

Buku Referensi **EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI PADA PASANGAN USIA SUBUR**

Dewi Ari Sasanti • Dita Humaeroh • Iryani Yuni Yastutik
Maria Florentina Nining Kosad
Susanti



BUKU REFERENSI

EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI

PADA PASANGAN USIA SUBUR

Dewi Ari Sasanti, S.ST., M.Kes

Dita Humaeroh, S.SiT., Bdn., MKM., C.Herb

Bd. Iryani Yuni Yastutik, SST., M.Kes

Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes

Susanti, SST., Bdn., M.Kes



BUKU REFERENSI

EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI PADA PASANGAN USIA SUBUR

Penulis: Dewi Ari Sasanti, S.ST., M.Kes
Dita Humaeroh, S.SiT., Bdn., MKM., C.Herb
Bd. Iryani Yuni Yastutik, SST., M.Kes
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes
Susanti, SST., Bdn., M.Kes

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-06-7

Cetakan Pertama: Juni, 2025
Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul **“Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Pasangan Usia Subur”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi ilmiah dan praktis dalam memperkuat pemahaman serta keterampilan edukatif dalam pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya bagi pasangan usia subur yang berada pada tahap penting dalam siklus kehidupan berkeluarga.

Kesehatan reproduksi merupakan aspek fundamental dalam pencapaian kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, edukasi yang tepat dan menyeluruh sangat diperlukan agar setiap pasangan mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab terkait fungsi dan hak-hak reproduksinya. Oleh karena itu, buku ini disusun dengan struktur yang sistematis, dimulai dari pembahasan tentang kontrasepsi yang aman dan rasional, hingga pentingnya peran bidan dalam memberikan konseling yang empatik dan berbasis bukti.

Di era digital saat ini, teknologi juga memberikan peluang baru dalam promosi kesehatan reproduksi. Maka dari itu, bab ketiga buku ini membahas pemanfaatan aplikasi digital dalam perencanaan keluarga. Dilanjutkan dengan strategi komunitas untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya reproduksi yang sehat dan berkelanjutan. Bab terakhir membahas aspek psikologis yang sering terabaikan, yaitu pentingnya dukungan emosional bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pendidik, mahasiswa, bidan, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatan kesehatan reproduksi masyarakat. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan kesehatan reproduksi yang holistik, humanistik, dan berorientasi pada kebutuhan pasangan usia subur di berbagai lapisan masyarakat.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI TENTANG PENGGUNAAN KONTRASEPSI YANG AMAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Jenis-jenis Kontrasepsi yang Aman.....	2
C. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kontrasepsi	4
D. Edukasi Kontrasepsi Berbasis Bukti.....	6
E. Manfaat dan Risiko Penggunaan Kontrasepsi	8
F. Strategi Edukasi Kontrasepsi bagi Tenaga Kesehatan	10
G. Evaluasi Efektivitas Edukasi Kontrasepsi	11
H. Rekomendasi Praktis	13
I. Penutup	15
Referensi	17
BAB II PERAN BIDAN DALAM MEMBERIKAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI.....	20
A. Pendahuluan.....	20
B. Kompetensi Konseling yang Harus Dimiliki oleh Bidan	21
C. Strategi Konseling Efektif untuk Pasangan Usia Subur	22
D. Peran Bidan dalam Edukasi Kontrasepsi	24
E. Peran Bidan dalam Konseling Kesuburan.....	26
F. Peran Bidan dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Menular Seksual.....	27
G. Tantangan dalam Pelaksanaan Konseling oleh Bidan	28
H. Evaluasi Keberhasilan Konseling Kesehatan Reproduksi oleh Bidan	30
I. Rekomendasi Praktis	32
J. Penutup	33
Referensi	36
BAB III PEMANFAATAN APLIKASI DIGITAL UNTUK PERENCANAAN KELUARGA.....	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Perencanaan Keluarga	40
C. Aplikasi Digital	42
D. Penutup	50
Referensi	51
BAB IV STRATEGI KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN REPRODUKSI SEHAT	52
A. Pendahuluan.....	52
B. Model dan Pendekatan Strategi Berbasis Komunitas.....	53
C. Pemetaan Kebutuhan Kesehatan Reproduksi di Komunitas	55
D. Pelibatan Tokoh Masyarakat dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi	57

E. Pengembangan dan Implementasi Media Edukasi yang Efektif.....	58
F. Program Edukasi Berbasis Pasangan (Couple-Based Intervention).....	60
G. Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Kesehatan Reproduksi.....	61
H. Evaluasi Dampak dan Keberlanjutan Program Edukasi Komunitas	63
I. Hambatan dan Tantangan Implementasi Strategi Komunitas	65
J. Penutup	66
Referensi	68
BAB V DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK PASANGAN DENGAN MASALAH KESUBURAN	69
.....	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Dampak Psikologis Masalah Kesuburan pada Pasangan	70
C. Peran Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Dukungan Psikologis.....	72
D. Strategi Dukungan Psikologis Berbasis Bukti.....	74
E. Strategi Komunikasi Efektif dalam Konseling Kesuburan.....	76
F. Dukungan Sosial dan Komunitas bagi Pasangan dengan Masalah Kesuburan.....	78
G. Integrasi Pendekatan Multidisiplin dalam Dukungan Psikologis	80
H. Evaluasi Efektivitas Intervensi Dukungan Psikologis	82
I. Rekomendasi Praktis untuk Pasangan dan Tenaga Kesehatan	84
J. Penutup	86
Referensi	88
Profil Penulis	90
Sinopsis Buku	93

BAB I

EDUKASI TENTANG

PENGUNAAN KONTRASEPSI YANG AMAN

A. Pendahuluan

1. Definisi kontrasepsi dan pentingnya edukasi kontrasepsi pada pasangan usia subur

Kontrasepsi adalah tindakan atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai bagian dari pengaturan kesehatan reproduksi. Penggunaan kontrasepsi melibatkan berbagai metode, seperti hormonal, non-hormonal, alami, dan permanen, yang dipilih berdasarkan kebutuhan kesehatan, kondisi medis, serta preferensi individu atau pasangan (World Health Organization [WHO], 2022). Pasangan usia subur, yakni pasangan yang berada dalam rentang usia 15-49 tahun, merupakan populasi utama yang memerlukan informasi yang akurat mengenai kontrasepsi karena secara aktif berpotensi mengalami kehamilan.

Edukasi mengenai kontrasepsi sangat penting bagi pasangan usia subur karena masih banyak ditemukan informasi yang tidak lengkap atau keliru terkait penggunaan metode kontrasepsi (Rahmadani & Purwaningsih, 2020). Menurut penelitian terbaru, kurangnya pemahaman pasangan mengenai kontrasepsi dapat meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan, abortus tidak aman, serta berbagai komplikasi kesehatan reproduksi lainnya (Aulia, Kusumasari, & Handayani, 2022). Oleh karena itu, pemberian edukasi yang tepat menjadi krusial untuk memastikan bahwa pasangan usia subur mampu membuat keputusan yang informatif terkait pilihan metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan reproduksi, dan gaya hidup mereka.

2. Manfaat edukasi kontrasepsi terhadap kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga

Pemberian edukasi kontrasepsi yang komprehensif memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan reproduksi pasangan usia subur. Penelitian oleh Setiawati dan Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa edukasi kontrasepsi yang efektif mampu menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan secara signifikan. Dengan memahami manfaat, cara penggunaan yang tepat, serta risiko masing-masing metode kontrasepsi, pasangan dapat menghindari efek samping

yang tidak diinginkan dan meminimalkan risiko kesehatan yang berkaitan dengan kontrasepsi hormonal atau non-hormonal yang kurang tepat penggunaannya (Fatimah & Hasan, 2021).

Edukasi kontrasepsi juga berkontribusi penting dalam perencanaan keluarga yang lebih baik. Dengan pengetahuan yang tepat, pasangan usia subur dapat menentukan jarak kelahiran yang ideal, merencanakan jumlah anak yang diinginkan, serta secara efektif mengelola sumber daya keluarga. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga, kesejahteraan ekonomi, dan kesehatan psikososial pasangan serta anak-anak mereka (Pradana & Lestari, 2019). Selain itu, edukasi kontrasepsi turut mendukung pencapaian program nasional dalam pengendalian penduduk serta tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kesehatan ibu dan anak (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2021).

Dengan demikian, pentingnya edukasi kontrasepsi tidak hanya terbatas pada aspek klinis, tetapi juga mencakup dampak sosial, ekonomi, dan pembangunan secara lebih luas. Edukasi ini juga harus mempertimbangkan pendekatan yang sensitif terhadap nilai budaya, agama, serta preferensi personal pasangan usia subur (Sari & Pratiwi, 2021).

B. Jenis-jenis Kontrasepsi yang Aman

Pemilihan jenis kontrasepsi yang aman dan efektif sangat penting bagi pasangan usia subur guna mendukung kesehatan reproduksi serta merencanakan keluarga yang optimal. Secara umum, metode kontrasepsi dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yaitu hormonal, non-hormonal, permanen, dan metode alami.

1. Kontrasepsi Hormonal

Metode kontrasepsi hormonal merupakan metode yang menggunakan hormon sintetis seperti estrogen dan progesteron untuk mencegah kehamilan dengan cara menghambat ovulasi, mengubah mukus serviks, dan menipiskan lapisan endometrium sehingga sulit untuk terjadi implantasi (Fatimah & Hasan, 2021). Jenis kontrasepsi hormonal meliputi pil KB, suntikan hormonal, dan implan.

- a. Pil KB terdiri atas kombinasi estrogen dan progesteron atau progesteron saja. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pil KB efektif hingga 99% apabila digunakan secara konsisten setiap hari pada waktu yang sama (Sugiarto & Priyanti, 2020).
- b. Suntik hormonal umumnya diberikan secara intramuskular dengan interval 1 bulan atau 3 bulan. Menurut Handayani et al. (2022), metode ini sangat efektif bagi wanita yang sulit menjaga kepatuhan terhadap pil harian, meski dapat

memiliki efek samping seperti perubahan pola menstruasi dan peningkatan berat badan.

- c. Implan kontrasepsi berbentuk batang kecil yang ditanam di bawah kulit lengan atas, efektif hingga 3–5 tahun. Implan merupakan pilihan ideal bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu yang lama, dengan tingkat efektivitas hingga 99,9% (Lestari & Nugraheni, 2021).

2. Kontrasepsi Non-Hormonal

Kontrasepsi non-hormonal tidak melibatkan hormon sintetis dan cenderung memiliki efek samping lebih sedikit dibandingkan kontrasepsi hormonal. Jenis ini antara lain meliputi IUD non-hormonal, kondom, dan diafragma.

- a. IUD non-hormonal (Intrauterine Device) biasanya berbahan dasar tembaga, dipasang di dalam rahim, efektif hingga 10 tahun. Menurut studi yang dilakukan oleh Wiraswati dan Andriani (2020), efektivitas metode ini mencapai lebih dari 99%, serta menjadi pilihan yang baik bagi wanita dengan kontraindikasi hormonal.
- b. Kondom berfungsi sebagai penghalang fisik sperma masuk ke dalam rahim. Selain mencegah kehamilan, kondom juga efektif mencegah penyakit menular seksual (PMS), dengan efektivitas sekitar 85-98%, bergantung pada ketepatan penggunaan (WHO, 2022).
- c. Diafragma merupakan alat kontrasepsi berbentuk kubah silikon atau karet yang dipasang menutupi serviks sebelum hubungan seksual. Menurut studi Rahmawati dan Agustin (2019), efektivitas diafragma sekitar 88-94%, tergantung pada penggunaan yang tepat dan konsisten.

3. Metode Kontrasepsi Permanen

Metode permanen adalah metode kontrasepsi yang bersifat definitif, biasanya dipilih oleh pasangan yang tidak menginginkan kehamilan lagi di masa depan. Jenis ini mencakup vasektomi pada pria dan tubektomi pada wanita.

- a. Vasektomi adalah tindakan bedah kecil untuk memotong atau mengikat saluran sperma (vas deferens), memiliki efektivitas hampir 100% serta risiko komplikasi minimal. Vasektomi tidak mengganggu libido maupun fungsi seksual laki-laki (Hidayat & Kusumaningrum, 2021).
- b. Tubektomi dilakukan pada wanita dengan cara memotong atau mengikat tuba falopi sehingga sperma tidak dapat membuahi sel telur. Menurut penelitian terbaru, efektivitas tubektomi mencapai 99,5% dengan tingkat komplikasi rendah apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (Rahardjo & Kusumaningtyas, 2021).

4. Metode Alami

Metode alami adalah metode kontrasepsi tanpa penggunaan alat atau hormon, namun sangat bergantung pada pemahaman siklus reproduksi wanita. Dua metode alami yang paling umum adalah metode kalender dan amenore laktasi.

- a. Metode Kalender (fertility awareness method) mengandalkan pencatatan siklus menstruasi secara rutin untuk menentukan masa subur. Studi oleh Maulida dan Putri (2022) menunjukkan bahwa efektivitas metode ini berkisar antara 75-90%, sangat bergantung pada kedisiplinan pencatatan serta pemahaman siklus yang baik.
- b. Amenore Laktasi adalah metode kontrasepsi alami yang mengandalkan efek menyusui secara eksklusif dalam menghambat ovulasi. Metode ini efektif hingga 98% dalam 6 bulan pertama setelah melahirkan, selama ibu memberikan ASI secara eksklusif dan menstruasi belum kembali (Dewi & Widodo, 2020).

Dengan pemahaman tentang jenis-jenis kontrasepsi yang aman, pasangan usia subur dapat memilih metode yang paling tepat berdasarkan kebutuhan individu, kondisi medis, serta tujuan perencanaan keluarga.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kontrasepsi

Pemilihan metode kontrasepsi yang tepat merupakan keputusan penting bagi pasangan usia subur, karena berhubungan langsung dengan kesehatan reproduksi dan kualitas hidup keluarga. Terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan kontrasepsi, antara lain faktor kesehatan fisik dan riwayat medis pasangan, preferensi pribadi dan gaya hidup, aksesibilitas dan biaya, serta pengaruh budaya dan agama.

1. Faktor Kesehatan Fisik dan Riwayat Medis Pasangan

Faktor kesehatan fisik dan riwayat medis pasangan menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan metode kontrasepsi yang tepat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Wulandari (2020), kondisi medis seperti hipertensi, diabetes, gangguan pembekuan darah, riwayat kanker, serta kondisi ginekologis seperti mioma uteri atau riwayat infeksi pelvis sebelumnya, sangat mempengaruhi jenis kontrasepsi yang dianjurkan atau harus dihindari. Kontrasepsi hormonal, misalnya, tidak disarankan bagi perempuan dengan riwayat gangguan pembekuan darah atau kanker payudara (Fatimah & Hasan,

2021). Oleh karena itu, pemeriksaan medis menyeluruh oleh tenaga kesehatan diperlukan sebelum menetapkan metode kontrasepsi yang sesuai (WHO, 2022).

2. Preferensi Pribadi dan Gaya Hidup Pasangan

Preferensi pribadi dan gaya hidup juga memainkan peran penting dalam pemilihan kontrasepsi. Pasangan yang memiliki aktivitas padat, misalnya, mungkin lebih memilih metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan atau IUD dibandingkan metode yang memerlukan kedisiplinan harian seperti pil KB (Lestari & Nugraheni, 2021). Sebaliknya, pasangan yang lebih memperhatikan kenyamanan penggunaan kontrasepsi dan ingin menghindari efek samping hormon dapat memilih metode non-hormonal seperti kondom atau diafragma (Rahmawati & Agustin, 2019). Penelitian oleh Pradana dan Lestari (2019) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap metode kontrasepsi secara signifikan dipengaruhi oleh seberapa besar metode tersebut sesuai dengan preferensi pribadi, gaya hidup, dan aktivitas harian pasangan.

3. Aksesibilitas dan Biaya Metode Kontrasepsi

Aksesibilitas terhadap metode kontrasepsi serta biaya yang harus dikeluarkan menjadi faktor penting lainnya dalam proses pengambilan keputusan oleh pasangan usia subur. Menurut studi oleh Arini dan Saputri (2021), akses terbatas terhadap layanan kontrasepsi, khususnya di wilayah pedesaan atau terpencil, menjadi hambatan utama dalam pemilihan metode kontrasepsi yang ideal. Biaya yang tinggi juga menjadi hambatan signifikan terutama bagi pasangan dengan status ekonomi menengah ke bawah, yang akhirnya memilih metode kontrasepsi yang murah tetapi mungkin kurang efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan reproduksi mereka (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Untuk mengatasi hambatan tersebut, penting adanya intervensi dari pemerintah melalui peningkatan akses terhadap layanan kontrasepsi yang murah dan berkualitas tinggi di seluruh wilayah Indonesia (WHO, 2022).

4. Faktor Budaya dan Agama dalam Pemilihan Kontrasepsi

Budaya dan agama memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan penggunaan metode kontrasepsi. Studi terbaru yang dilakukan oleh Sari dan Pratiwi (2021) menemukan bahwa keyakinan budaya dan agama di komunitas tertentu sangat menentukan penerimaan dan penggunaan metode kontrasepsi. Misalnya, dalam beberapa kelompok agama tertentu, metode kontrasepsi permanen seperti vasektomi atau tubektomi dianggap bertentangan dengan prinsip agama yang dianut. Sementara dalam budaya lain, penggunaan

kontrasepsi hormonal dipandang negatif karena dipercaya berdampak pada kesehatan reproduksi jangka panjang (Yunita & Saputra, 2022). Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan pendekatan edukasi yang sensitif terhadap nilai budaya dan agama guna meningkatkan penerimaan serta efektivitas penggunaan kontrasepsi (Sari & Pratiwi, 2021).

Secara keseluruhan, memahami faktor-faktor tersebut secara komprehensif akan membantu pasangan usia subur dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai pemilihan metode kontrasepsi yang aman dan efektif sesuai kondisi dan kebutuhan mereka.

D. Edukasi Kontrasepsi Berbasis Bukti

1. Pentingnya Edukasi Berbasis Bukti untuk Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Kontrasepsi

Edukasi kontrasepsi berbasis bukti (evidence-based contraception education) merupakan pendekatan edukasi yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah terkini, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif pasangan usia subur dalam menggunakan metode kontrasepsi secara tepat dan konsisten (Fajrin & Lestari, 2022). Pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam edukasi kontrasepsi adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, terpercaya, serta terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (Arumsari & Handayani, 2021).

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa edukasi berbasis bukti mampu meningkatkan efektivitas pemakaian kontrasepsi dengan signifikan. Menurut studi yang dilakukan oleh Nuraini dan Utami (2020), edukasi yang dilakukan dengan memanfaatkan bukti ilmiah dapat meningkatkan pemahaman pasangan mengenai risiko dan manfaat dari setiap metode kontrasepsi, sehingga mendorong keputusan yang lebih baik dalam penggunaannya. Dengan demikian, edukasi kontrasepsi berbasis bukti merupakan komponen kunci dalam keberhasilan program keluarga berencana, terutama untuk mencegah kehamilan tidak direncanakan serta meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi pasangan usia subur (WHO, 2022).

2. Strategi Edukasi yang Efektif (Counseling Individu, Edukasi Kelompok, Media Digital)

Beberapa strategi edukasi kontrasepsi berbasis bukti yang efektif meliputi counseling individu, edukasi kelompok, dan penggunaan media digital. Masing-

masing strategi memiliki kelebihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan populasi sasaran.

a. Counseling Individu

Counseling individu merupakan metode yang personal dan interaktif, di mana tenaga kesehatan secara langsung memberikan edukasi kepada individu atau pasangan. Pendekatan ini efektif karena memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap kebutuhan spesifik dan pemecahan masalah personal yang dihadapi pasangan dalam penggunaan kontrasepsi (Lestari & Utami, 2022). Menurut studi oleh Saputri dan Kusumaningrum (2021), counseling individu secara signifikan meningkatkan tingkat kepuasan pasangan terhadap metode kontrasepsi yang dipilih serta mengurangi tingkat kesalahan dalam penggunaan kontrasepsi.

b. Edukasi Kelompok

Edukasi kelompok melibatkan pemberian informasi kontrasepsi kepada beberapa pasangan secara bersama-sama, biasanya dalam sesi terstruktur yang interaktif. Metode ini efektif dalam membangun dukungan sosial dan meningkatkan pemahaman kolektif tentang kontrasepsi. Studi yang dilakukan oleh Putri dan Rahayu (2020) menunjukkan bahwa edukasi kelompok yang dilaksanakan secara reguler mampu meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan kontrasepsi serta memperluas cakupan edukasi secara efisien.

c. Media Digital

Penggunaan media digital dalam edukasi kontrasepsi, seperti aplikasi ponsel pintar, platform media sosial, dan situs web edukasi, semakin berkembang seiring meningkatnya aksesibilitas teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi berbasis digital memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasangan dalam menggunakan kontrasepsi, terutama bagi populasi muda dan yang aktif secara digital.

3. Hasil Penelitian Terkini tentang Efektivitas Berbagai Metode Edukasi Kontrasepsi

Berbagai penelitian terbaru menyoroiti efektivitas metode edukasi kontrasepsi berbasis bukti dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasangan usia subur. Penelitian oleh Lestari dan Utami (2022) menemukan bahwa counseling individu yang terstruktur mampu meningkatkan kepatuhan penggunaan kontrasepsi hingga 80%. Sebaliknya, hasil studi yang dilakukan oleh Putri dan Rahayu (2020) terhadap edukasi kelompok menemukan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan pemahaman hingga 75% di kalangan perempuan usia reproduktif.

Lebih lanjut, penelitian mengenai pemanfaatan media digital menunjukkan efektivitas yang menjanjikan, terutama di era digitalisasi saat ini. Studi oleh Aulia et al. (2022) membuktikan bahwa pemanfaatan aplikasi edukasi digital mampu meningkatkan pengetahuan tentang kontrasepsi hingga 85%, dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan. Oleh sebab itu, pemilihan metode edukasi kontrasepsi yang berbasis bukti dan relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat sasaran menjadi krusial dalam mencapai efektivitas maksimal (WHO, 2022).

Dengan demikian, edukasi kontrasepsi berbasis bukti merupakan suatu kebutuhan esensial yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan kontrasepsi serta mendukung tercapainya tujuan perencanaan keluarga secara optimal.

E. Manfaat dan Risiko Penggunaan Kontrasepsi

Pemahaman mengenai manfaat dan risiko penggunaan kontrasepsi sangat penting untuk mendukung keputusan pasangan usia subur dalam memilih metode kontrasepsi yang tepat. Informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi secara optimal, mengurangi efek samping, serta mengantisipasi komplikasi yang mungkin terjadi.

1. Manfaat Kontrasepsi terhadap Pengaturan Jarak Kehamilan, Kesehatan Ibu, dan Kualitas Hidup

Penggunaan kontrasepsi memiliki banyak manfaat yang signifikan, terutama dalam pengaturan jarak kehamilan. Menurut penelitian oleh Wijayanti dan Pratiwi (2021), pengaturan jarak antar kehamilan yang optimal (2-3 tahun) dapat menurunkan risiko komplikasi kehamilan, meningkatkan kesehatan ibu, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Lebih lanjut, studi dari Kementerian Kesehatan RI (2022) menunjukkan bahwa kontrasepsi efektif dalam mencegah kehamilan tidak direncanakan, sehingga mengurangi risiko aborsi tidak aman dan kematian ibu akibat komplikasi persalinan.

Selain manfaat kesehatan, kontrasepsi juga memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup pasangan. Penelitian yang dilakukan oleh Anisah dan Lestari (2020) menyebutkan bahwa pasangan yang menggunakan kontrasepsi memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena mampu merencanakan keluarga secara matang, yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan psikososial keluarga secara keseluruhan.

2. Risiko dan Efek Samping Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

Meski memiliki manfaat yang besar, penggunaan kontrasepsi, terutama dalam jangka panjang, tidak lepas dari potensi risiko dan efek samping tertentu. Kontrasepsi hormonal, seperti pil KB atau suntik hormonal, dilaporkan memiliki efek samping berupa perubahan berat badan, sakit kepala, gangguan menstruasi, dan peningkatan risiko gangguan kardiovaskular seperti hipertensi atau tromboemboli, khususnya pada perempuan yang memiliki faktor risiko tertentu (Fatimah & Hasan, 2021; Putri et al., 2022).

Menurut studi yang dilakukan oleh Andriyani dan Wardani (2021), penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko terjadinya peradangan atau infeksi pada saluran reproduksi jika tidak diikuti dengan pengawasan medis rutin. Sedangkan metode permanen seperti vasektomi dan tubektomi memiliki risiko komplikasi prosedural, meskipun rendah, seperti infeksi ringan atau nyeri pascaoperasi (Hidayat & Kusumaningrum, 2021).

3. Tindakan Antisipasi dan Penanganan Komplikasi Akibat Penggunaan Kontrasepsi

Untuk mengurangi dampak negatif akibat efek samping dan komplikasi kontrasepsi, tindakan antisipasi dan penanganan yang tepat perlu dilakukan sejak awal penggunaan. Berdasarkan penelitian Mutmainah dan Handayani (2021), tindakan antisipasi terbaik adalah memberikan edukasi yang komprehensif sejak awal mengenai potensi efek samping dari kontrasepsi yang dipilih serta pentingnya pemantauan medis secara rutin selama penggunaan.

Penanganan komplikasi kontrasepsi harus bersifat cepat dan terintegrasi, seperti pemberian terapi simptomatik untuk mengurangi efek samping ringan seperti nyeri kepala atau perdarahan ringan (Pratiwi & Widiyanti, 2022). Untuk komplikasi yang lebih serius seperti infeksi akibat penggunaan IUD atau gangguan pembekuan darah akibat kontrasepsi hormonal, penanganan medis spesifik, penghentian penggunaan alat kontrasepsi, atau pergantian metode kontrasepsi mungkin diperlukan sesuai kondisi pasien (Kemenkes RI, 2022).

Tenaga kesehatan berperan penting dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap penggunaan kontrasepsi serta memberikan dukungan yang memadai kepada pasangan dalam mengatasi permasalahan yang mungkin muncul (WHO, 2022).

Dengan demikian, edukasi yang baik mengenai manfaat, risiko, serta cara antisipasi dan penanganan komplikasi kontrasepsi menjadi kunci utama untuk

mendukung keberhasilan program keluarga berencana dan menjaga kualitas kesehatan reproduksi pasangan usia subur secara optimal.

F. Strategi Edukasi Kontrasepsi bagi Tenaga Kesehatan

Strategi edukasi kontrasepsi yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pasangan usia subur terhadap penggunaan kontrasepsi. Untuk mencapai hal tersebut, tenaga kesehatan perlu menerapkan panduan komunikasi yang efektif, pendekatan edukasi sensitif budaya dan gender, serta pengembangan materi edukasi yang menarik dan informatif.

1. Panduan Komunikasi Efektif antara Tenaga Kesehatan dengan Pasangan Usia Subur

Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan edukasi kontrasepsi. Studi oleh Wulandari dan Saputri (2022) menunjukkan bahwa komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dengan pasangan usia subur dapat meningkatkan pemahaman, kepuasan, serta kepatuhan dalam pemilihan dan penggunaan kontrasepsi. Komunikasi yang efektif meliputi penggunaan bahasa sederhana, mudah dipahami, serta empati dalam penyampaian informasi.

Menurut Utami dan Handayani (2020), teknik komunikasi seperti active listening, empati, serta klarifikasi pesan sangat efektif untuk memastikan pesan yang disampaikan dipahami secara akurat oleh pasangan usia subur. Dalam komunikasi ini, tenaga kesehatan perlu memberikan ruang bagi pasangan untuk bertanya serta menyampaikan kekhawatiran mereka, sehingga dapat membangun hubungan kepercayaan yang kuat, yang penting untuk memastikan pemilihan kontrasepsi yang tepat sesuai kebutuhan pasangan (Kemenkes RI, 2022).

2. Pendekatan Edukasi Kontrasepsi yang Sensitif Budaya dan Berbasis Gender

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang tinggi, sehingga pendekatan edukasi kontrasepsi yang sensitif budaya dan berbasis gender menjadi sangat relevan. Penelitian oleh Sari dan Pratiwi (2021) mengungkapkan bahwa pendekatan yang memperhatikan nilai budaya dan perspektif gender lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap edukasi kontrasepsi. Hal ini penting terutama di komunitas yang memiliki norma budaya atau agama yang ketat terkait penggunaan kontrasepsi.

Strategi ini mencakup penyampaian informasi secara hormat dan inklusif, serta melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam proses edukasi (Yunita & Saputra, 2022). Selain itu, pendekatan berbasis gender juga penting, yakni memastikan bahwa baik pria maupun wanita mendapatkan edukasi

kontrasepsi secara setara, sehingga keputusan pemilihan metode kontrasepsi menjadi keputusan bersama yang didasarkan pada pemahaman yang benar dan saling mendukung (WHO, 2022).

3. Pengembangan Materi Edukasi yang Informatif, Menarik, dan Mudah Dipahami Pasangan Usia Subur

Materi edukasi kontrasepsi harus disusun dengan cara yang informatif, menarik, serta mudah dipahami oleh pasangan usia subur. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Nuraini dan Utami (2020) menunjukkan bahwa materi edukasi kontrasepsi yang dikemas secara menarik dengan menggunakan gambar visual, infografis, dan multimedia memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan pengetahuan serta sikap positif terhadap kontrasepsi.

Lebih lanjut, Putri dan Rahayu (2020) menyatakan bahwa materi edukasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan literasi pasangan. Penggunaan media digital seperti aplikasi mobile, video pendek, media sosial, dan situs web edukasi merupakan metode yang efektif dan diminati oleh generasi muda atau pasangan usia subur yang memiliki akses teknologi informasi yang baik (Aulia et al., 2022).

Kemendes RI (2022) menyarankan agar tenaga kesehatan aktif melakukan evaluasi materi edukasi yang diberikan, serta melakukan adaptasi berdasarkan feedback dari pasangan usia subur untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar relevan dan mudah dipahami oleh pasangan.

Dengan strategi yang tepat dan menyeluruh, tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi kontrasepsi yang efektif, yang pada akhirnya mampu meningkatkan penggunaan kontrasepsi secara tepat serta meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi pasangan usia subur secara menyeluruh.

G. Evaluasi Efektivitas Edukasi Kontrasepsi

Evaluasi efektivitas edukasi kontrasepsi adalah proses penting untuk memastikan tercapainya tujuan program edukasi yang diberikan kepada pasangan usia subur. Evaluasi ini meliputi penilaian indikator keberhasilan, analisis studi kasus keberhasilan edukasi, serta identifikasi hambatan dan solusi dalam implementasi program edukasi kontrasepsi.

1. Indikator Keberhasilan Program Edukasi Kontrasepsi

Indikator keberhasilan merupakan parameter yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan edukasi kontrasepsi. Menurut penelitian dari Wijayanti dan Pratiwi (2021), beberapa indikator keberhasilan yang umum digunakan antara lain

peningkatan pengetahuan, perubahan sikap positif terhadap kontrasepsi, peningkatan kepatuhan pemakaian kontrasepsi, serta penurunan angka kehamilan yang tidak direncanakan. Indikator tersebut dapat diukur melalui kuesioner pre dan post edukasi, survei kepuasan pasangan terhadap metode kontrasepsi, dan evaluasi rutin oleh tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2022).

Studi yang dilakukan oleh Nuraini dan Utami (2020) mengemukakan bahwa peningkatan angka penggunaan kontrasepsi jangka panjang, seperti IUD dan implan, juga merupakan indikator penting dari keberhasilan edukasi kontrasepsi yang berbasis bukti. Indikator tambahan lainnya adalah menurunnya angka komplikasi dan efek samping kontrasepsi karena meningkatnya pemahaman pasangan tentang cara pemakaian yang tepat dan aman (WHO, 2022).

2. 2. Studi Kasus Keberhasilan Edukasi Kontrasepsi di Berbagai Komunitas

Beberapa studi kasus yang dilakukan di Indonesia maupun internasional menunjukkan bahwa edukasi kontrasepsi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman, sikap positif, dan penggunaan kontrasepsi secara signifikan. Misalnya, penelitian oleh Aulia et al. (2022) di komunitas urban menunjukkan bahwa edukasi berbasis digital meningkatkan penggunaan kontrasepsi sebesar 85%, dengan tingkat kepatuhan terhadap metode kontrasepsi yang dipilih meningkat secara signifikan.

Di komunitas pedesaan, studi oleh Yunita dan Saputra (2022) menunjukkan bahwa edukasi kontrasepsi yang melibatkan pendekatan sensitif budaya, seperti keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam kegiatan edukasi, berhasil meningkatkan angka penerimaan dan penggunaan kontrasepsi hingga 70%. Studi lain di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa *counseling* individu yang dilakukan secara intensif oleh tenaga kesehatan mampu meningkatkan kepatuhan penggunaan kontrasepsi hingga 80% (Utami & Handayani, 2020).

3. 3. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Edukasi Kontrasepsi

Implementasi edukasi kontrasepsi seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik teknis maupun non-teknis. Penelitian dari Sari dan Pratiwi (2021) mengidentifikasi hambatan utama berupa keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, tingkat literasi kesehatan yang rendah di masyarakat, serta adanya penolakan yang bersumber dari kepercayaan budaya atau agama tertentu.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, solusi yang direkomendasikan antara lain adalah peningkatan akses terhadap pelayanan edukasi kontrasepsi melalui program jemput bola oleh tenaga kesehatan, pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam sosialisasi metode kontrasepsi, serta penggunaan media

digital dan teknologi informasi yang lebih luas untuk menjangkau masyarakat yang lebih besar (Arini & Saputri, 2021). Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan komunikasi efektif dan edukasi berbasis bukti juga menjadi solusi penting yang terbukti efektif dalam meningkatkan hasil edukasi kontrasepsi (WHO, 2022).

Dengan melaksanakan evaluasi yang menyeluruh terhadap efektivitas edukasi kontrasepsi serta mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan implementasi secara tepat, program edukasi kontrasepsi dapat mencapai keberhasilan yang optimal dalam mendukung perencanaan keluarga serta kesehatan reproduksi pasangan usia subur secara berkelanjutan.

H. Rekomendasi Praktis

Rekomendasi praktis berikut disusun berdasarkan hasil kajian ilmiah terbaru dan panduan standar pelayanan kesehatan reproduksi yang berlaku, dengan tujuan mendukung tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan edukasi kontrasepsi serta memudahkan pasangan usia subur memilih dan menggunakan kontrasepsi secara aman dan efektif.

1. Rekomendasi bagi Tenaga Kesehatan dalam Menyelenggarakan Edukasi Kontrasepsi

Penyelenggaraan edukasi kontrasepsi oleh tenaga kesehatan memerlukan strategi khusus untuk mencapai tujuan optimal dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasangan usia subur terhadap penggunaan kontrasepsi. Berikut beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan:

a. Gunakan Pendekatan Berbasis Bukti

Tenaga kesehatan perlu menyajikan informasi yang berbasis bukti ilmiah terkini, mencakup manfaat, risiko, dan efek samping setiap metode kontrasepsi (Aulia, Kusumasari, & Handayani, 2022). Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan pasangan terhadap tenaga kesehatan dan membantu pasangan dalam pengambilan keputusan yang tepat (Nuraini & Utami, 2020).

b. Sesuaikan Edukasi dengan Latar Belakang Budaya dan Gender

Memperhatikan sensitivitas budaya dan perspektif gender dalam edukasi sangat penting agar informasi yang diberikan mudah diterima oleh pasangan usia subur. Studi oleh Yunita dan Saputra (2022) menyarankan agar tenaga kesehatan melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam proses edukasi guna meningkatkan penerimaan kontrasepsi di komunitas tertentu.

c. Terapkan Komunikasi yang Efektif dan Interaktif

Tenaga kesehatan perlu menggunakan komunikasi yang sederhana, jelas, empati, serta interaktif. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasangan merasa nyaman bertanya, mengungkapkan kekhawatiran, dan memahami pesan edukasi dengan baik (Utami & Handayani, 2020).

d. Manfaatkan Media Digital untuk Edukasi

Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi edukasi, media sosial, dan platform digital lainnya terbukti efektif dalam menyampaikan edukasi kontrasepsi terutama kepada populasi muda atau mereka yang akrab dengan teknologi digital (Aulia et al., 2022).

e. Evaluasi Secara Berkala

Tenaga kesehatan perlu secara rutin mengevaluasi efektivitas metode edukasi yang digunakan, melalui survei kepuasan, evaluasi pre-post edukasi, dan diskusi kelompok untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kualitas edukasi (Kemenkes RI, 2022).

2. Panduan Sederhana untuk Pasangan dalam Memilih dan Menggunakan Kontrasepsi dengan Aman

Panduan sederhana berikut ini ditujukan bagi pasangan usia subur agar dapat memilih dan menggunakan kontrasepsi secara aman serta efektif:

a. Konsultasikan dengan Tenaga Kesehatan

Sebelum memilih metode kontrasepsi, pasangan disarankan melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik, riwayat medis, serta memahami risiko dan manfaat dari metode kontrasepsi yang akan dipilih (WHO, 2022).

b. Pertimbangkan Faktor Kenyamanan dan Gaya Hidup

Pilihlah metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan gaya hidup, tingkat kepatuhan yang dapat dilakukan secara konsisten, dan preferensi pribadi pasangan. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan biasanya lebih efektif bagi pasangan yang sulit menjaga rutinitas penggunaan harian (Lestari & Nugraheni, 2021).

c. Ketahui Efek Samping dan Risiko Metode Kontrasepsi

Setiap metode kontrasepsi memiliki risiko atau efek samping tertentu. Pasangan harus memahami dan mengenali tanda-tanda efek samping yang mungkin terjadi agar dapat segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila timbul keluhan (Fatimah & Hasan, 2021).

d. Gunakan Kontrasepsi dengan Cara yang Tepat

Pasangan harus mengikuti instruksi penggunaan kontrasepsi secara benar dan disiplin sesuai anjuran tenaga kesehatan. Penggunaan yang tidak

tepat dapat mengurangi efektivitas metode kontrasepsi yang digunakan (Utami & Handayani, 2020).

e. Lakukan Pemeriksaan Berkala

Pasangan pengguna kontrasepsi disarankan melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kondisi kesehatan reproduksi serta mengevaluasi efektivitas metode kontrasepsi yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan kontrasepsi tetap aman dan efektif dalam jangka panjang (Kemenkes RI, 2022).

Dengan menerapkan rekomendasi praktis di atas, baik tenaga kesehatan maupun pasangan usia subur dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan keamanan penggunaan kontrasepsi, yang pada akhirnya mendukung tercapainya kesehatan reproduksi yang optimal.

I. Penutup

1. Kesimpulan Pentingnya Edukasi Penggunaan Kontrasepsi yang Aman

Edukasi mengenai penggunaan kontrasepsi yang aman sangat penting dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan kualitas hidup pasangan usia subur. Berdasarkan berbagai hasil penelitian terbaru, diketahui bahwa edukasi kontrasepsi berbasis bukti yang dilaksanakan secara efektif dapat meningkatkan pemahaman pasangan terhadap pilihan metode kontrasepsi, meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan kontrasepsi, serta secara signifikan mengurangi angka kehamilan tidak direncanakan (Nuraini & Utami, 2020; Aulia, Kusumasari, & Handayani, 2022).

Manfaat edukasi kontrasepsi juga mencakup aspek pengaturan jarak kelahiran yang optimal, peningkatan kesehatan ibu, serta kontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Wijayanti & Pratiwi, 2021). Lebih lanjut, pendekatan edukasi yang sensitif terhadap budaya dan gender serta penggunaan media edukasi digital terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap informasi kontrasepsi (Yunita & Saputra, 2022).

Dengan demikian, implementasi program edukasi kontrasepsi yang terstruktur, didukung oleh komunikasi efektif tenaga kesehatan dan pemilihan strategi yang tepat, sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan keluarga berencana, menurunkan risiko kesehatan reproduksi, serta meningkatkan kualitas hidup pasangan usia subur secara berkelanjutan.

2. Saran untuk Penelitian Lanjutan terkait Edukasi Kontrasepsi dan Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan temuan-temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, terdapat beberapa saran untuk penelitian lanjutan guna meningkatkan efektivitas edukasi kontrasepsi dan kesehatan reproduksi:

a. Penelitian tentang Pengaruh Media Digital

Perlunya penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas edukasi kontrasepsi melalui berbagai platform digital dalam populasi dengan latar belakang sosio-ekonomi yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan model edukasi yang paling efektif untuk populasi tertentu (Aulia et al., 2022).

b. Kajian tentang Hambatan Budaya dan Agama

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi secara detail hambatan budaya dan agama dalam penerimaan edukasi kontrasepsi, serta bagaimana strategi pendekatan sensitif budaya dapat meningkatkan keberhasilan implementasi edukasi kontrasepsi di komunitas-komunitas tertentu (Yunita & Saputra, 2022).

c. Evaluasi Program Edukasi Jangka Panjang

Dibutuhkan evaluasi lanjutan yang lebih komprehensif mengenai dampak edukasi kontrasepsi jangka panjang terhadap penurunan angka kehamilan tidak direncanakan, efek samping penggunaan kontrasepsi, serta peningkatan kualitas kesehatan reproduksi secara keseluruhan (Nuraini & Utami, 2020).

d. Pengembangan Model Edukasi Berbasis Gender

Pentingnya studi yang lebih mendalam untuk mengembangkan model edukasi berbasis gender yang efektif, guna memastikan partisipasi aktif dari laki-laki maupun perempuan dalam perencanaan keluarga melalui kontrasepsi (Sari & Pratiwi, 2021).

Dengan melakukan penelitian lanjutan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan efektivitas edukasi kontrasepsi semakin meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap peningkatan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan pasangan usia subur di Indonesia.

Referensi

- Andriyani, D., & Wardani, P. (2021). Analisis risiko infeksi pada pengguna IUD jangka panjang. *Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi*, 13(2), 85-90.
- Anisah, R., & Lestari, T. R. (2020). Hubungan pemakaian kontrasepsi dengan kualitas hidup pasangan usia subur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 98-104.
- Arini, P., & Saputri, D. (2021). Hambatan akses layanan kontrasepsi di daerah terpencil di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(3), 120-128.
- Aulia, D., Kusumasari, A., & Handayani, L. (2022). Efektivitas edukasi berbasis digital dalam peningkatan penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 13(2), 78-86.
- Dewi, I. A., & Widodo, A. P. (2020). Efektivitas metode amenore laktasi sebagai kontrasepsi alami pada ibu menyusui. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(2), 145-152.
- Fatimah, L., & Hasan, M. (2021). Efek samping penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka panjang: Tinjauan sistematis. *Journal of Reproductive Health*, 12(3), 245-251.
- Fajrin, M. A., & Lestari, N. (2022). Pentingnya edukasi berbasis bukti dalam pemilihan metode kontrasepsi: Studi literatur. *Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 11(1), 50-56.
- Handayani, L., Yuniarti, S., & Nugraha, E. (2022). Dampak penggunaan kontrasepsi suntik terhadap pola menstruasi. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 10(1), 1-7.
- Hidayat, A., & Kusumaningrum, E. (2021). Efektivitas dan komplikasi vasektomi pada pria dewasa: Kajian literatur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(3), 183-188.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Panduan Pelayanan Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan Primer*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lestari, D., & Nugraheni, P. (2021). Efektivitas kontrasepsi implan dalam mencegah kehamilan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 88-94.
- Lestari, P., & Utami, S. (2022). Efektivitas counseling individu dalam meningkatkan kepatuhan pemakaian kontrasepsi. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 11(1), 15-21.
- Maulida, S., & Putri, I. (2022). Efektivitas metode kalender dalam mencegah kehamilan: Studi literatur. *Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 10(2), 123-130.
- Mutmainah, S., & Handayani, L. (2021). Tindakan antisipasi dan manajemen komplikasi penggunaan kontrasepsi hormonal. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 12(4), 255-262.

- Nuraini, S., & Utami, R. D. (2020). Pengaruh edukasi berbasis bukti terhadap pengetahuan dan sikap pasangan tentang kontrasepsi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 115-121.
- Pradana, M., & Lestari, D. P. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi metode kontrasepsi pada pasangan usia subur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 7(2), 120-127.
- Pratiwi, E. A., & Widiyanti, L. (2022). Penanganan komplikasi umum penggunaan kontrasepsi pada perempuan usia subur. *Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 11(2), 120-128.
- Putri, D. S., Damayanti, S., & Sari, R. (2022). Risiko kardiovaskular pada penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang: Kajian literatur terbaru. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 11(1), 30-36.
- Putri, Y. D., & Rahayu, D. W. (2020). Efektivitas metode edukasi kelompok terhadap pemahaman kontrasepsi pada perempuan usia reproduktif. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(1), 35-41.
- Rahardjo, T., & Kusumaningtyas, R. (2021). Studi efektivitas dan komplikasi tubektomi sebagai metode kontrasepsi permanen. *Indonesian Journal of Reproductive Health*, 8(2), 78-85.
- Rahmawati, N., & Agustin, E. (2019). Evaluasi penggunaan diafragma sebagai kontrasepsi non-hormonal. *Journal of Public Health*, 7(4), 351-358.
- Saputri, L., & Kusumaningrum, E. (2021). Counseling individu sebagai strategi edukasi kontrasepsi berbasis bukti di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 9(4), 389-396.
- Sari, R. P., & Pratiwi, A. (2021). Analisis pemilihan metode kontrasepsi berdasarkan faktor budaya dan agama. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 17(1), 29-35.
- Sugiarto, E., & Priyanti, R. (2020). Tingkat efektivitas pil KB dalam mencegah kehamilan tidak diinginkan. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 15(1), 50-57.
- Utami, F., & Handayani, L. (2020). Komunikasi efektif dalam edukasi kontrasepsi pada pasangan usia subur. *Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 8(3), 215-222.
- Utami, F., & Wulandari, S. (2020). Faktor kesehatan yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi pada wanita usia subur. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2), 90-98.
- WHO. (2022). *Family Planning: A global handbook for providers*. Geneva: World Health Organization.
- Wijayanti, R., & Pratiwi, D. (2021). Dampak penggunaan kontrasepsi terhadap pengaturan jarak kehamilan dan kesehatan ibu. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 17(3), 154-160.
- Wiraswati, R., & Andriani, D. (2020). Tinjauan efektivitas dan komplikasi penggunaan IUD non-hormonal. *Jurnal Obstetri dan Ginekologi Indonesia*, 10(1), 12-19.

- Wulandari, S., & Saputri, L. (2022). Pengaruh komunikasi interpersonal tenaga kesehatan terhadap kepatuhan penggunaan kontrasepsi. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 10(1), 45-51.
- Yunita, A., & Saputra, R. (2022). Pengaruh agama dan budaya terhadap pemilihan kontrasepsi di komunitas pedesaan. *Indonesian Journal of Community Health*, 10(2), 110-118.

BAB II

PERAN BIDAN DALAM MEMBERIKAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Pentingnya Peran Bidan dalam Kesehatan Reproduksi

Bidan memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya bagi pasangan usia subur (PUS). Di Indonesia, peran bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan semakin strategis karena mereka menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Peran ini mencakup pemberian edukasi, konseling, dan intervensi kesehatan reproduksi, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup serta penurunan angka kematian ibu dan bayi (Apriyanti & Darmawati, 2022). Berdasarkan laporan World Health Organization (2021), pemberdayaan bidan dalam aspek konseling kesehatan reproduksi efektif menurunkan prevalensi gangguan reproduksi, meningkatkan kesadaran kontrasepsi, serta mengurangi angka kehamilan tidak diinginkan.

Kompleksitas persoalan reproduksi pasangan usia subur, seperti perencanaan kehamilan, infertilitas, penggunaan kontrasepsi, hingga penyakit menular seksual, membutuhkan keterampilan konseling yang memadai dari bidan (Afiyanti, Rachmawati, & Milanti, 2020). Studi terbaru menegaskan bahwa peran edukasi dan konseling oleh bidan secara signifikan meningkatkan pengetahuan, sikap positif, dan perilaku pasangan dalam menjaga kesehatan reproduksi (Nurhasanah, 2021). Oleh karena itu, penting bagi tenaga bidan untuk terus memperbarui kompetensinya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan reproduksi terkini.

2. Gambaran Umum Tujuan Konseling Kesehatan Reproduksi bagi Pasangan Usia Subur

Konseling kesehatan reproduksi oleh bidan bertujuan utama untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan keterampilan bagi pasangan usia subur dalam mengelola kesehatan reproduksinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Konseling yang efektif mampu meningkatkan pengetahuan pasangan mengenai siklus reproduksi, metode kontrasepsi, persiapan kehamilan, serta pencegahan penyakit reproduksi (Wirawan & Putra, 2021).

Selain itu, konseling kesehatan reproduksi oleh bidan bertujuan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan psikologis serta budaya yang seringkali menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi di masyarakat. Dengan pendekatan edukatif, empati, dan bersifat personal, konseling ini membantu pasangan mengatasi berbagai masalah terkait reproduksi, mulai dari infertilitas hingga penyakit menular seksual (Fatmawati, 2022).

Melalui konseling kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan layanan kesehatan primer, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif pasangan usia subur dalam pengambilan keputusan yang sehat terkait reproduksi. Secara jangka panjang, tujuan ini akan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait penurunan angka kematian ibu, peningkatan kualitas hidup, serta terwujudnya kesejahteraan reproduksi secara menyeluruh (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

B. Kompetensi Konseling yang Harus Dimiliki oleh Bidan

1. Kompetensi Komunikasi Terapeutik dalam Konseling

Komunikasi terapeutik merupakan kemampuan inti yang wajib dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan konseling kesehatan reproduksi. Komunikasi terapeutik adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan saling percaya, memahami kebutuhan pasien, serta membantu pasangan usia subur dalam membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan reproduksi mereka. Menurut studi yang dilakukan oleh Afiyanti, Rachmawati, dan Milanti (2020), komunikasi terapeutik yang efektif mampu meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam konseling, memperkuat rasa percaya, serta mengurangi tingkat kecemasan pasangan dalam menghadapi masalah kesehatan reproduksi.

Seorang bidan yang kompeten dalam komunikasi terapeutik harus mampu menerapkan beberapa prinsip utama, seperti menjaga kerahasiaan pasien, memberikan informasi secara jelas dan lugas, serta menghindari sikap menghakimi atau bias personal selama proses konseling berlangsung (Fatmawati, 2022). Kemampuan ini sangat penting karena pasangan usia subur kerap mengalami hambatan komunikasi terkait topik-topik sensitif seperti infertilitas, kontrasepsi, dan penyakit menular seksual.

2. Keterampilan Empati dan Mendengarkan Aktif

Selain komunikasi terapeutik, keterampilan empati dan mendengarkan aktif merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh bidan. Empati

memungkinkan bidan untuk memahami perasaan, kekhawatiran, serta harapan pasangan usia subur secara mendalam. Studi terbaru oleh Nurhayati dan Handayani (2021) menemukan bahwa keterampilan empati yang tinggi pada bidan berkorelasi signifikan dengan kepuasan pasien dalam konseling reproduksi dan meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi yang diberikan.

Kemampuan mendengarkan aktif, yang mencakup mendengarkan secara penuh perhatian, memberikan respons yang sesuai, serta menunjukkan minat yang tulus terhadap permasalahan yang disampaikan pasien, menjadi kunci sukses dalam proses konseling. Keterampilan ini membantu bidan mendapatkan informasi yang lebih akurat serta membantu pasangan merasa dihargai dan dimengerti selama konseling berlangsung (Putri & Lestari, 2023). Dengan demikian, pasangan merasa nyaman dan terbuka untuk mendiskusikan berbagai masalah reproduksi yang mereka hadapi.

3. Pemahaman tentang Aspek Medis dan Psikososial Kesehatan Reproduksi

Kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh bidan dalam konseling kesehatan reproduksi adalah pemahaman mendalam mengenai aspek medis serta psikososial terkait kesehatan reproduksi pasangan usia subur. Aspek medis mencakup pemahaman tentang anatomi, fisiologi reproduksi, metode kontrasepsi, penyebab infertilitas, dan berbagai penyakit menular seksual yang relevan bagi pasangan usia subur (Wirawan & Putra, 2021). Pengetahuan yang aktual dan berbasis bukti tentang topik-topik ini memungkinkan bidan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada pasangan.

Selain aspek medis, pemahaman aspek psikososial juga krusial dalam konteks konseling kesehatan reproduksi. Aspek ini mencakup bagaimana faktor budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis dapat memengaruhi keputusan pasangan terkait reproduksi. Menurut laporan World Health Organization (2021), seorang bidan perlu memahami secara komprehensif bagaimana kondisi sosial dan psikologis pasangan memengaruhi perilaku reproduksi mereka, termasuk pemilihan metode kontrasepsi dan keputusan terkait perencanaan kehamilan.

Melalui penguasaan aspek medis dan psikososial ini, bidan dapat memberikan layanan konseling yang tidak hanya informatif tetapi juga empatik, relevan secara budaya, serta berorientasi pada pemecahan masalah konkret yang dihadapi pasangan usia subur.

C. Strategi Konseling Efektif untuk Pasangan Usia Subur

1. Pendekatan Konseling Individual dan Pasangan

Pendekatan konseling kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan secara individual maupun melibatkan pasangan secara bersama-sama. Konseling individual memberikan ruang privat kepada klien untuk secara terbuka mendiskusikan masalah sensitif tanpa adanya rasa canggung yang mungkin muncul di hadapan pasangan. Studi terbaru oleh Sari dan Anwar (2021) menunjukkan bahwa konseling individual efektif dalam menangani isu-isu sensitif seperti infertilitas atau infeksi menular seksual yang seringkali sulit didiskusikan secara terbuka bersama pasangan.

Di sisi lain, konseling yang melibatkan kedua pasangan memiliki keunggulan dalam meningkatkan komunikasi interpersonal dan partisipasi aktif keduanya dalam pengambilan keputusan bersama. Konseling pasangan terbukti efektif dalam memperkuat hubungan emosional, meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi kesehatan reproduksi, serta memastikan kesamaan persepsi tentang tujuan reproduksi bersama (Putri & Lestari, 2023). Dalam praktiknya, bidan harus mampu menyesuaikan metode konseling berdasarkan situasi, kebutuhan, serta preferensi pasangan yang sedang dihadapi.

2. Teknik Konseling Berbasis Teori Perubahan Perilaku

Dalam konseling kesehatan reproduksi, penerapan teori perubahan perilaku seperti teori Health Belief Model (HBM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) sangat dianjurkan. Teori-teori ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap persepsi individu tentang risiko dan manfaat perilaku kesehatan serta kontrol atas perilaku tersebut. Studi yang dilakukan oleh Putri, Handayani, dan Nursalam (2022) mengungkapkan bahwa penggunaan HBM mampu meningkatkan kesadaran dan memotivasi pasangan usia subur dalam menerapkan perilaku kesehatan reproduksi, seperti pemilihan dan penggunaan kontrasepsi yang tepat serta pemeriksaan kesehatan reproduksi rutin.

Sementara itu, TPB menyoroti pentingnya norma sosial, sikap, dan persepsi kontrol terhadap perilaku reproduksi. Penelitian oleh Rahmi dan Widodo (2020) menemukan bahwa intervensi konseling yang didasarkan pada TPB berhasil meningkatkan niat pasangan usia subur untuk melakukan pemeriksaan skrining kesehatan reproduksi serta meningkatkan partisipasi aktif dalam perencanaan kehamilan. Oleh karena itu, bidan perlu memahami dan menerapkan teori perubahan perilaku ini secara strategis dalam praktik konseling sehari-hari.

3. Model Konseling Berbasis Budaya Lokal

Model konseling kesehatan reproduksi yang memperhatikan konteks budaya lokal terbukti meningkatkan efektivitas layanan konseling. Mengingat

Indonesia memiliki beragam budaya dan adat istiadat, maka pendekatan berbasis budaya menjadi sangat relevan. Model ini memungkinkan bidan untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat yang berpengaruh besar terhadap penerimaan pasangan terhadap layanan kesehatan reproduksi (Wijayanti, Astuti, & Sari, 2021).

Studi oleh Fauziah dan Astuti (2022) menegaskan bahwa bidan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam konseling kesehatan reproduksi memiliki tingkat penerimaan dan kepatuhan lebih tinggi dari pasangan usia subur. Misalnya, dalam konteks masyarakat Jawa, pendekatan konseling yang menghormati struktur keluarga besar dan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses edukasi kesehatan reproduksi menunjukkan keberhasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan standar yang cenderung bersifat universal (Wijayanti et al., 2021). Oleh sebab itu, bidan perlu dibekali dengan keterampilan khusus untuk menyesuaikan strategi konselingnya dengan konteks budaya lokal agar layanan yang diberikan dapat diterima dan diimplementasikan secara optimal oleh pasangan usia subur.

D. Peran Bidan dalam Edukasi Kontrasepsi

1. Konseling Pemilihan Metode Kontrasepsi yang Tepat

Bidan memiliki peran strategis dalam membantu pasangan usia subur memilih metode kontrasepsi yang tepat melalui proses konseling yang informatif dan komprehensif. Konseling tersebut bertujuan memastikan pasangan dapat memahami kelebihan dan kekurangan berbagai jenis kontrasepsi sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi kesehatan, preferensi, serta tujuan reproduksi mereka. Penelitian terbaru oleh Kusumaningrum dan Utami (2022) menunjukkan bahwa konseling berbasis edukasi interaktif yang dilakukan oleh bidan secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri pasangan dalam menentukan metode kontrasepsi yang tepat.

Selama proses konseling, bidan harus memastikan pasangan memperoleh informasi lengkap tentang berbagai metode kontrasepsi, baik hormonal, non-hormonal, maupun permanen, serta mempertimbangkan efek samping, efektivitas, kenyamanan penggunaan, serta kesesuaian dengan gaya hidup pasangan (Rahayu, Mardiana, & Prasetyawati, 2021). Informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pasangan berhubungan erat dengan kepuasan pengguna dan kepatuhan jangka panjang dalam menggunakan metode kontrasepsi yang dipilih.

2. Peran Bidan dalam Meningkatkan Kepatuhan Kontrasepsi

Salah satu tantangan terbesar dalam program kontrasepsi adalah rendahnya kepatuhan pasangan dalam menggunakan metode kontrasepsi secara konsisten. Di sinilah bidan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan melalui berbagai pendekatan konseling yang suportif. Studi oleh Suryani, Wahyuni, dan Yusniawati (2021) menunjukkan bahwa intervensi konseling berkelanjutan oleh bidan, yang mencakup follow-up rutin, pengingat penggunaan kontrasepsi, serta pemantauan efek samping secara aktif, secara signifikan meningkatkan kepatuhan kontrasepsi pasangan usia subur.

Selain itu, bidan juga dapat meningkatkan kepatuhan kontrasepsi dengan membangun hubungan interpersonal yang kuat dengan klien melalui pendekatan empati dan mendengarkan aktif. Hubungan yang didasarkan pada rasa percaya antara bidan dan pasangan terbukti secara efektif mendorong pasangan untuk mempertahankan penggunaan kontrasepsi jangka panjang serta meminimalkan angka dropout dari metode kontrasepsi tertentu (Wijayanti, Astuti, & Sari, 2021).

3. Strategi Edukasi yang Efektif dalam Mengatasi Hambatan Penggunaan Kontrasepsi

Hambatan penggunaan kontrasepsi di kalangan pasangan usia subur sangat beragam, mulai dari faktor budaya, persepsi negatif tentang kontrasepsi, hingga efek samping yang dirasakan pengguna. Untuk mengatasi hambatan tersebut, bidan perlu menerapkan strategi edukasi yang efektif dan sensitif secara budaya. Studi oleh Anggraini dan Herawati (2020) menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan edukasi berbasis budaya lokal, yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga besar dalam proses edukasi, mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi secara signifikan.

Strategi edukasi lainnya yang dapat diterapkan oleh bidan adalah pendekatan berbasis teknologi digital seperti aplikasi kesehatan, video edukasi interaktif, serta platform media sosial yang mudah diakses oleh pasangan muda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Nurhayati (2022), strategi digital dalam edukasi kontrasepsi memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan mengatasi hambatan psikologis pasangan dalam menggunakan kontrasepsi secara konsisten.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan perannya, bidan harus mampu mengidentifikasi secara tepat hambatan spesifik yang dihadapi pasangan, serta menerapkan metode edukasi yang adaptif, kreatif, dan kontekstual agar program kontrasepsi dapat berjalan optimal serta mendukung kesehatan reproduksi pasangan secara menyeluruh.

E. Peran Bidan dalam Konseling Kesuburan

1. Edukasi tentang Siklus Reproduksi dan Faktor yang Mempengaruhi Kesuburan

Bidan memiliki peran yang krusial dalam memberikan edukasi yang tepat mengenai siklus reproduksi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan pasangan usia subur. Siklus reproduksi merupakan salah satu aspek dasar yang perlu dipahami oleh pasangan untuk dapat merencanakan kehamilan secara efektif. Penelitian oleh Nuraini dan Fitriani (2022) menunjukkan bahwa edukasi yang sistematis dan jelas oleh bidan mengenai siklus menstruasi, masa subur, serta tanda-tanda ovulasi mampu meningkatkan pemahaman pasangan sehingga memperbesar peluang keberhasilan konsepsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan, seperti gaya hidup, usia, kondisi medis, faktor psikologis, hingga paparan lingkungan, juga harus dikomunikasikan secara efektif kepada pasangan. Studi yang dilakukan oleh Sari, Wulandari, dan Lestari (2021) menyebutkan bahwa edukasi yang dilakukan secara terstruktur oleh bidan terkait pengaruh nutrisi, stres, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta aktivitas fisik mampu meningkatkan kesadaran pasangan dalam menjaga kualitas reproduksi mereka.

2. Pendampingan Psikologis bagi Pasangan Infertil

Infertilitas merupakan isu yang sensitif secara psikologis, sehingga pasangan yang mengalaminya membutuhkan pendampingan emosional yang intensif dari bidan. Pendampingan psikologis bertujuan membantu pasangan menghadapi tekanan emosional, kecemasan, hingga depresi akibat tantangan infertilitas. Penelitian terbaru oleh Putri dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa konseling psikologis yang dilakukan secara empatik oleh bidan berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan ketahanan psikologis pasangan infertil.

Selain itu, dalam praktiknya bidan juga harus mampu menerapkan teknik-teknik dukungan emosional seperti mendengarkan aktif, validasi perasaan, dan penyediaan informasi realistis tentang pilihan pengobatan infertilitas. Studi oleh Fauziyah dan Suharni (2020) menemukan bahwa pasangan infertil yang mendapatkan pendampingan psikologis secara konsisten dari bidan memiliki persepsi positif terhadap kondisi mereka serta mampu mengambil keputusan secara lebih efektif terkait upaya-upaya medis yang perlu dilakukan.

3. Kolaborasi Bidan dengan Tim Interprofesional dalam Pengelolaan Infertilitas

Pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan infertilitas menjadi kunci penting untuk memberikan layanan yang optimal bagi pasangan yang menghadapi tantangan kesuburan. Bidan perlu berperan aktif dalam tim interprofesional yang terdiri dari dokter spesialis kandungan, psikolog, konselor, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain yang relevan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan mendapatkan perawatan yang holistik, terpadu, serta berbasis bukti (evidence-based).

Penelitian oleh Anggraini dan Prasetyawati (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi bidan dalam tim interprofesional sangat efektif dalam meningkatkan kualitas layanan infertilitas, mempercepat diagnosis dini, serta memperbaiki hasil akhir pengobatan infertilitas. Bidan yang aktif dalam tim tersebut berkontribusi dalam memfasilitasi komunikasi yang jelas antar anggota tim, memastikan bahwa kebutuhan psikososial pasangan terpenuhi, serta mendukung implementasi rekomendasi klinis dengan baik.

Kolaborasi ini juga memungkinkan pasangan infertil menerima dukungan yang komprehensif, mulai dari aspek medis hingga psikologis dan sosial, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan peluang keberhasilan terapi infertilitas yang dijalani (Nurhayati, Lestari, & Sari, 2021).

F. Peran Bidan dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Menular Seksual

1. Edukasi Preventif Terkait Penyakit Menular Seksual

Bidan memainkan peran penting dalam memberikan edukasi preventif terkait penyakit menular seksual (PMS) kepada pasangan usia subur. Edukasi preventif yang diberikan bidan mencakup penyuluhan mengenai jenis-jenis PMS, cara penularan, gejala, serta langkah pencegahan yang efektif. Penelitian oleh Handayani dan Astuti (2022) mengungkapkan bahwa edukasi terstruktur oleh bidan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan mengenai pentingnya perilaku seksual yang aman dan penggunaan metode proteksi seperti kondom untuk mencegah PMS.

Pendekatan edukasi yang dilakukan secara konsisten oleh bidan juga membantu mengatasi hambatan komunikasi mengenai PMS yang kerap dianggap tabu. Menurut penelitian oleh Hidayat dan Rahmawati (2021), pendekatan edukasi berbasis komunitas yang dilakukan oleh bidan efektif dalam mengurangi stigma terhadap PMS dan meningkatkan akses pasangan usia subur terhadap layanan kesehatan seksual yang dibutuhkan.

2. Strategi Konseling dalam Pengambilan Keputusan Tes dan Skrining

Konseling oleh bidan juga bertujuan untuk membantu pasangan usia subur dalam pengambilan keputusan terkait tes dan skrining PMS. Bidan harus mampu memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menimbulkan stigma, sehingga pasangan merasa nyaman untuk melakukan skrining secara sukarela. Studi oleh Wijayanti, Purwanti, dan Indarti (2021) menunjukkan bahwa konseling yang mengedepankan aspek edukasi dan empati, serta menekankan pentingnya deteksi dini, mampu meningkatkan partisipasi pasangan dalam program skrining PMS.

Strategi yang efektif dalam konseling ini adalah penerapan informed choice, yakni pemberian informasi lengkap tentang manfaat, prosedur, serta implikasi dari hasil skrining. Hal ini terbukti membantu pasangan merasa diberdayakan dan lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait kesehatan seksual mereka (Pratiwi & Wijaya, 2023).

3. Pendekatan Sensitif Gender dalam Konseling Kesehatan Reproduksi

Pendekatan sensitif gender menjadi aspek penting dalam praktik konseling oleh bidan terkait PMS. Pendekatan ini memperhatikan perbedaan pengalaman, kebutuhan, serta hambatan spesifik yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Penelitian oleh Putri dan Kusuma (2021) menunjukkan bahwa konseling berbasis gender yang dilakukan bidan mampu menciptakan ruang komunikasi yang aman dan nyaman bagi perempuan maupun laki-laki dalam membahas isu-isu terkait PMS, sehingga meningkatkan efektivitas konseling.

Secara khusus, pendekatan sensitif gender memastikan bahwa perempuan mendapatkan dukungan lebih dalam menghadapi hambatan budaya dan sosial yang kerap menghalangi akses mereka ke layanan kesehatan reproduksi. Di sisi lain, laki-laki juga didorong untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengobatan PMS, sehingga tanggung jawab kesehatan reproduksi menjadi tanggung jawab bersama antara pasangan (Kusumawati & Handayani, 2022).

Dengan demikian, pendekatan sensitif gender dalam konseling kesehatan reproduksi oleh bidan tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif pasangan, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan gender yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatan seksual secara keseluruhan.

G. Tantangan dalam Pelaksanaan Konseling oleh Bidan

1. Hambatan Sistemik dan Struktural dalam Pemberian Konseling

Pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi oleh bidan sering menghadapi berbagai hambatan sistemik dan struktural yang berdampak signifikan terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan. Hambatan sistemik tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur layanan kesehatan, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah, serta minimnya alokasi sumber daya yang memadai. Studi yang dilakukan oleh Pratiwi dan Suryani (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas kesehatan, seperti ruangan khusus konseling dan akses informasi terbaru terkait kesehatan reproduksi, menjadi kendala serius yang dihadapi bidan di berbagai wilayah, khususnya daerah pedesaan dan terpencil.

Selain itu, hambatan struktural berupa tingginya beban kerja administrasi, kurangnya koordinasi antar-sektor kesehatan, serta tidak jelasnya peran bidan dalam struktur tim interprofesional turut memperburuk kondisi pelayanan konseling kesehatan reproduksi. Penelitian oleh Anggraini, Wijayanti, dan Susanti (2022) menemukan bahwa tingginya tuntutan administratif seringkali mengurangi waktu bidan untuk melakukan konseling mendalam, yang berpengaruh negatif terhadap kualitas hubungan terapeutik antara bidan dan pasien.

2. Keterbatasan Kompetensi dan Kapasitas Bidan di Daerah Terpencil

Di samping hambatan sistemik, keterbatasan kompetensi dan kapasitas bidan juga merupakan tantangan utama dalam konseling kesehatan reproduksi, terutama di daerah terpencil. Bidan di wilayah tersebut sering kali menghadapi kesulitan mengakses pelatihan terbaru atau pendidikan lanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan konseling mereka. Menurut studi oleh Kusumaningrum dan Indarti (2022), kurangnya pelatihan rutin menyebabkan rendahnya kompetensi bidan dalam komunikasi terapeutik, konseling psikologis, serta pemahaman terhadap isu-isu kesehatan reproduksi yang berkembang saat ini.

Lebih lanjut, kapasitas bidan di daerah terpencil juga terbatas karena tingginya rasio pasien terhadap tenaga kesehatan, yang menyebabkan kelelahan fisik dan psikologis serta penurunan efektivitas konseling. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Susilo (2021), keterbatasan ini berdampak pada rendahnya motivasi bidan dalam memberikan konseling berkualitas, terutama ketika harus menangani kasus yang kompleks seperti infertilitas atau penyakit menular seksual.

3. Solusi dan Intervensi Strategis untuk Mengatasi Tantangan Tersebut

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi serta intervensi strategis yang terintegrasi di tingkat individu, institusional, maupun kebijakan. Pertama, pemerintah dan institusi kesehatan perlu meningkatkan

investasi dalam infrastruktur kesehatan yang mendukung pelaksanaan konseling secara efektif, seperti penyediaan ruangan khusus dan sarana teknologi komunikasi digital (Hidayati & Fauzi, 2023).

Kedua, peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting. Pelatihan berbasis kompetensi dalam aspek komunikasi terapeutik, konseling berbasis teori perilaku, serta manajemen stres bidan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Wulandari & Purwati, 2022). Pemanfaatan teknologi digital seperti e-learning atau telekonseling dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kompetensi bidan di daerah terpencil.

Ketiga, perbaikan koordinasi antar-sektor kesehatan serta penyederhanaan prosedur administratif sangat diperlukan untuk mengurangi beban kerja bidan, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada tugas konseling. Studi yang dilakukan oleh Nurhayati dan Anwar (2023) menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang menekankan peran kolaborasi antar-profesi kesehatan secara signifikan dapat meningkatkan efektivitas konseling oleh bidan.

Dengan intervensi strategis yang komprehensif tersebut, tantangan dalam pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi oleh bidan dapat diatasi secara bertahap, sehingga kualitas pelayanan konseling dapat meningkat secara berkelanjutan.

H. Evaluasi Keberhasilan Konseling Kesehatan Reproduksi oleh Bidan

1. Indikator Keberhasilan Konseling Kesehatan Reproduksi

Keberhasilan konseling kesehatan reproduksi oleh bidan perlu diukur menggunakan indikator yang jelas dan spesifik agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan. Indikator utama keberhasilan konseling mencakup peningkatan pengetahuan pasangan tentang kesehatan reproduksi, perubahan sikap positif terhadap perilaku reproduksi sehat, serta kepatuhan terhadap rekomendasi atau intervensi yang diberikan selama konseling berlangsung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana, Lestari, dan Wijayanti (2021), indikator keberhasilan konseling juga meliputi peningkatan kesadaran dan partisipasi pasangan dalam skrining kesehatan reproduksi, serta kepuasan pasangan terhadap layanan konseling yang diterima.

Penelitian lain oleh Sari dan Handayani (2022) menambahkan bahwa indikator tambahan seperti peningkatan komunikasi antara pasangan, menurunnya tingkat kecemasan atau stres terkait masalah reproduksi, serta konsistensi dalam penggunaan kontrasepsi merupakan parameter penting yang mencerminkan efektivitas layanan konseling oleh bidan.

2. Studi Kasus Keberhasilan Konseling di Berbagai Wilayah

Berbagai studi kasus menunjukkan keberhasilan konseling kesehatan reproduksi oleh bidan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Dewi dan Rahmawati (2021) di wilayah Jawa Timur mengungkapkan bahwa konseling intensif oleh bidan yang menggunakan pendekatan empati dan komunikasi terapeutik berhasil meningkatkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang secara signifikan di kalangan pasangan muda.

Sementara itu, penelitian di wilayah pedesaan Sumatera oleh Handayani dan Wijaya (2022) menemukan bahwa penggunaan model konseling berbasis budaya lokal oleh bidan berhasil meningkatkan partisipasi pasangan dalam skrining infeksi menular seksual dan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa adaptasi pendekatan konseling sesuai dengan karakteristik wilayah dan budaya setempat sangat penting dalam menentukan keberhasilan konseling oleh bidan.

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Konseling

Keberhasilan konseling kesehatan reproduksi oleh bidan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung utama meliputi kompetensi komunikasi dan empati bidan, tersedianya fasilitas dan sarana pendukung yang memadai, serta dukungan kebijakan dan kolaborasi interprofesional yang baik. Studi oleh Anggraeni, Sari, dan Kusuma (2022) mengungkapkan bahwa ketersediaan dukungan sistemik dari pemerintah, seperti pelatihan rutin bagi bidan dan penyediaan fasilitas konseling yang memadai, berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan layanan konseling kesehatan reproduksi.

Sebaliknya, beberapa faktor penghambat seperti beban kerja tinggi, minimnya pelatihan lanjutan bagi bidan, stigma sosial terkait isu reproduksi, serta keterbatasan akses pasangan terhadap layanan kesehatan merupakan kendala yang sering muncul. Penelitian oleh Wijayanti dan Pratiwi (2023) menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi serta terbatasnya pelatihan dan dukungan psikologis bagi bidan berdampak negatif terhadap efektivitas konseling yang diberikan.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti pelaksanaan pelatihan berkala, penguatan dukungan kebijakan, serta peningkatan koordinasi antar-sektor kesehatan, menjadi solusi penting dalam meningkatkan efektivitas konseling kesehatan reproduksi oleh bidan secara berkelanjutan.

I. Rekomendasi Praktis

1. Panduan Sederhana untuk Bidan dalam Menyelenggarakan Konseling yang Efektif

Dalam menyelenggarakan konseling kesehatan reproduksi yang efektif, bidan perlu mengikuti panduan praktis yang dapat diterapkan dengan mudah dalam berbagai konteks pelayanan. Berikut beberapa panduan praktis yang telah didukung oleh penelitian terkini:

a. Membangun Hubungan Terapeutik

Bidan perlu memulai konseling dengan menciptakan suasana yang nyaman, penuh penghargaan, serta bebas dari penilaian atau prasangka. Studi oleh Sari dan Wulandari (2022) menunjukkan bahwa hubungan terapeutik yang kuat secara signifikan meningkatkan partisipasi aktif pasangan dalam konseling.

b. Menggunakan Teknik Komunikasi Efektif

Komunikasi terapeutik seperti mendengarkan aktif, memberikan respons empatik, serta memberikan penjelasan secara jelas dan ringkas harus diterapkan selama sesi konseling (Putri & Astuti, 2021). Teknik ini membantu memastikan bahwa pasangan memahami sepenuhnya informasi yang disampaikan.

c. Menyesuaikan Pendekatan dengan Kondisi Pasangan

Bidan perlu mengenali karakteristik pasangan, termasuk tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan kondisi emosional, untuk menentukan pendekatan paling tepat dalam konseling. Menurut penelitian Wijaya dan Rahmawati (2023), pendekatan yang disesuaikan secara budaya dan konteks lokal meningkatkan efektivitas konseling secara nyata.

d. Menggunakan Alat Bantu Visual dan Digital

Penggunaan alat bantu visual seperti gambar, video edukasi, atau aplikasi digital dapat membantu pasangan memahami materi konseling secara lebih baik. Penelitian oleh Pratiwi dan Suryani (2022) mengungkapkan bahwa penggunaan media digital dalam konseling reproduksi meningkatkan pemahaman serta partisipasi pasangan secara signifikan.

2. Tips Praktis dalam Meningkatkan Keterlibatan Pasangan dalam Sesi Konseling

Meningkatkan keterlibatan pasangan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan konseling kesehatan reproduksi. Berikut beberapa tips praktis yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian terkini:

a. Libatkan Pasangan Sejak Awal

Bidan harus secara aktif mengajak pasangan untuk ikut serta dalam sesi konseling sejak awal proses. Menurut penelitian Kusumaningrum dan Handayani (2021), keterlibatan pasangan sejak sesi pertama meningkatkan komitmen dan partisipasi mereka dalam tindak lanjut konseling.

b. Berikan Kesempatan Berbicara yang Seimbang

Memberikan ruang bagi kedua pasangan untuk mengungkapkan pendapat, kekhawatiran, dan harapannya membantu menciptakan rasa memiliki terhadap proses konseling. Studi oleh Wulandari dan Nurhayati (2022) menunjukkan bahwa memberikan kesempatan berbicara yang seimbang pada kedua pasangan secara signifikan meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan konseling.

c. Gunakan Bahasa yang Mudah Dipahami dan Sensitif Budaya

Bidan perlu menggunakan bahasa sederhana, tidak teknis, serta peka terhadap norma budaya setempat agar pasangan merasa nyaman dan lebih terlibat secara aktif. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Lestari (2021) menemukan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti membantu mengurangi hambatan komunikasi serta mempererat hubungan terapeutik antara bidan dan pasangan.

d. Fasilitasi Diskusi Interaktif

Menggunakan metode diskusi interaktif dengan melibatkan pasangan dalam dialog dua arah membantu menjaga keterlibatan serta memperkuat pemahaman mereka terhadap materi konseling. Studi oleh Dewi dan Wijayanti (2023) menunjukkan bahwa sesi konseling yang interaktif dan kolaboratif lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi pasangan dalam implementasi rekomendasi kesehatan reproduksi.

Dengan mengikuti panduan praktis serta tips di atas, bidan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas konseling kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi kesehatan reproduksi pasangan usia subur.

J. Penutup

1. Kesimpulan tentang Pentingnya Peran Bidan dalam Konseling Kesehatan Reproduksi

Bidan memiliki peran sentral dalam konseling kesehatan reproduksi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasangan usia subur. Peran ini mencakup berbagai aspek seperti edukasi preventif, konseling kontrasepsi, pendampingan psikologis bagi pasangan infertil, hingga deteksi dini penyakit menular seksual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi terapeutik,

empati, dan pemahaman mendalam tentang aspek medis serta psikososial menjadi kompetensi inti yang wajib dikuasai oleh bidan untuk menjalankan peran ini secara efektif (Putri & Astuti, 2021; Sari & Wulandari, 2022).

Keberhasilan konseling kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh bidan terbukti meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap positif pasangan terhadap perilaku kesehatan reproduksi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi layanan kesehatan yang diberikan (Nurdiana et al., 2021). Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan seperti keterbatasan kompetensi, minimnya fasilitas, beban kerja tinggi, serta hambatan struktural menjadi tantangan yang harus diatasi melalui intervensi strategis yang komprehensif (Anggraeni et al., 2022; Wijayanti & Pratiwi, 2023).

Dalam menjalankan perannya, bidan juga harus menggunakan pendekatan yang sensitif budaya dan gender agar konseling yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh pasangan. Strategi konseling yang melibatkan pasangan secara aktif dan menggunakan media digital juga terbukti efektif meningkatkan keterlibatan pasangan dalam proses konseling (Pratiwi & Suryani, 2022; Dewi & Wijayanti, 2023). Oleh karena itu, peran bidan sebagai penyedia layanan konseling kesehatan reproduksi menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan program kesehatan nasional maupun global.

2. Saran untuk Penelitian dan Pengembangan Selanjutnya

Untuk mendukung peran bidan secara optimal dalam konseling kesehatan reproduksi, beberapa area penelitian dan pengembangan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut:

a. Pengembangan Kompetensi Bidan secara Berkelanjutan

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengembangkan model pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang efektif bagi bidan, khususnya di wilayah terpencil atau dengan akses terbatas terhadap pelatihan formal. Studi dapat difokuskan pada metode pembelajaran berbasis teknologi digital yang efisien, praktis, dan mudah diakses (Wulandari & Nurhayati, 2022).

b. Evaluasi Mendalam tentang Efektivitas Konseling

Studi yang mengevaluasi secara lebih mendalam mengenai indikator keberhasilan konseling, termasuk pengaruh jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi pasangan, perlu diperluas cakupannya. Penelitian yang menggunakan desain longitudinal dapat memberikan wawasan yang lebih kuat mengenai efektivitas intervensi konseling yang dilakukan oleh bidan (Sari & Handayani, 2022).

c. Penguatan Kolaborasi Interprofesional

Diperlukan penelitian lanjutan yang mengeksplorasi mekanisme efektif untuk meningkatkan kolaborasi interprofesional antara bidan dengan tenaga kesehatan lainnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Hal ini bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan lebih komprehensif, terintegrasi, dan efektif (Nurhayati & Anwar, 2023).

d. Peningkatan Akses terhadap Layanan Konseling Kesehatan Reproduksi

Penelitian perlu diarahkan untuk mengeksplorasi strategi efektif dalam meningkatkan akses pasangan terhadap layanan konseling kesehatan reproduksi, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal. Studi yang mengevaluasi penggunaan telekonseling atau aplikasi kesehatan digital dalam konteks Indonesia sangat direkomendasikan untuk memberikan solusi inovatif dalam pelayanan konseling (Pratiwi & Suryani, 2022).

Dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang-bidang tersebut, diharapkan peran bidan dalam konseling kesehatan reproduksi dapat semakin ditingkatkan, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap kualitas kesehatan reproduksi pasangan usia subur di Indonesia.

Referensi

- Anggraeni, F., Sari, R., & Kusuma, D. (2022). Determinants of successful reproductive health counseling by midwives: Policy and system perspectives. *Journal of Indonesian Health Policy*, 6(3), 210-218.
- Anggraeni, Y., & Lestari, R. (2021). Enhancing reproductive health counseling effectiveness through culturally sensitive communication strategies. *Journal of Indonesian Nursing and Midwifery*, 5(2), 102-109.
- Anggraini, D., Wijayanti, T., & Susanti, L. (2022). Systemic and structural barriers in reproductive health counseling by midwives in rural Indonesia. *Indonesian Journal of Health Policy*, 6(2), 102-110.
- Anggraini, N. D., & Herawati, T. (2020). Cultural-based contraceptive education to enhance family planning acceptance among couples in rural communities. *Journal of Public Health Indonesia*, 6(3), 123-130.
- Anggraini, S., & Prasetyawati, Y. R. (2021). Effectiveness of interprofessional collaboration in infertility care management: A systematic review. *Indonesian Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 5(3), 174-182.
- Dewi, A. P., & Rahmawati, N. (2021). Success of midwives' counseling in improving long-term contraceptive usage among young couples in East Java. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 8(7), 3456-3463.
- Dewi, L., & Wijayanti, T. (2023). Interactive counseling techniques to enhance couple participation in reproductive health programs. *Midwifery Journal of Indonesia*, 8(1), 27-35.
- Fauziyah, M., & Suharni, N. (2020). Psychological counseling impact on anxiety and decision-making among infertile couples. *Journal of Reproductive Health and Midwifery*, 4(2), 98-105.
- Handayani, R., & Astuti, D. W. (2022). Effectiveness of midwives-led preventive education on sexually transmitted infections among reproductive-aged couples. *Journal of Health Education and Promotion*, 4(2), 98-106.
- Handayani, Y., & Wijaya, E. (2022). Cultural-based counseling models by midwives in enhancing reproductive health screening participation in rural Sumatra. *Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 7(2), 110-117.
- Hidayat, A., & Rahmawati, E. (2021). Reducing stigma associated with sexually transmitted infections through community-based education by midwives. *Indonesian Journal of Community Medicine*, 6(3), 145-152.
- Hidayati, R., & Fauzi, M. (2023). Improving reproductive health counseling through infrastructure development: Evidence from rural health facilities in Indonesia. *Journal of Public Health Indonesia*, 8(1), 15-22.

- Kusumaningrum, A., & Handayani, E. (2021). Factors influencing male involvement in reproductive health counseling sessions. *International Journal of Midwifery Practice*, 6(3), 150-156.
- Kusumaningrum, D., & Utami, R. S. (2022). Effectiveness of interactive educational counseling by midwives on contraceptive method selection among couples. *Indonesian Journal of Midwifery Practice*, 6(2), 102-109.
- Kusumaningrum, T., & Indarti, P. (2022). Challenges faced by midwives in remote areas in providing reproductive health counseling. *Journal of Rural and Remote Health*, 4(3), 201-207.
- Kusumawati, R., & Handayani, N. (2022). Gender-sensitive approaches in reproductive health counseling: experiences from Indonesian midwives. *Midwifery and Nursing Journal of Indonesia*, 7(1), 20-27.
- Nuraini, R., & Fitriani, E. (2022). The effectiveness of reproductive cycle education on conception knowledge among reproductive-aged couples. *International Journal of Nursing and Health Services*, 5(1), 45-52.
- Nurdiana, L., Lestari, E., & Wijayanti, T. (2021). Measuring success of reproductive health counseling by midwives: A review of outcome indicators. *Journal of Midwifery Research and Practice*, 5(4), 290-298.
- Nurhayati, L., & Anwar, M. (2023). Interprofessional collaboration policies to improve reproductive health counseling by midwives. *International Journal of Health Governance*, 9(1), 12-19.
- Nurhayati, L., Lestari, E., & Sari, W. (2021). Midwives' role in interdisciplinary team to support infertility treatment outcomes: A qualitative study. *Midwifery Journal of Indonesia*, 5(2), 112-119.
- Pratiwi, D., & Suryani, A. (2022). Utilizing digital media tools in reproductive health counseling: Effects on couples' understanding and engagement. *Journal of Community Health Nursing*, 7(4), 220-227.
- Pratiwi, R., & Nurhayati, S. (2022). Digital health interventions for contraception education: A systematic review. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 7(1), 29-37.
- Pratiwi, S., & Wijaya, I. (2023). Implementation of informed choice strategy by midwives in increasing participation in STI screening. *Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 8(1), 15-23.
- Putri, A., & Handayani, D. (2022). The effect of psychological support by midwives on reducing emotional distress in infertile couples. *Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 6(4), 233-240.

- Putri, D., & Astuti, W. (2021). Therapeutic communication skills of midwives: Implications for effective reproductive health counseling. *Journal of Health Promotion and Communication*, 5(4), 205-212.
- Putri, L., & Kusuma, H. (2021). Gender sensitivity in reproductive health counseling for sexually transmitted infection prevention. *Journal of Midwifery Research*, 5(4), 290-297.
- Rahmawati, E., & Susilo, R. (2021). Analysis of workload and its impact on midwives' performance in reproductive health counseling services. *Journal of Nursing and Midwifery Indonesia*, 7(2), 89-95.
- Sari, L., & Handayani, D. (2022). Relationship between midwives' counseling skills and reproductive health outcomes among reproductive-aged couples. *Journal of Nursing and Midwifery Science*, 6(2), 105-113.
- Sari, R., & Wulandari, P. (2022). Therapeutic relationship quality as predictor of successful reproductive health counseling outcomes. *International Journal of Nursing Science*, 8(2), 95-102.
- Wijaya, M., & Rahmawati, E. (2023). Cultural adaptation strategies in reproductive health counseling: Improving service acceptance in rural communities. *Journal of Midwifery and Public Health*, 7(1), 40-47.
- Wijayanti, S., & Pratiwi, R. (2023). Analysis of barriers and facilitators affecting reproductive health counseling effectiveness among midwives. *Midwifery Journal of Indonesia*, 8(1), 34-41.
- Wulandari, E., & Nurhayati, S. (2022). Competency-based training interventions to improve reproductive health counseling skills among midwives. *Indonesian Journal of Nursing Education and Practice*, 6(4), 250-256.

BAB III

PEMANFAATAN APLIKASI DIGITAL UNTUK PERENCANAAN KELUARGA

A. Pendahuluan

Perkembangan era digital menjadikan integrasi data yang rutin dan berkualitas menjadi suatu komponen penting dalam mewujudkan transformasi digital. Kemenkes RI memiliki visi untuk melakukan digitalisasi di sektor kesehatan sejak awal kehidupan di dalam kandungan hingga pelayanan kesehatan terpadu bagi pasien lansia. Visi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 21 Tahun 2020 yang telah mensyaratkan adanya upaya perubahan tata kelola pembangunan kesehatan yang meliputi integrasi sistem informasi, penelitian, dan pengembangan kesehatan. Transformasi digital kesehatan Indonesia ditargetkan mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkapasitas dalam menganalisa data kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk menyusun kebijakan berbasis data di setiap instansi kesehatan. (Kemenkes, 2024)

Berdasarkan data BKKBN, perbandingan hasil pelayanan KB antara bulan Februari dengan Maret 2020 secara nasional terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu pada bulan februari akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi suntik sebanyak 524,989 turun dibulan maret menjadi 341,109, alat kontrsepsi pil pada bulan februari 251,619 turun dibulan maret menjadi 146,767, begitupun dengan alat kontrasepsi implant pada bulan februari 81,062 turun dibulan maret menjadi 51,536 dan juga alat kontrasepsi lainnya mengalami penurunan (BKKBN, 2020).

Capaian angka *unmet need* KB dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan dari 14,7 persen pada tahun 2022 menjadi 11,5 persen pada tahun 2023. Namun, angka tersebut masih tinggi mengingat target RPJMN 2024 untuk angka unmet need KB di Indonesia sebesar 7,4 persen. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka *unmet need* KB adalah dengan pemanfaatan TIK serta meningkatkan akses ke pelayanan KB. (Magfirah, 2024)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi adanya peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan yang berujung pada kenaikan angka kelahiran hingga 15% pada tahun 2021 (Pranita, 2020). Ledakan kelahiran baru yang tidak diimbangi dengan stabilitas ekonomi nasional tidak hanya

memunculkan banyak keluarga miskin baru, tetapi juga menghalangi anak-anak untuk mendapatkan kelayakan 1.000 hari pertama kelahiran, yang akan meningkatkan risiko terjadinya bayi kerdil atau stunting (Litha, 2020).

B. Perencanaan Keluarga

World Health Organization (WHO), Johns Hopkins Bloomberg, dan United States Agency for International Development (USAID) setidaknya merumuskan 9 hak pelayanan KB bagi individu atau keluarga, 9 hak tersebut telah dijelaskan dalam buku pedoman yang berjudul *Family Planning a Guidance for Service Providers*. 9 hak pelayanan KB tersebut adalah:

1. Tidak ada diskriminasi;
2. Ketersediaan pelayanan dan informasi tentang kontrasepsi;
3. Informasi dan pelayanan KB yang dapat diakses;
4. Informasi dan pelayanan yang dapat diterima;
5. Informasi dan pelayanan yang berkualitas;
6. Membantu membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap;
7. Menjaga kerahasiaan data pasien;
8. Partisipasi provider; dan
9. Akuntabilitas pelayanan (WHO et al., 2018).

Kontrasepsi digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, serta kontrasepsi digunakan pula untuk mengatur siklus menstruasi seseorang (Affandi, 2013; Schaapveld, A & Ineke, 2018; Shinta, 2013). Secara umum terdapat 7 jenis metode kontrasepsi yaitu:

1. Metode kontrasepsi hormonal jangka pendek, seperti pil, cincin vagina dan suntik;
2. Metode kontrasepsi hormonal jangka panjang, seperti *Intra Uterine Device* (IUD) progestin dan implan;
3. Metode kontrasepsi hormonal, seperti IUD;
4. Metode barrier non-hormonal, seperti kondom pria dan wanita;
5. Metode non-hormonal irreversibel, seperti *vasectomy* dan *tubectomy*;
6. Kontrasepsi darurat, seperti pil darurat, IUD *Copper* yang digunakan sesudah hubungan seksual;
7. Metode natural dan tradisional lainnya, seperti *koitus interruptus* dan menghitung masa (Affandi, 2013; Schaapveld, A & Ineke, 2018; Shinta, 2013).

Akses terhadap kontrasepsi adalah hal yang sangat esensial bagi kesejahteraan seseorang, di beberapa negara akses terhadap kontrasepsi sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi, geografi, sosial, budaya dan politik (Hulme,

Dunn, Guilbert, Soon, & Norman, 2015; Schaapveld, A & Ineke, 2018; WHO et al., 2018).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berdasarkan hasil Long Form SP2020 sebesar 189/100.000 kelahiran. Salah satu pendekatan untuk menurunkan AKI adalah *safe motherhood* yang memiliki empat pilar yaitu keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan sesuai standar, persalinan bersih dan aman serta PONEK dan PONEK. Dari empat pilar tersebut, pelayanan kontrasepsi melalui program keluarga berencana (KB) menjadi intervensi yang strategis dalam menurunkan AKI di Indonesia. (Maydianasari, 2023)

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi. (Rahmidini, Annisa. 2021). Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi. Salah satu indikator tercapainya program KB yaitu meningkatnya jumlah akseptor KB (Kemenkes RI, 2019).

Setiap pasangan yang menggunakan kontrasepsi dilandasi permintaan KB yang jelas, baik untuk menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan atau tidak ingin punya anak lagi. Kejelasan maksud tersebut terkait dengan tersedianya teknologi kontrasepsi sesuai dengan keamanan medis serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan, efektivitas, dan efisiensi metode kontrasepsi (Dhillon et al., 2020; Handayani et al., 2013).

Penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di Indonesia menurut tren data SDKI masih tergolong lambat dan cenderung stagnan karena rata-rata penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi selama 5 tahun hanya sebesar 1-2 persen. *United Nation* (2017) memproyeksikan angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di Indonesia pada tahun 2030 mencapai 11,4 persen. Sedangkan, target penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dalam SDGs Indonesia pada tahun 2030 diharapkan mampu mencapai angka 5,8 persen. (Maghfirah, 2024)

Program KB diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kelahiran dan angka kematian sehingga pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan laju pembangunan di berbagai bidang. Salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program KB adalah akseptor yang berhenti pakai alat kontrasepsi (*drop out*). Meningkatnya angka *drop out* menyebabkan jumlah penduduk juga meningkat karena jumlah kelahiran tidak dapat dikendalikan sehingga tingkat kesejahteraan, kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan pembangunan bidang lainnya menjadi menurun. (Prihutomo, S.2018)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku drop out, salah satunya adalah faktor efek samping kontrasepsi. (Oktavia,S.2020) Penelitian Maydianasari (2023) memperkuat bahwa faktor penentu berhenti pakai (*drop out*) adalah masih takut akan efek samping alat kontrasepsi. Pengetahuan terhadap jenis kontrasepsi termasuk efek sampingnya terbukti menjadi faktor resiko perilaku drop out KB. (Ardhanie, 2023) Efek samping penggunaan kontrasepsi ada yang dapat diatasi oleh akseptor sehingga dapat bertahan untuk tetap menggunakannya, namun ada juga efek samping yang tidak dapat diatasi dan terasa berat serta mengganggu, akibatnya akseptor cenderung untuk berhenti pakai alat kontrasepsi tersebut.

Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang efek samping kontrasepsi memunculkan ide untuk merancang aplikasi berbasis android untuk meningkatkan pengetahuan akseptor tentang efek samping penggunaan kontrasepsi sehingga dapat mencegah drop out. Saat ini, sistem operasi android telah digunakan secara luas. Sistem yang open source code menjadikan smartphone dengan sistem android paling banyak digunakan dibandingkan dengan system operasi smartphone lainnya karena memudahkan para pengembang untuk membuat dan memodifikasi aplikasi yang belum tersedia di sistem android sesuai kebutuhan. (Herlambang, S.2018)

C. Aplikasi Digital

Penerapan teknologi digital medis dapat memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas perawatan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Salah satu perangkat *mobile* yang paling pesat adalah *handphone* dan hampir setiap orang memilikinya. Fungsi utama handphone sebenarnya adalah alat komunikasi, namun saat ini dengan berbagai fitur didalamnya seperti pengolah dokumen, penampil gambar dan teknologi *smartphone* yang sedang menjadi tren saat ini adalah adanya sistem operasi berbasis android yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi yang dinilai dapat memberikan kemudahan, efisien dan keuntungan bagi penggunaanya (Noviyanto et al., 2012).

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi berbasis android ini sangat mungkin untuk dikembangkan sistem yang menggantikan peran seorang tenaga ahli dibidang kesehatan seperti pada masa pandemi covid saat ini untuk membatasi kontak langsung antara pasien dengan petugas kesehatan maka dibuat aplikasi kontrasepsi berbasis android yang memuat fitur-fitur seperti media sosialisasi kesehatan melalui kumpulan-kumpulan artikel kontrasepsi serta menu tanya jawab antara bidan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasien (Dayer et al., 2013).

Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi yang terdapat dalam *smartphone* sangat menarik karena dirancang efisien untuk digunakan dan dengan aplikasi bisa memudahkan untuk berinteraksi antara Ibu dan bidan serta meningkatkan kepuasan ibu dalam menerima pelayanan kesehatan dari bidan sehingga meningkatkan pengetahuan serta kesadaran ibu untuk patuh dalam melakukan kegiatan ber-KB secara berkelanjutan (Dayer et al., 2013). Kedua tingkat paparan dikaitkan dengan kemungkinan lebih tinggi bagi ibu untuk melaporkan bahwa petugas lapangan mendiskusikan pilihan kontrasepsi, efek samping kontrasepsi, dan manajemen efek samping kontrasepsi dibandingkan dengan ibu yang tidak terpapar. Ibu dalam kelompok paparan tinggi memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan ibu yang tidak terpapar.

Kepuasan aplikasi konsultasi kontrasepsi ini menunjukkan pada kategori puas dengan hasil perhitungan IKP (Indek Kepuasan Pengguna) 83,4 %. Kepuasan responden didefinisikan sebagai respon PUS terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian aplikasi kontrasepsi. Efek selanjutnya dari kepuasan aplikasi ini akan berlanjut pada proses meningkatnya pengetahuan PUS serta membantu tenaga kesehatan dalam mencapai target program Keluarga Berencana (KB).

Media aplikasi yang merupakan bagian dari Teknologi Informasi (TI) memiliki peranan penting dalam memudahkan penyebaran. Media aplikasi dapat menyampaikan informasi lebih cepat serta menjangkau khalayak lebih luas dengan biaya yang lebih murah serta memberikan kemudahan akses bagi publik dalam menerima informasi. Demikian juga dalam pelayanan khususnya dalam kesehatan, pelayanan kontrasepsi. Pentingnya keikutsertaan Wanita PUS dalam menggunakan alat kontrasepsi dengan penyuluhan interaktif berbasis teknologi informasi (TI) (Yusita et al. 2020).

Pada saat ini *smartphone* merupakan hal yang lumrah atau biasa digunakan bagi masyarakat luas. Perkembangan *smartphone* setiap tahunnya terus meningkat, khususnya bagi *smartphone* dengan operating sistem Android. Pada bulan Oktober 2017 pengguna *smartphone* dengan *operating system* Android mencapai jumlah 75% (Rahmidini and Hartiningrum 2021).

Berikut beberapa aplikasi yang tersedia di android yang berhubungan dengan pelayanan kontrasepsi:

1. Aplikasi Medical Eligibility Criteria For Contraceptive Use Medical Eligibility Criteria

Adalah kriteria kelayakan diluncurkan pelayanan oleh medis yang WHO untuk kontrasepsi. Tenaga kesehatan harus memberikan KIE berbasis bukti tentang keamanan metode kontrasepsi untuk wanita dengan karakteristik fisik

atau masalah medis tertentu (Allen, Cwiak, and Kaunitz 2013). Medical Eligibility Criteria atau disebut juga Kriteria Kelayakan Medis Kontrasepsi (KLOP) untuk versi Bahasa Indonesia merupakan lingkaran/diagram kontrasepsi yang berisi kriteria persyaratan medis untuk memulai penggunaan kontrasepsi Medical tertentu, Eligibility metode berdasarkan Criteria for Contraceptive Use, 5th edition (2015). Medical Eligibility Criteria akan mencocokkan kondisi medis wanita dengan metode-metode kontrasepsi tertentu yang sesuai. Diagram lingkaran ini terbagi dalam empat kategori yang menunjukkan apakah seorang wanita dapat menggunakan kontrasepsi tertentu atau tidak. Terdapat Empat kategori dalam aplikasi ini untuk rekomendasi pilihan metode kontrasepsi adalah:

- a. Kategori 1 Metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap kondisi
- b. Kategori 2 : Secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan
- c. Kategori 3 Penggunaan metode kontrasepsi biasanya tidak direkomendasikan terkecuali tidak ada metode lain yang tersedia atau dapat diterima oleh klien
- d. Kategori 4: Metode kontrasepsi tidak dapat digunakan

Aplikasi Medical Eligibility Criteria sangat berpengaruh bagi praktisi (tenaga kesehatan) dan pembuat kebijakan KB. Medical Eligibility Criteria memberikan rekomendasi terkini, berbasis bukti untuk penggunaan kontrasepsi bagi wanita dengan berbagai kondisi dan karakteristik medis yang sesuai (Altshuler, Gaffield, and Kiarie 2015). Pemanfaatan Medical Eligibility Criteria juga dilakukan dalam memberikan konseling untuk kontrasepsi IUD dan meningkatkan jumlah pengguna kontrasepsi IUD (Harper et al. 2012). Selain penapisan klien untuk kontrasepsi, pemilihan aplikasi ini metode juga digunakan untuk konseling dalam pelayanan kontrasepsi mengenai berbagai metode kontrasepsi yang ada. Menurut panduan yang dilansir dari Kemenkes RI, diagram lingkaran kontrasepsi ini meliputi rekomendasi penggunaan 11 tipe kontrasepsi yang umum digunakan, yaitu:

- a. Pil kombinasi
- b. Koyok (*patch*) kombinasi
- c. Cincin kombinasi vagina kontrasepsi kontrasepsi
- d. Kontrasepsi injeksi kombinasi
- e. Pil progestin
- f. Injeksi progestin
- g. Implan
- h. Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) – LNG
- i. Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) - Copper T
- j. Sterilisasi tubektomi

k. Sterilisasi vasektomi

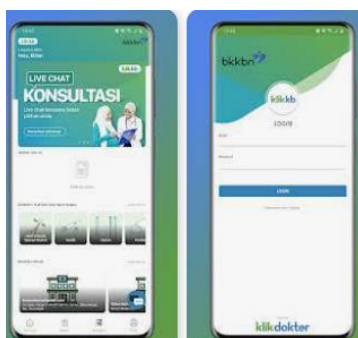


Gambar 1.1 Tampilan Aplikasi *Medical Eligibility*/KLOP

Penggunaan WHO Wheel Criteria lebih efektif terhadap pemilihan alat kontrasepsi masa dibandingkan dengan postpartum koseling menggunakan media ABPK-KB. Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu rekomendasi dalam penggunaan aplikasi WHO Wheel Criteria dalam upaya meningkatkan pemilihan kontasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan calon akseptor. Penelitian ini dapat dikembangkan menggunakan (Zakaria 2020). kelompok dengan kontrol Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pemanfaatan Media Medical Eligibility dalam meningkatkan faktor determinan pada PUS dalam berKB dengan cara membentuk peergroup terbukti bermakna secara signifikan. Artinya ada perbedaan antara kelompok yang diberi edukasi dengan media medical eligibility dengan yang diberi edukasi dengan media ABPK konvensional. Seperti dijelaskan sebelumnya banyak sekali faktor penyebab unmet need kontrasepsi salah satunya adalah belum maksimal edukasi kontrasepsi melalui media bantu yang mudah dipahami dan dimengerti oleh calon akseptor KB dan efektif mengubah perilaku dan sikap dalam berKB pada PUS (Nurchayani and Widyastuti 2020). Konseling KB merupakan proses pertukaran informasi dan interaksi positif antarklien dan petugas kesehatan untuk membantu klien atau calon akseptor KB dalam mengetahui kebutuhan kontrasepsi, metode terbaik dan memilih membuat keputusan mengenai kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan kondisi medis yang sedang dihadapi PUS (Saraswati et al. 2021). Jika konseling KB dilakukan secara optimal dan berkualitas, maka kebutuhan masyarakat akan informasi kontrasepsi akan terpenuhi.

2. Aplikasi KlikKB

Aplikasi klikKB merupakan aplikasi kontrasepsi berbasis TI yang diinisiasi oleh memudahkan BKKBN akseptor untuk KB mendapatkan pelayanan kontrasepsi pada masa pandemi Covid-19. Aplikasi klikKB diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia pada tanggal 26 September 2020. Aplikasi klikKB akan menghubungkan secara langsung antara akseptor KB dengan bidan dan memungkinkan akseptor mendapatkan informasi secara interaktif atau konseling dalam aplikasi klikKB (BKKBN 2020). Layanan yang tersedia dalam klikKB antara lain : layanan live chat dengan provider, informasi tempat pelayanan KB, alarm pengingat baik bagi provider maupun akseptor untuk pelayanan mendapatkan kontrasepsi ulangan. Sebelum mendapatkan pelayanan, peserta KB dapat membuat janji terlebih dahulu sehingga meminimalkan waktu tunggu. Upaya ini juga diharapkan membantu akseptor dalam mendapatkan alarm pengingat saat meminum pil KB setiap harinya.



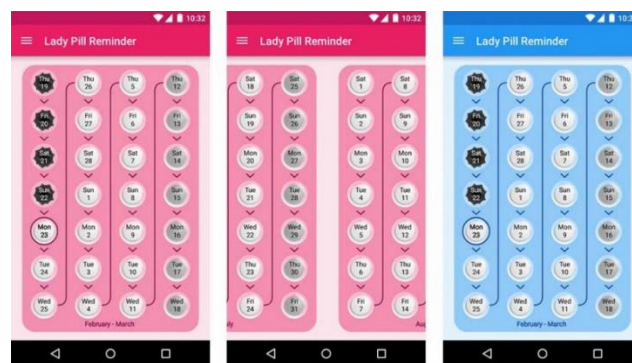
Gambar 1.2 Tampilan Aplikasi KlikKB di Android

Belum banyak penelitian tentang pemanfaatan aplikasi klikKB. Sebuah penelitian yang memanfaatkan aplikasi KlikKB dalam memberikan KIE kontrasepsi pada PUS menunjukkan hasil bahwa terjadinya peningkatan pengetahuan PUS setelah diberikan edukasi (Yusita et al. 2020). Pendampingan pengguna pelayanan Keluarga Berencana dengan jangkauan Virtual Outreach (VO) melalui dunia maya (internet) sangat dianjurkan dilakukan untuk menghindari tatap muka pada masa pandemi Covid-19 (Rawinarno, Alynudin, and Shafira 2021).

3. Aplikasi Lady Pill Reminder

Ketaatan WUS mengonsumsi pil KB bertujuan agar pil KB efektif untuk menunda kehamilan. Kepatuhan minum pil KB akan mencegah, menghambat dan menjarangkan terjadinya kehamilan. Ketidakpatuhan dalam mengonsumsi pil KB akan berisiko tinggi terjadinya kehamilan pada Wanita Usia Subur. Aplikasi Lady Pill Reminder merupakan salah satu teknologi informasi yang dapat

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama bagi pengguna kontrasepsi pil. Lady Pill Reminder merupakan salah satu bentuk aplikasi yang dibuat untuk membantu akseptor KB pil dalam membantu mengatur jadwal minum pil. Aplikasi android yang terdapat dalam telepon seluler yang selalu dibawa akan memberikan manfaat dan kemudahan untuk mengingat minum pil. Berdasarkan hasil penelusuran di google play, Lady Pill Reminder adalah aplikasi pengingat untuk minum pil KB yang mudah digunakan. Pengguna hanya perlu menunjukkan jenis pil KB yang digunakan (jumlah pil dalam paket) dan waktu biasa untuk meminum pil. Selanjutnya aplikasi Lady Pill Reminder akan mengingatkan pengguna kapan harus minum pil. Selain itu, pengguna juga dapat memeriksa status paket pil saat ini. Notifikasi pengingat dapat dinonaktifkan secara otomatis ketika pengguna tidak mengonsumsi pil KB. Aplikasi ini juga mengingatkan pengguna untuk membeli paket pil baru ketika paket pil sebelumnya hampir habis.



Gambar. 1.3 Tampilan Aplikasi *Lady Pill Reminder*

Terdapat pengaruh penggunaan aplikasi pengingat minum pil terhadap ketaatan minum obat KB oral di Puskesmas Bogorejo Kabupaten Blora karena nilai $p (0.000) < 0.05$. Aplikasi pengingat pil KB sangat efektif karena akseptor setiap saat diberikan notifikasi (pengingat) melalui *handphone*. Aplikasi memberikan kemudahan dalam memberikan peringatan untuk minum obat serta penggunaan aplikasi tersebut efektif dan efisien (Andriani, Nurul K, and Purwatiningsih 2021).

4. Aplikasi Family Planning

Aplikasi Keluarga Berencana ini tersedia dalam bahasa Inggris di android yang dirancang untuk memudahkan tenaga kesehatan berbagi informasi yang tidak bias tentang metode kontrasepsi. Aplikasi ini dapat membantu pengguna memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi, berbagai metode

kontrasepsi, keuntungan dan kerugian dari setiap metode, kontrasepsi darurat, dan banyak lagi. Fitur "Method Chooser" dapat membantu menentukan metode mana yang paling sesuai dengan preferensi individu, keadaan, dan riwayat kesehatan pengguna. Aplikasi ini masih sulit digunakan di Indonesia karena belum tersedia dalam bahasa Indonesia.



Gambar 1.4 Tampilan Aplikasi *Family Planning*

Belum ada penelitian tentang keefektifan penggunaan aplikasi ini di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran di android, aplikasi ini menyediakan fitur metode KB paling bagus, info umum tentang kontrasepsi, cara kerja berbagai metode kontrasepsi, penapisan melalui kuesioner yang disediakan, konseling dan fitur tanya jawab tentang pertanyaan yang sering muncul tentang kontrasepsi.

Alat bantu pengambilan keputusan (ABPK) ber-KB dengan digitalisasi akan lebih memudahkan bidan dan juga responden dalam mengambil Keputusan untuk melakukan atau memilih jenis KB. Pelatihan ABPK dengan digitalisasi dalam bentuk modul akan lebih memudahkan serta mempercepat pengambilan Keputusan serta peningkatan pemahaman tentang ABPK.

5. Aplikasi CERDIK

Aplikasi berbasis android Cegah Drop Out dengan Informasi Kewaspadaan (CERDIK) merupakan salah satu aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan akseptor KB untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang metode kontrasepsi modern maupun efek sampingnya sehingga bertambahnya angka drop out dapat ditekan. Sebagai aplikasi yang baru dirancang, maka diperlukan uji kelayakan sebelum penggunaan lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kelayakan aplikasi CERDIK.

Aplikasi CERDIK menyediakan empat fitur pengguna yaitu informasi tentang aplikasi, metode kontrasepsi modern, keluhan/efek samping dan konsultasi. Pengguna aplikasi CERDIK dapat mengetahui informasi tentang aplikasi CERDIK

dengan menekan tombol lingkaran hijau, maka akan muncul tampilan menu yang disediakan oleh aplikasi. Tampilan muka dan menu aplikasi CERDIK dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

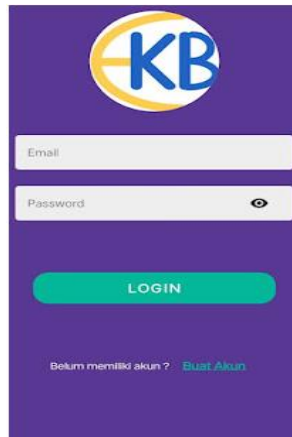


Gambar 1.5 Tampilan Muka dan Fitur Menu Aplikasi CERDIK

Aplikasi CERDIK dirancang untuk memberikan informasi tentang metode kontrasepsi dengan efek sampingnya agar membantu akseptor KB untuk mencegah berhenti pakai (*drop out*). Informasi yang disediakan oleh aplikasi adalah metode kontrasepsi modern meliputi Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR, implan, suntik, pil, kondom, tubektomi /MOW, vasektomi /MOP, dan Metode Amenore Laktasi (MAL).(Maydianasari, 2023)

6. Aplikasi e-KABE

Aplikasi KB yang sudah tersedia di playstore dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-KABE ini berbeda dengan aplikasi KB yang sudah ada, pada umumnya aplikasi KB yang ada tidak terintegrasi masih terpisah-pisah sedangkan pada aplikasi ini terdapat beberapa jenis alat kontrasepsi serta ada program reminder sebagai pengingat penggunaan alat kontrasepsi. Perancangan aplikasi e-KABE ini diharapkan dapat mempermudah bidan dalam memberikan pelayanan KB dan pendataan jumlah WUS yang ber KB sedangkan bagi akseptor KB dapat mempermudah dalam penggunaan alat kontrasepsi terutamanya pada akseptor KB pil dan suntik karena ada menu notifikasi sebagai pengingat akseptor KB baik untuk minum pil KB maupun kunjungan ulang suntik KB. Oleh karena itu, peneliti ingin berinisiatif untuk menganalisis efektifitas e-KABE terhadap kesesuaian penggunaan alat kontrasepsi.



Gambar 1.6 Tampilan Aplikasi e-KABE

D. Penutup

Beberapa aplikasi berbasis digital tersedia di playstore android, yakni Medical Eligibility for Contraceptive Use, Lady Pill Reminder, Family Planning, klikKB, CERDIK, e-KABE, dll. Pemanfaatan media digital ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan faktor determinan calon akseptor KB dalam memilih kontrasepsi, terutama MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Pemanfaatan perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komputer) berhubungan negatif dengan unmet need KB total, untuk menjarangkan dan membatasi kelahiran. Penggunaan internet berhubungan positif dengan unmet need KB total dan untuk menjarangkan kelahiran, namun berhubungan negatif untuk membatasi kelahiran. Akses ke pelayanan KB berhubungan negatif dengan unmet need KB total dan untuk membatasi kelahiran. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa untuk menurunkan peluang wanita mengalami unmet need KB bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pemanfaatan TIK dan akses ke pelayanan KB. (Magfirah, 2024)

Perlunya rekomendasi kebijakan terkait peningkatan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komputer) dalam program KB yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu Pemerintah dapat menentukan tarif yang lebih rendah dari penyedia telekomunikasi sektor swasta untuk layanan televisi berbayar, harga pulsa telepon seluler yang tergolong mahal, dan aplikasi KB yang berbayar. Sehingga, seluruh wanita dapat mengakses program televisi dan memanfaatkan telepon seluler untuk program perencanaan keluarga.

Referensi

- Ardhanie S, Fitriyah NN, Hayuningsih P. Determinan Perilaku Drop Out KB di Jawa Timur Berdasarkan Teori Lawrence Green. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*; 2023. p. 1496-1503.
- Handayani, L., Suharmiati, S., Hariastuti, I., & Latifah, C. (2013). Peningkatan Informasi Tentang KB: Hak Kesehatan Reproduksi yang Perlu Diperhatikan oleh Program Pelayanan Keluarga Berencana. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. <https://doi.org/10.22435/bpsk.v15i3>
- Herlambang S. (2018). Deteksi Malware Android Berdasarkan System Call Menggunakan Algoritma Support Vector Machine.
- Kemenkes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Litha, Y. (2020). Kemiskinan Akibat Pandemi Corona Picu Kerawanan Gizi Anak. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/kemiskinan-akibat-pandemi-corona-picu-kerawanan-gizi-anak/5415460.html>
- Maghfirah, Maghfirah; Samosir, Omas Bulan; and Djutaharta, Triasih (2024) "Pemanfaatan TIK dan Akses Terhadap Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi," *Jurnal Ekonomi Kependudukan dan Keluarga: Vol. 1, Article 6*. DOI: 10.7454/jekk.v1i2.02 <https://scholarhub.ui.ac.id/jekk/vol1/iss2/6>
- Maydianasari L, Wantini NA, Rahmuniyati ME, Maranresy M, Handayani F. (2023). Faktor Penentu Berhenti Pakai (Drop Out) Alat Kontrasepsi pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati*; p. 156-165.
- Nurchayani L WD. (2020). Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB Digital sebagai Konseling Inovasi Media Konseling Keluarga Berencana. *J Ilm Bidan*.
- Priohutomo S.(2018) Kebijakan dan Strategi Program KKBPK Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu". Jakarta: BKKBN.
- Rahmidini, Annisa. (2021). Analisis Kesesuaian Penggunaan Alat Kontrasepsi Dengan Tujuan BerKB menggunakan Aplikasi e-KABE
- Oktavia S. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Drop Out Akseptor KB di Puskesmas Dukun. *Swara Bumi*; p. 1-9. (6)
- WHO, Johns Hopkins Bloomberg, & USAID. (2018). *Family Planning* (3rd ed.). Geneva: United States Agency for International Development Bureau for Global Health Office of Population and Reproductive Health

BAB IV

STRATEGI KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN REPRODUKSI SEHAT

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Strategi Berbasis Komunitas dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga, khususnya pada pasangan usia subur. Salah satu pendekatan efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi adalah melalui penerapan strategi berbasis komunitas. Strategi ini memanfaatkan sumber daya lokal, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan memperhitungkan konteks sosial budaya setempat, sehingga intervensi edukasi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Hartono & Yulianingsih, 2023; Afifah, Suhartini, & Setyowati, 2021).

Strategi berbasis komunitas terbukti mampu memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola isu kesehatan reproduksi melalui peningkatan pengetahuan, sikap positif, serta partisipasi aktif anggota masyarakat (Kusumaningrum & Budiastuti, 2020). Keterlibatan komunitas juga memungkinkan deteksi dini berbagai masalah kesehatan reproduksi, sehingga intervensi bisa dilakukan secara tepat waktu. Menurut World Health Organization (WHO, 2022), partisipasi komunitas mampu meningkatkan efektivitas program edukasi hingga mencapai target cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan yang lebih individualistik.

Selain itu, strategi berbasis komunitas memanfaatkan peran penting tokoh masyarakat yang dipercaya, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin informal lainnya. Melibatkan tokoh-tokoh tersebut sangat strategis, terutama dalam konteks budaya Indonesia, yang masyarakatnya cenderung lebih mempercayai informasi yang berasal dari tokoh yang dihormati di lingkungannya (Wulandari & Indarwati, 2022). Dengan demikian, strategi ini sangat relevan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan mendukung perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam menjaga kesehatan reproduksi.

2. Tantangan Umum yang Dihadapi dalam Peningkatan Kesadaran Reproduksi

Meskipun pendekatan berbasis komunitas memiliki berbagai keuntungan, implementasinya di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan. Pertama,

terdapat hambatan sosial budaya seperti stigma, tabu, dan miskonsepsi tentang kesehatan reproduksi yang masih kuat melekat di masyarakat. Stigma ini membuat masyarakat enggan membicarakan masalah reproduksi secara terbuka, bahkan dalam lingkup keluarga sekalipun, sehingga informasi yang benar sulit diterima atau disebarluaskan (Nasution & Dewi, 2022).

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, seperti kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dan terbiasa dengan pendekatan komunitas, sering menjadi penghambat utama. Banyak tenaga kesehatan di komunitas masih terbatas kemampuannya dalam menggunakan pendekatan partisipatif dan kurang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif (Rahayu & Sukirman, 2021). Akibatnya, kegiatan edukasi tidak berjalan optimal atau kurang memberikan dampak signifikan.

Ketiga, tantangan terkait keterbatasan dana dan infrastruktur pendukung juga menjadi kendala nyata di banyak wilayah, khususnya di daerah terpencil. Rendahnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dasar serta kurangnya dukungan logistik seperti alat peraga dan media edukasi yang efektif menyebabkan kegiatan edukasi kesehatan reproduksi kurang maksimal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Keempat, kurangnya keterlibatan pria dalam program kesehatan reproduksi juga merupakan isu krusial. Sebagian besar intervensi kesehatan reproduksi masih berfokus pada perempuan, sementara laki-laki kurang dilibatkan, padahal mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi dan keluarga (Kusumaningrum & Budihastuti, 2020).

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, hingga partisipasi aktif masyarakat secara umum. Kolaborasi lintas sektor yang kuat akan menjadi faktor kunci keberhasilan dalam implementasi program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas.

B. Model dan Pendekatan Strategi Berbasis Komunitas

1. Model Edukasi Kesehatan Berbasis Komunitas

Model edukasi kesehatan berbasis komunitas merupakan suatu pendekatan yang menempatkan komunitas sebagai mitra aktif dalam proses edukasi kesehatan. Model ini bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan komunitas melalui partisipasi langsung dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan edukasi (Hartono & Yulianingsih, 2023). Karakteristik utama dari model ini adalah inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, dan penggunaan kearifan lokal sebagai basis pendekatan edukasi.

Penerapan model ini telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman komunitas tentang kesehatan reproduksi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Indarwati (2022) mengungkapkan bahwa penggunaan model edukasi yang melibatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat mampu meningkatkan tingkat penerimaan informasi dan perilaku kesehatan reproduksi secara berkelanjutan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021) juga merekomendasikan model ini sebagai pendekatan efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat di berbagai daerah.

2. Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam Kesehatan Reproduksi

Participatory Action Research (PAR) adalah pendekatan riset partisipatif yang menekankan kolaborasi antara peneliti dengan anggota komunitas dalam setiap tahap penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi (Rahayu & Sukirman, 2021). Pendekatan ini cocok diterapkan dalam edukasi kesehatan reproduksi karena memungkinkan masyarakat untuk secara aktif mengidentifikasi masalah kesehatan reproduksi mereka sendiri serta merancang solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

PAR memiliki beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, perencanaan aksi, implementasi aksi, observasi, dan refleksi evaluatif. Setiap tahapan dilakukan secara kolaboratif antara komunitas dan peneliti, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan tepat sasaran. Sebuah penelitian oleh Nasution dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa penerapan PAR dalam komunitas yang memiliki hambatan budaya mampu meningkatkan pemahaman serta keterlibatan aktif masyarakat dalam isu-isu kesehatan reproduksi, terutama dalam mengurangi stigma terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

3. Community-Based Participatory Research (CBPR): Aplikasi dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi

Community-Based Participatory Research (CBPR) adalah pendekatan riset yang serupa dengan PAR, namun secara spesifik menekankan pentingnya partisipasi komunitas dalam konteks kemitraan yang setara antara komunitas dan akademisi atau tenaga kesehatan. Tujuan utama CBPR adalah membangun kapasitas komunitas untuk meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara berkelanjutan, termasuk dalam kesehatan reproduksi (Afifah, Suhartini, & Setyowati, 2021).

Penerapan CBPR dalam konteks edukasi kesehatan reproduksi telah terbukti efektif di berbagai komunitas. Menurut Kusumaningrum dan Budiastuti (2020), implementasi CBPR dalam edukasi berbasis pasangan berhasil meningkatkan

komunikasi dan kesadaran pasangan usia subur terhadap praktik reproduksi sehat secara signifikan. Hal ini dikarenakan pendekatan ini mampu mengidentifikasi hambatan sosial budaya yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran kesehatan reproduksi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak jangka panjang.

Selain itu, penerapan CBPR mendorong komunitas untuk lebih proaktif dalam mengambil keputusan tentang kesehatan reproduksi, menciptakan rasa kepemilikan terhadap program, dan menjamin keberlanjutan hasil edukasi. Menurut World Health Organization (2022), pendekatan CBPR dapat memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas secara keseluruhan karena adanya peningkatan kapasitas, kepercayaan, dan dukungan timbal balik antara masyarakat dengan penyedia layanan kesehatan.

Dengan demikian, baik model edukasi berbasis komunitas, PAR, maupun CBPR memberikan berbagai pilihan pendekatan yang komprehensif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan program edukasi tidak hanya tergantung pada konten edukasi, tetapi juga bagaimana komunitas secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan diri.

C. Pemetaan Kebutuhan Kesehatan Reproduksi di Komunitas

1. Teknik Asesmen Kebutuhan Kesehatan Reproduksi di Masyarakat

Asesmen kebutuhan kesehatan reproduksi merupakan langkah kritis yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan program edukasi dan intervensi kesehatan berbasis komunitas. Tujuan asesmen ini adalah untuk mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, serta memahami secara mendalam tentang kebutuhan aktual masyarakat. Proses asesmen yang sistematis dan partisipatif akan menghasilkan data yang akurat dan relevan, sehingga program kesehatan reproduksi dapat dirancang sesuai kondisi nyata masyarakat (Hartono & Yulianingsih, 2023).

Beberapa teknik utama yang digunakan dalam asesmen kebutuhan kesehatan reproduksi di masyarakat meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam (in-depth interviews), diskusi kelompok terfokus (focus group discussion, FGD), serta survei menggunakan kuesioner terstandarisasi. Observasi lapangan berguna untuk memperoleh data langsung tentang kondisi fisik, sosial, dan lingkungan komunitas, sedangkan wawancara mendalam dan FGD lebih efektif untuk menggali informasi kualitatif terkait persepsi, keyakinan, dan pengalaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi (Rahayu & Sukirman, 2021).

Selain metode kualitatif, survei menggunakan kuesioner juga menjadi pendekatan penting dalam asesmen kebutuhan komunitas. Teknik ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat secara kuantitatif. Dengan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif, asesmen kebutuhan dapat memberikan gambaran komprehensif yang sangat membantu dalam perancangan intervensi yang efektif (Wulandari & Indarwati, 2022).

2. Studi Kasus Aplikasi Pemetaan Kebutuhan di Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Pemetaan kebutuhan kesehatan reproduksi berbeda-beda tergantung konteks geografis, budaya, dan sosial ekonomi masyarakat. Untuk lebih memahami perbedaan ini, beberapa studi kasus berikut menggambarkan bagaimana pemetaan kebutuhan dilakukan di daerah perkotaan dan pedesaan.

Di daerah perkotaan, tantangan kesehatan reproduksi cenderung berkaitan dengan tingginya mobilitas, pola hidup modern, serta akses informasi yang luas tetapi sering kali tidak akurat. Penelitian oleh Kusumaningrum dan Budihastuti (2020) di kota besar seperti Jakarta menunjukkan bahwa pemetaan kebutuhan dilakukan melalui survei digital dan FGD dengan kelompok usia subur muda. Hasilnya menunjukkan bahwa isu utama yang muncul adalah tingginya prevalensi perilaku seksual berisiko, kebutuhan mendesak akan informasi kesehatan reproduksi yang valid, serta pentingnya layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja dan pasangan muda.

Sebaliknya, di daerah pedesaan, pemetaan kebutuhan menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, serta kuatnya nilai tradisional yang dapat menjadi penghambat komunikasi terbuka tentang kesehatan reproduksi. Studi yang dilakukan Afifah, Suhartini, dan Setyowati (2021) di pedesaan Jawa Tengah menggunakan teknik wawancara mendalam dan FGD bersama tokoh masyarakat. Studi ini mengungkap bahwa isu dominan meliputi rendahnya pemahaman tentang metode kontrasepsi modern, kehamilan tidak diinginkan, serta keterbatasan akses layanan kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, rekomendasi utama dari studi tersebut adalah perlunya edukasi berbasis budaya lokal serta peningkatan kapasitas kader kesehatan desa.

Studi kasus ini menggambarkan bahwa pendekatan pemetaan kebutuhan yang tepat sesuai karakteristik wilayah sangat menentukan efektivitas intervensi kesehatan reproduksi yang direncanakan. Pemahaman tentang kebutuhan spesifik komunitas memungkinkan intervensi kesehatan reproduksi dirancang secara lebih relevan, diterima masyarakat, serta berkelanjutan.

D. Pelibatan Tokoh Masyarakat dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi

1. Peran Strategis Tokoh Masyarakat dalam Peningkatan Kesadaran Reproduksi

Pelibatan tokoh masyarakat dalam edukasi kesehatan reproduksi merupakan pendekatan strategis yang dapat secara efektif meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan reproduksi masyarakat. Tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun pemimpin informal lainnya, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini, norma sosial, serta keputusan yang terkait dengan kesehatan masyarakat (Wulandari & Indarwati, 2022). Dalam konteks budaya Indonesia, tokoh-tokoh tersebut dipandang sebagai sumber informasi yang terpercaya dan dihormati oleh komunitasnya, sehingga pesan-pesan kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh mereka lebih mudah diterima oleh masyarakat (Hartono & Yulianingsih, 2023).

Menurut Afifah, Suhartini, dan Setyowati (2021), tokoh masyarakat mampu menjembatani kesenjangan antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang sensitif seperti masalah reproduksi. Mereka mampu menyampaikan pesan kesehatan dengan bahasa dan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Peran strategis ini semakin penting, terutama di daerah pedesaan atau komunitas dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah, di mana persepsi negatif dan tabu terhadap isu-isu reproduksi masih cukup kuat (Nasution & Dewi, 2022).

2. Contoh Kasus Keberhasilan Pelibatan Tokoh Agama dan Adat dalam Edukasi Reproduksi Sehat

Pelibatan tokoh agama dan adat dalam edukasi kesehatan reproduksi telah menunjukkan berbagai keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan perilaku positif di masyarakat. Salah satu contoh keberhasilan terjadi dalam studi kasus di wilayah urban Jawa Timur oleh Wulandari dan Indarwati (2022). Tokoh agama setempat secara aktif terlibat dalam kampanye kesehatan reproduksi melalui ceramah agama yang dikombinasikan dengan sesi diskusi informal. Hasil studi menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama secara signifikan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, khususnya dalam mencegah kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual (IMS).

Contoh lain di komunitas adat di Kalimantan Barat, sebagaimana diungkapkan oleh Rahayu dan Sukirman (2021), menunjukkan keberhasilan serupa melalui peran tokoh adat. Pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan tokoh adat dalam mengintegrasikan edukasi kesehatan reproduksi dalam acara adat setempat. Tokoh adat memainkan peran penting

dalam memberikan pesan-pesan tentang perencanaan keluarga, pentingnya persalinan aman, dan pencegahan komplikasi kehamilan. Studi ini menemukan bahwa metode tersebut efektif karena pesan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan nilai dan tradisi lokal, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap informasi baru terkait kesehatan reproduksi.

Selanjutnya, penelitian oleh Hartono dan Yulianingsih (2023) menunjukkan efektivitas pelibatan tokoh agama dalam kampanye pencegahan stunting dan kehamilan remaja di beberapa desa di Jawa Tengah. Tokoh agama di desa-desa tersebut rutin memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi yang tepat selama kehamilan dan pola asuh yang baik melalui forum pengajian dan pertemuan masyarakat, menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan dalam waktu relatif singkat.

Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa pelibatan tokoh agama dan adat dalam edukasi kesehatan reproduksi sangat efektif, terutama dalam lingkungan sosial yang masih dipengaruhi oleh norma budaya dan agama. Keberhasilan ini memperlihatkan pentingnya membangun kemitraan strategis antara tenaga kesehatan dengan tokoh masyarakat untuk mencapai tujuan peningkatan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan.

E. Pengembangan dan Implementasi Media Edukasi yang Efektif

1. Strategi Pengembangan Media Edukasi yang Berbasis Budaya Lokal

Pengembangan media edukasi yang berbasis budaya lokal merupakan pendekatan penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kesehatan reproduksi. Strategi ini menekankan bahwa pesan-pesan edukasi disusun dengan mempertimbangkan nilai, norma, bahasa, serta konteks budaya yang spesifik di komunitas sasaran. Dengan demikian, pesan yang disampaikan menjadi lebih relevan, mudah diterima, dan memiliki dampak signifikan dalam perubahan perilaku (Hartono & Yulianingsih, 2023).

Beberapa langkah strategis dalam pengembangan media edukasi berbasis budaya lokal mencakup identifikasi nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku, kolaborasi aktif dengan tokoh masyarakat, serta adaptasi materi edukasi ke dalam bentuk yang familiar dan nyaman bagi komunitas. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Afifah, Suhartini, dan Setyowati (2021) di daerah pedesaan menunjukkan bahwa penggunaan media edukasi dalam bentuk cerita rakyat, drama pendek, serta visualisasi yang mencerminkan situasi lokal mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi secara efektif.

Penelitian lain oleh Rahayu dan Sukirman (2021) menunjukkan bahwa media edukasi berbentuk video yang menampilkan tokoh lokal dan menggunakan dialek daerah mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan kesehatan reproduksi, terutama dalam topik sensitif seperti penggunaan kontrasepsi dan persalinan aman. Oleh karena itu, pendekatan budaya dalam pengembangan media edukasi dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan umum yang kurang memperhatikan konteks lokal.

2. Evaluasi Efektivitas Media Komunikasi seperti Video Edukatif, Pamflet, dan Media Sosial

Evaluasi efektivitas media edukasi merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa media komunikasi yang digunakan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat. Berbagai bentuk media komunikasi seperti video edukatif, pamflet, dan media sosial memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dievaluasi secara sistematis (Kusumaningrum & Budihastuti, 2020).

Video edukatif, sebagai salah satu bentuk media audiovisual, memiliki keunggulan dalam menyampaikan pesan secara menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki tingkat literasi rendah. Studi yang dilakukan oleh Hartono dan Yulianingsih (2023) menunjukkan bahwa video edukatif yang menyajikan konten visual yang jelas dan narasi sederhana dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi secara signifikan dibandingkan metode edukasi konvensional.

Pamflet atau brosur juga merupakan media yang banyak digunakan dalam edukasi kesehatan reproduksi. Kelebihan pamflet adalah mudah didistribusikan, biaya relatif rendah, dan efektif dalam memberikan informasi ringkas. Namun, efektivitas pamflet bergantung pada desain visual yang menarik dan jelas, serta bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran edukasi (Wulandari & Indarwati, 2022). Evaluasi oleh Nasution dan Dewi (2022) menemukan bahwa pamflet dengan desain visual yang sesuai budaya lokal memiliki tingkat penerimaan dan retensi informasi yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dibandingkan pamflet umum.

Selain itu, media sosial kini semakin populer digunakan dalam edukasi kesehatan reproduksi, terutama untuk menjangkau kelompok muda atau populasi urban yang aktif secara digital. Media sosial memungkinkan interaksi dua arah yang intensif, penyebaran informasi secara cepat dan luas, serta mudah untuk diakses. Studi Kusumaningrum dan Budihastuti (2020) menunjukkan bahwa

kampanye kesehatan reproduksi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pengguna dalam isu-isu kesehatan reproduksi, meskipun tantangan berupa hoaks dan misinformasi perlu terus diatasi melalui konten edukasi yang kredibel dan konsisten.

Dengan demikian, evaluasi secara berkelanjutan terhadap berbagai media komunikasi penting dilakukan agar media edukasi yang digunakan selalu relevan, menarik, serta efektif dalam mencapai tujuan edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas.

F. Program Edukasi Berbasis Pasangan (Couple-Based Intervention)

1. Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Pasangan Usia Subur secara Berpasangan

Program edukasi kesehatan reproduksi berbasis pasangan (Couple-Based Intervention) merupakan pendekatan penting yang berfokus pada pelibatan kedua pasangan secara bersama-sama dalam proses edukasi kesehatan reproduksi. Pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa keputusan terkait kesehatan reproduksi, termasuk perencanaan keluarga, penggunaan kontrasepsi, dan perilaku seksual yang aman, sebaiknya didiskusikan dan diputuskan oleh pasangan secara bersama-sama. Pendekatan edukasi berbasis pasangan mampu meningkatkan komunikasi terbuka antara pasangan, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat dukungan emosional antar pasangan (Kusumaningrum & Budihastuti, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kedua pasangan dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas program kesehatan reproduksi dibandingkan edukasi yang hanya diberikan kepada individu, terutama dalam konteks budaya yang cenderung menempatkan keputusan reproduksi dalam konteks keluarga. Studi yang dilakukan oleh Rahayu dan Sukirman (2021) menemukan bahwa pasangan yang mengikuti program edukasi bersama menunjukkan peningkatan dalam komunikasi tentang metode kontrasepsi, persiapan kehamilan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesehatan reproduksi.

Selain itu, edukasi berbasis pasangan mampu memfasilitasi peningkatan kesadaran laki-laki yang selama ini sering kali kurang terlibat dalam urusan kesehatan reproduksi. Dengan melibatkan laki-laki secara aktif, edukasi ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan dalam pengambilan keputusan reproduksi, serta meningkatkan pemahaman laki-laki

mengenai perannya dalam menjaga kesehatan reproduksi pasangan dan keluarganya (Afifah, Suhartini, & Setyowati, 2021).

2. Studi Efektivitas Intervensi Berbasis Pasangan dalam Meningkatkan Komunikasi Reproduksi Sehat

Berbagai penelitian telah mendokumentasikan efektivitas intervensi berbasis pasangan dalam meningkatkan komunikasi dan perilaku reproduksi yang sehat di kalangan pasangan usia subur. Misalnya, sebuah studi oleh Kusumaningrum dan Budihastuti (2020) di daerah urban menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti edukasi bersama secara signifikan mengalami peningkatan dalam komunikasi mengenai pilihan metode kontrasepsi, serta menunjukkan perilaku seksual yang lebih aman dibandingkan pasangan yang tidak mengikuti intervensi berbasis pasangan.

Studi lain oleh Nasution dan Dewi (2022) menemukan bahwa edukasi berbasis pasangan secara efektif membantu mengatasi hambatan budaya dalam komunikasi reproduksi, terutama di komunitas yang memiliki tabu tinggi terhadap diskusi mengenai seksualitas dan kontrasepsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti program edukasi berbasis pasangan, pasangan cenderung lebih terbuka dalam mendiskusikan isu-isu sensitif tersebut, yang secara signifikan meningkatkan kesadaran dan pengambilan keputusan bersama dalam hal kesehatan reproduksi.

Penelitian yang dilakukan di pedesaan Jawa Tengah oleh Hartono dan Yulianingsih (2023) menunjukkan hasil yang konsisten. Pasangan yang terlibat dalam intervensi berbasis pasangan melaporkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan dukungan terhadap perilaku kesehatan reproduksi, seperti pemeriksaan antenatal bersama, persalinan di fasilitas kesehatan, dan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang.

Dari berbagai studi tersebut, jelas bahwa intervensi berbasis pasangan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan komunikasi yang sehat, mengurangi hambatan budaya dalam diskusi reproduksi, serta memperkuat kolaborasi pasangan dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka. Oleh karena itu, penerapan edukasi berbasis pasangan sangat direkomendasikan sebagai bagian penting dari program kesehatan reproduksi berbasis komunitas.

G. Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Kesehatan Reproduksi

1. Program Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan Kesadaran Reproduksi

Program pemberdayaan perempuan dalam konteks kesehatan reproduksi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan

keterampilan perempuan dalam membuat keputusan yang tepat tentang kesehatannya sendiri. Strategi pemberdayaan ini bertujuan mengurangi kerentanan perempuan terhadap risiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan tidak diinginkan, komplikasi kehamilan dan persalinan, serta infeksi menular seksual (Rahayu & Sukirman, 2021).

Pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi umumnya dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan perempuan secara langsung dalam setiap proses edukasi dan pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah model partisipatif seperti Participatory Action Research (PAR) atau Community-Based Participatory Research (CBPR), di mana perempuan berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi masalah kesehatan reproduksi, merancang solusi, serta mengimplementasikan intervensi yang sesuai kebutuhan mereka (Afifah, Suhartini, & Setyowati, 2021).

Menurut Hartono dan Yulianingsih (2023), pendekatan pemberdayaan yang berbasis komunitas dan kearifan lokal efektif dalam meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya kesehatan reproduksi, terutama di komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan formal. Dengan memberdayakan perempuan, mereka menjadi lebih percaya diri untuk mengambil keputusan tentang kesehatan reproduksinya sendiri, serta mampu secara aktif menyebarkan informasi kesehatan ke lingkungannya.

2. Studi Efektivitas Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Kelompok Ibu-Ibu (Mother's Group)

Salah satu bentuk intervensi pemberdayaan perempuan yang terbukti efektif dalam konteks kesehatan reproduksi adalah melalui kegiatan kelompok ibu-ibu atau mother's group. Kelompok ini menjadi forum di mana perempuan secara berkala bertemu, berdiskusi, saling bertukar pengalaman, serta memperoleh edukasi mengenai kesehatan reproduksi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka (Kusumaningrum & Budihastuti, 2020).

Penelitian oleh Wulandari dan Indarwati (2022) di daerah urban menunjukkan bahwa intervensi melalui kelompok ibu-ibu berhasil meningkatkan kesadaran dan praktik kesehatan reproduksi secara signifikan. Kegiatan edukasi dalam kelompok ibu-ibu tersebut mencakup diskusi terstruktur, demonstrasi praktis mengenai penggunaan alat kontrasepsi, perawatan kesehatan antenatal, serta pengenalan tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan pasca-persalinan.

Studi lain oleh Rahayu dan Sukirman (2021) di komunitas pedesaan menemukan bahwa kelompok ibu-ibu tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman perempuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, tetapi juga

memperkuat solidaritas dan dukungan sosial di antara anggota kelompok. Keberhasilan ini dicapai melalui sesi interaktif yang secara aktif melibatkan peserta dalam proses pembelajaran, serta dukungan emosional antar anggota dalam menghadapi tantangan kesehatan reproduksi.

Selain meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, kelompok ibu-ibu juga terbukti meningkatkan keterampilan advokasi perempuan di komunitas. Studi oleh Nasution dan Dewi (2022) menemukan bahwa perempuan yang aktif dalam kelompok ibu-ibu memiliki kapasitas lebih baik dalam menyuarakan kebutuhan mereka kepada tokoh masyarakat maupun tenaga kesehatan. Mereka juga lebih mampu mengadvokasi perubahan kebijakan atau program yang mendukung kesehatan reproduksi perempuan secara luas.

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan melalui kelompok ibu-ibu merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi sekaligus memperkuat kapasitas perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya secara mandiri dan berkelanjutan.

H. Evaluasi Dampak dan Keberlanjutan Program Edukasi Komunitas

1. Indikator Evaluasi Efektivitas Program Edukasi Kesehatan Reproduksi

Evaluasi merupakan bagian integral dari setiap program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas. Evaluasi yang sistematis dan terstruktur membantu untuk mengukur efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa depan (Hartono & Yulianingsih, 2023). Beberapa indikator penting dalam evaluasi efektivitas program kesehatan reproduksi meliputi indikator perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program yang dilaksanakan.

Pertama, indikator perubahan pengetahuan dapat diukur melalui survei sebelum dan sesudah intervensi, menilai peningkatan pemahaman peserta mengenai isu-isu kesehatan reproduksi seperti perencanaan keluarga, penggunaan kontrasepsi, tanda bahaya kehamilan, serta penyakit menular seksual (Kusumaningrum & Budihastuti, 2020).

Kedua, indikator sikap berkaitan dengan perubahan persepsi masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Penelitian oleh Nasution dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa evaluasi sikap dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, mengukur sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung praktik kesehatan reproduksi yang sebelumnya dianggap tabu atau sensitif.

Ketiga, indikator perubahan perilaku adalah yang paling penting, karena perubahan perilaku merupakan tujuan akhir dari edukasi kesehatan reproduksi. Indikator ini meliputi tingkat penggunaan kontrasepsi, jumlah kunjungan antenatal dan postnatal, pemilihan tempat persalinan yang aman, serta partisipasi dalam pemeriksaan kesehatan reproduksi rutin (Wulandari & Indarwati, 2022).

Terakhir, tingkat partisipasi komunitas dalam program juga menjadi indikator penting efektivitas intervensi. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan edukasi menunjukkan penerimaan dan relevansi program, yang berdampak pada keberlanjutan program edukasi tersebut (Rahayu & Sukirman, 2021).

2. Strategi Mempertahankan Keberlanjutan Program Edukasi Berbasis Komunitas

Keberlanjutan adalah aspek krusial dari program edukasi kesehatan reproduksi, yang bertujuan memastikan manfaat program tetap dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mencapai keberlanjutan tersebut, beberapa strategi utama perlu dilakukan.

Pertama, membangun kapasitas lokal dengan melatih kader-kader kesehatan dari komunitas setempat sangat efektif dalam menjaga keberlanjutan program. Menurut penelitian oleh Afifah, Suhartini, dan Setyowati (2021), pelatihan kader lokal memberikan kemandirian komunitas dalam menjalankan edukasi kesehatan reproduksi secara mandiri, bahkan setelah intervensi formal berakhir.

Kedua, integrasi program edukasi ke dalam struktur dan sistem komunitas yang sudah ada merupakan strategi penting lainnya. Misalnya, memasukkan edukasi kesehatan reproduksi dalam kegiatan rutin desa, pertemuan ibu-ibu, atau kegiatan kelompok agama setempat dapat memastikan bahwa edukasi terus berjalan sebagai bagian dari aktivitas reguler komunitas (Hartono & Yulianingsih, 2023).

Ketiga, dukungan dan kemitraan lintas sektor juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program. Kerjasama yang kuat antara komunitas dengan pemerintah lokal, lembaga kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta dapat menyediakan sumber daya yang cukup dan memastikan adanya dukungan struktural jangka panjang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Keempat, penyediaan sumber daya berkelanjutan seperti materi edukasi, alat bantu komunikasi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa program dapat terus berjalan dan berkembang. World Health Organization (2022) menyatakan bahwa

keberlanjutan program edukasi berbasis komunitas sangat tergantung pada adanya sumber daya yang berkelanjutan dan pengelolaan yang baik.

Dengan demikian, evaluasi yang sistematis dan strategi yang tepat dalam mempertahankan keberlanjutan merupakan kunci utama keberhasilan program edukasi kesehatan reproduksi di komunitas, sehingga memberikan dampak yang luas dan bertahan lama.

I. Hambatan dan Tantangan Implementasi Strategi Komunitas

1. Hambatan Struktural dan Sosial Budaya dalam Implementasi Edukasi Kesehatan Reproduksi

Implementasi program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas sering menghadapi berbagai hambatan struktural maupun sosial budaya yang kompleks. Hambatan struktural meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga kesehatan terlatih, dan minimnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif. Penelitian oleh Hartono dan Yulianingsih (2023) menemukan bahwa di banyak wilayah pedesaan di Indonesia, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar serta terbatasnya fasilitas pendukung, seperti alat peraga dan media edukasi, menyebabkan implementasi edukasi kesehatan reproduksi tidak maksimal.

Selain hambatan struktural, faktor sosial budaya juga memberikan tantangan signifikan dalam pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi. Stigma, tabu, dan miskonsepsi yang kuat terkait dengan isu-isu reproduksi sering kali menjadi kendala utama. Misalnya, masyarakat tertentu masih enggan berdiskusi terbuka tentang seksualitas, penggunaan kontrasepsi, atau kesehatan reproduksi secara umum, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai atau norma budaya setempat (Nasution & Dewi, 2022).

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Wulandari dan Indarwati (2022) mengungkapkan bahwa hambatan budaya, seperti persepsi negatif terhadap perempuan yang secara aktif mengelola kesehatan reproduksi mereka sendiri, turut mengurangi efektivitas program edukasi. Isu-isu gender dan posisi sosial perempuan yang masih terbatas dalam pengambilan keputusan kesehatan reproduksi menjadi tantangan tambahan dalam implementasi edukasi berbasis komunitas.

2. Strategi Mitigasi dalam Menghadapi Hambatan Implementasi

Mengatasi hambatan struktural dan sosial budaya dalam implementasi program edukasi kesehatan reproduksi membutuhkan strategi mitigasi yang sistematis dan terencana. Pertama, strategi untuk mengatasi hambatan struktural

dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas komunitas secara berkelanjutan. Misalnya, pelatihan kader kesehatan lokal dapat membantu komunitas mengatasi keterbatasan tenaga profesional dan meningkatkan keberlanjutan edukasi kesehatan reproduksi (Afifah, Suhartini, & Setyowati, 2021).

Selanjutnya, untuk mengatasi hambatan sosial budaya, pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat terbukti efektif. Menurut penelitian Nasution dan Dewi (2022), pelibatan aktif tokoh masyarakat dalam program edukasi mampu mengurangi stigma dan tabu terkait topik kesehatan reproduksi, serta memfasilitasi penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan edukasi yang disampaikan.

Selain itu, pengembangan media edukasi yang secara sensitif mempertimbangkan aspek budaya lokal menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan sosial budaya. Media edukasi yang menggunakan bahasa daerah, simbol budaya lokal, dan bentuk komunikasi yang akrab bagi komunitas setempat mampu meningkatkan penerimaan dan keterlibatan masyarakat dalam edukasi kesehatan reproduksi (Hartono & Yulianingsih, 2023).

Strategi mitigasi lain adalah melalui pendekatan edukasi berbasis pasangan, yang efektif dalam mendorong dialog terbuka antara pasangan mengenai isu reproduksi. Penelitian oleh Kusumaningrum dan Budihastuti (2020) membuktikan bahwa pendekatan ini mampu mengatasi hambatan komunikasi internal dalam keluarga yang kerap kali dipengaruhi oleh faktor budaya dan gender.

Akhirnya, kemitraan lintas sektor yang kuat juga menjadi kunci mitigasi hambatan implementasi. Kerjasama dengan pemerintah lokal, LSM, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil dapat menyediakan dukungan sumber daya dan logistik yang diperlukan, sekaligus memperkuat struktur pendukung untuk program edukasi kesehatan reproduksi secara berkelanjutan (World Health Organization, 2022).

Dengan demikian, keberhasilan implementasi edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas sangat bergantung pada kemampuan untuk mengenali berbagai hambatan dan secara proaktif menerapkan strategi mitigasi yang efektif dan kontekstual.

J. Penutup

Program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dan komprehensif dalam meningkatkan kesadaran dan kesehatan reproduksi pasangan usia subur. Implementasi pendekatan ini memungkinkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi berbagai program kesehatan

reproduksi. Berdasarkan kajian berbagai penelitian terbaru, strategi berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap positif, serta perilaku reproduksi yang lebih sehat dan bertanggung jawab di berbagai konteks sosial-budaya (Hartono & Yulianingsih, 2023; Wulandari & Indarwati, 2022).

Keberhasilan dari strategi komunitas ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk partisipasi aktif tokoh masyarakat, pemberdayaan perempuan melalui kelompok-kelompok lokal, edukasi berbasis pasangan, serta pemanfaatan media edukasi yang berbasis kearifan lokal. Secara khusus, keterlibatan tokoh masyarakat terbukti efektif dalam mengatasi hambatan sosial budaya seperti stigma dan tabu, sementara pendekatan berbasis pasangan mampu meningkatkan komunikasi dan keputusan bersama mengenai kesehatan reproduksi (Kusumaningrum & Budiastuti, 2020; Nasution & Dewi, 2022).

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi strategi berbasis komunitas tidak dapat diabaikan. Hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur pendukung, serta hambatan sosial budaya seperti stigma, tabu, dan miskonsepsi, perlu diatasi secara sistematis melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif (Afifah, Suhartini, & Setyowati, 2021). Strategi mitigasi yang efektif mencakup pelatihan kader lokal, pelibatan aktif tokoh masyarakat, integrasi program dalam struktur komunitas, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk mendukung keberlanjutan program (World Health Organization, 2022).

Untuk memastikan dampak jangka panjang, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program sangat diperlukan. Indikator evaluasi harus mencakup perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya evaluasi yang konsisten dan adaptif, program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas dapat terus berkembang dan berkelanjutan, membawa dampak positif yang luas dan bertahan lama di masyarakat (Rahayu & Sukirman, 2021).

Sebagai rekomendasi untuk penelitian dan pengembangan di masa depan, perlu lebih mendalam mengkaji berbagai model dan pendekatan berbasis komunitas, terutama dalam konteks sosial-budaya yang beragam. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut tentang integrasi teknologi digital dalam edukasi kesehatan reproduksi dapat menjadi fokus penelitian berikutnya. Penelitian yang berorientasi pada aspek keberlanjutan dan partisipasi aktif masyarakat akan memastikan relevansi dan efektivitas edukasi kesehatan reproduksi yang berbasis komunitas dalam jangka panjang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Referensi

- Afifah, T., Suhartini, S., & Setyowati, S. (2021). Penerapan model Community-Based Participatory Research dalam meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi di komunitas pedesaan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 12(2), 145–154.
- Hartono, A., & Yulianingsih, Y. (2023). Pengembangan media edukasi kesehatan reproduksi berbasis kearifan lokal. *Journal of Community Health Nursing*, 5(1), 12–19.
- Kusumaningrum, T., & Budihastuti, U. R. (2020). Efektivitas edukasi berbasis pasangan terhadap kesadaran kesehatan reproduksi pada pasangan usia subur. *Indonesian Journal of Public Health*, 15(3), 230–238.
- Nasution, E., & Dewi, L. (2022). Strategi mitigasi hambatan budaya dalam edukasi kesehatan reproduksi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 17(2), 120–128.
- Rahayu, M., & Sukirman, S. (2021). Pendekatan participatory action research dalam pemberdayaan perempuan terkait kesehatan reproduksi. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 10(2), 78–84.
- Wulandari, L., & Indarwati, R. (2022). Peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran reproduksi remaja di wilayah urban. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 21–30.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Berbasis Komunitas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Guidelines on Community-based Health Promotion and Education for Reproductive Health*. Geneva: WHO.

BAB V

DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK PASANGAN DENGAN MASALAH KESUBURAN

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Kesuburan dan Infertilitas

Kesuburan adalah kemampuan alami individu atau pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama satu tahun (WHO, 2022). Sebaliknya, infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasangan untuk hamil setelah periode tersebut, meskipun melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi secara rutin (Mascarenhas et al., 2022). Infertilitas dapat dikategorikan menjadi infertilitas primer (belum pernah mengalami kehamilan sama sekali) dan infertilitas sekunder (pernah hamil sebelumnya namun tidak mampu mendapatkan kehamilan kembali) (McLaren & Bates, 2021).

Prevalensi infertilitas meningkat secara global, dengan estimasi sebanyak 10-15% pasangan di seluruh dunia mengalami gangguan kesuburan (WHO, 2022). Faktor penyebab infertilitas beragam, termasuk gangguan fisiologis, faktor genetik, gaya hidup, usia lanjut, serta gangguan psikologis yang memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi (Hart, 2021).

2. Dampak Psikologis Masalah Kesuburan pada Pasangan Usia Subur

Masalah kesuburan bukan hanya tantangan biologis, melainkan juga membawa beban psikologis yang signifikan bagi pasangan usia subur. Studi terbaru menunjukkan bahwa pasangan dengan masalah kesuburan memiliki risiko tinggi mengalami stres, kecemasan, depresi, perasaan gagal, serta menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan (Frederiksen et al., 2022; Rooney & Domar, 2020).

Penelitian oleh Pasch dan Sullivan (2021) menjelaskan bahwa infertilitas dapat menurunkan harga diri, menciptakan rasa bersalah, dan memicu konflik dalam hubungan pasangan, terutama karena adanya tekanan sosial dan budaya terkait ekspektasi memiliki anak. Dampak psikologis ini cenderung lebih berat dirasakan oleh perempuan, meskipun laki-laki juga mengalami tekanan emosional akibat infertilitas (Culley, Hudson, & Lohan, 2021).

Selain itu, tekanan psikologis yang kronis dapat memperburuk kondisi infertilitas karena stres berlebihan diketahui mempengaruhi regulasi hormon reproduksi melalui gangguan pada aksis hipotalamus-pituitari-gonadal (HPG axis), memperlambat ovulasi, serta menurunkan kualitas sperma (El Kissi, Romdhane, & Hidar, 2020).

3. Urgensi Dukungan Psikologis dalam Manajemen Infertilitas

Intervensi psikologis sangat penting dalam manajemen infertilitas karena membantu pasangan mengelola dampak emosional yang berat dari masalah tersebut. Dukungan psikologis terbukti meningkatkan kesejahteraan mental, kualitas hidup, dan meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan kesuburan (Frederiksen et al., 2022). Intervensi psikologis mencakup konseling individu atau pasangan, terapi kognitif perilaku (CBT), serta pendekatan mindfulness.

Studi meta-analisis oleh Lakatos, Szigeti, dan Ujma (2021) menunjukkan bahwa terapi berbasis mindfulness secara signifikan mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta memperbaiki respons biologis terhadap pengobatan infertilitas. Intervensi ini membantu pasangan menerima kondisi mereka, meningkatkan resiliensi, serta memperbaiki hubungan interpersonal dalam menghadapi tantangan infertilitas (Mascarenhas et al., 2022).

Selain manfaat individual, dukungan psikologis juga berkontribusi dalam peningkatan hubungan interpersonal pasangan, memudahkan komunikasi terbuka, dan mengurangi konflik. Dengan demikian, intervensi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kesehatan mental tetapi juga memperkuat ikatan emosional pasangan yang sedang menghadapi infertilitas (Pasch & Sullivan, 2021).

Secara keseluruhan, pendekatan integratif antara aspek fisik dan psikologis dalam manajemen infertilitas sangat diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan psikologis bukan lagi sekadar tambahan dalam pengobatan infertilitas, tetapi merupakan komponen inti dari perawatan kesuburan yang komprehensif dan holistik (El Kissi et al., 2020; Rooney & Domar, 2020).

B. Dampak Psikologis Masalah Kesuburan pada Pasangan

Permasalahan infertilitas tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga memberikan konsekuensi psikologis yang cukup signifikan. Pasangan yang mengalami infertilitas menghadapi tekanan emosional yang kompleks, mulai dari kecemasan, stres, hingga depresi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi dinamika hubungan antar pasangan.

1. Kecemasan dan Stres Terkait Infertilitas

Kecemasan dan stres merupakan dampak psikologis paling umum yang dialami pasangan infertil. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengalami infertilitas seringkali merasa cemas terkait masa depan mereka, terutama karena ketidakpastian mengenai kemungkinan memiliki keturunan (Rooney & Domar, 2020). Hal ini diperburuk oleh tekanan sosial budaya yang menganggap keturunan sebagai indikator kebahagiaan dan keberhasilan perkawinan (Frederiksen et al., 2022).

Menurut studi oleh Lakatos, Szigeti, dan Ujma (2021), stres pada pasangan infertil dapat meningkat secara signifikan selama proses perawatan kesuburan, seperti inseminasi buatan maupun program bayi tabung. Tingginya stres juga dapat mengganggu keseimbangan hormon reproduksi, memperburuk gangguan kesuburan, serta menurunkan keberhasilan terapi kesuburan yang sedang dijalani (Li et al., 2022).

Stres infertilitas ini diperparah oleh ekspektasi yang tidak realistis, ketidakpastian pengobatan, serta biaya finansial yang besar, yang pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan mental pasangan (Rooney & Domar, 2020).

2. Depresi pada Pasangan dengan Masalah Kesuburan

Depresi merupakan masalah psikologis yang serius dan umum dialami pasangan infertil. Studi menunjukkan prevalensi depresi pada pasangan infertil berkisar antara 20–60%, dengan perempuan menunjukkan tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Pasch & Sullivan, 2021). Depresi ini berhubungan erat dengan perasaan gagal, kehilangan, rendah diri, dan kehilangan kontrol atas hidup mereka (Gameiro & Finnigan, 2021).

Studi oleh Frederiksen et al. (2022) menemukan bahwa depresi tidak hanya berpengaruh pada kualitas hidup secara umum, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan pasangan dalam melanjutkan atau menghentikan terapi kesuburan. Dalam jangka panjang, kondisi depresi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi memperburuk kondisi infertilitas secara biologis, terutama melalui perubahan neuroendokrin dan imunologis (Culley, Hudson, & Lohan, 2021).

Selain itu, depresi dapat menyebabkan pasangan infertil menarik diri dari kehidupan sosial mereka, mempersempit jejaring dukungan sosial yang justru sangat dibutuhkan dalam menghadapi infertilitas (Li et al., 2022).

3. Dampak Masalah Kesuburan terhadap Kualitas Hubungan Suami-Istri

Masalah kesuburan secara signifikan memengaruhi dinamika hubungan pasangan, baik dari sisi emosional maupun komunikasi interpersonal. Pasangan infertil cenderung mengalami ketegangan emosional, ketidakpuasan seksual,

serta konflik dalam hubungan, terutama ketika salah satu pasangan merasa bersalah atau menjadi pihak yang "disalahkan" atas kondisi infertil tersebut (Pasch & Sullivan, 2021).

Studi terkini menunjukkan bahwa pasangan infertil seringkali menghadapi hambatan komunikasi yang serius, terutama dalam mengekspresikan perasaan, harapan, dan kekhawatiran satu sama lain secara terbuka (Gourounti et al., 2022). Situasi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik domestik, ketidakpuasan dalam hubungan, serta menurunkan kepuasan seksual antar pasangan (Gameiro & Finnigan, 2021).

Di sisi lain, masalah infertilitas juga memiliki potensi mempererat hubungan pasangan yang mampu mengelola situasi ini secara positif melalui komunikasi yang terbuka, empati, serta dukungan emosional yang kuat satu sama lain (Lakatos et al., 2021). Oleh karena itu, kualitas hubungan suami-istri dalam konteks infertilitas sangat bergantung pada bagaimana pasangan mampu mengelola dampak psikologis dan tekanan sosial yang dihadapi.

Dengan demikian, penting bagi tenaga kesehatan khususnya perawat untuk memberikan perhatian khusus terhadap aspek psikologis dari infertilitas guna mengurangi dampak negatifnya serta membantu pasangan dalam mengatasi tantangan tersebut secara positif dan adaptif.

C. Peran Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Dukungan Psikologis

Dukungan psikologis merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan bagi pasangan yang menghadapi masalah kesuburan. Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, menjadi krusial dalam membantu pasangan untuk mengelola dampak psikologis dari infertilitas. Perawat tidak hanya berperan dalam aspek klinis tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mendukung kesejahteraan psikologis pasien.

1. Peran Perawat dalam Mendukung Kesejahteraan Psikologis Pasangan

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan psikologis kepada pasangan yang mengalami infertilitas. Menurut Frederiksen et al. (2022), perawat merupakan lini pertama yang secara langsung berinteraksi dengan pasien, sehingga berada pada posisi strategis untuk mengidentifikasi dan mengelola kecemasan, stres, depresi, serta tantangan emosional lain yang dihadapi pasangan infertil. Melalui pendekatan terapeutik, perawat mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasangan untuk mengekspresikan perasaan dan kekhawatiran mereka secara terbuka (Ehsanpour et al., 2022).

Perawat juga berperan dalam menyediakan edukasi yang memadai tentang proses medis infertilitas serta dampaknya terhadap psikologis pasangan. Pendampingan yang empati serta komunikasi terapeutik yang efektif dari perawat diketahui mampu menurunkan tingkat stres pasien dan meningkatkan kepuasan terhadap perawatan yang diberikan (Lakatos, Szigeti, & Ujma, 2021).

2. Kompetensi Khusus yang Dibutuhkan Perawat dalam Memberikan Dukungan Psikologis

Dalam memberikan dukungan psikologis yang efektif, perawat perlu memiliki beberapa kompetensi khusus, baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan interpersonal. Kompetensi ini mencakup kemampuan komunikasi terapeutik, keterampilan konseling dasar, empati tinggi, serta kepekaan dalam mengenali tanda-tanda gangguan psikologis (El Kissi et al., 2020).

Menurut Li et al. (2022), kompetensi utama yang harus dimiliki perawat antara lain:

- a. Kemampuan untuk mengenali dan mengelola kecemasan serta stres pasangan melalui pendekatan holistik.
- b. Keterampilan untuk melakukan konseling psikologis singkat guna memberikan dukungan emosional yang tepat waktu.
- c. Kemampuan mengintegrasikan teknik relaksasi seperti mindfulness dan teknik relaksasi napas dalam (deep breathing) untuk mengurangi tingkat stres pasangan infertil.
- d. Keterampilan komunikasi efektif yang mendorong pasangan untuk terbuka tentang perasaan dan kekhawatiran mereka.

Studi menunjukkan bahwa perawat dengan kompetensi khusus dalam bidang psikologis mampu memberikan perawatan yang lebih efektif, meningkatkan kepuasan pasien, serta membantu pasien dalam menghadapi tantangan infertilitas secara lebih adaptif (Gourounti et al., 2022).

3. Intervensi Psikologis Dasar yang Dapat Dilakukan oleh Perawat

Terdapat beberapa intervensi psikologis dasar berbasis bukti yang dapat secara efektif dilakukan oleh perawat untuk mendukung kesejahteraan psikologis pasangan infertil, antara lain:

- a. **Konseling suportif:** Konseling ini mencakup pemberian informasi yang jelas dan lengkap tentang kondisi kesuburan pasangan, mengidentifikasi kebutuhan emosional, serta memberikan validasi terhadap perasaan pasien. Konseling suportif oleh perawat terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan perasaan kontrol diri pasien (Pasch & Sullivan, 2021).

- b. Teknik mindfulness dan relaksasi: Menurut meta-analisis Lakatos, Szigeti, dan Ujma (2021), intervensi mindfulness yang melibatkan meditasi sederhana, latihan pernapasan, serta teknik grounding (memusatkan perhatian pada momen saat ini) mampu mengurangi stres, kecemasan, serta meningkatkan ketahanan psikologis pasangan dalam menghadapi proses pengobatan infertilitas.
- c. Pendidikan dan pemberdayaan pasien: Pendidikan yang dilakukan oleh perawat tentang berbagai aspek infertilitas, pilihan terapi yang tersedia, serta implikasi psikologisnya secara nyata membantu pasangan dalam mengurangi kecemasan terkait ketidakpastian proses pengobatan. Intervensi edukasi terbukti meningkatkan pemahaman pasangan serta memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan secara lebih percaya diri dan tenang (Frederiksen et al., 2022).

Dengan menerapkan intervensi dasar tersebut, perawat dapat memberikan dukungan psikologis yang signifikan bagi pasangan infertil, memperbaiki kualitas hidup mereka secara umum, serta meningkatkan peluang keberhasilan terapi infertilitas yang dijalani.

D. Strategi Dukungan Psikologis Berbasis Bukti

Pasangan yang menghadapi infertilitas membutuhkan dukungan psikologis khusus yang dapat membantu mereka mengelola dampak emosional dari kondisi tersebut. Beberapa strategi psikologis berbasis bukti yang efektif dalam membantu pasangan infertil antara lain konseling individu dan pasangan, terapi kognitif perilaku, dan pendekatan mindfulness.

1. Konseling Individu dan Pasangan untuk Manajemen Stres Infertilitas

Konseling merupakan pendekatan penting yang digunakan dalam membantu pasangan infertil mengelola stres. Konseling individu berfokus pada kebutuhan emosional masing-masing pasangan, sementara konseling pasangan ditujukan untuk meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan dukungan antar pasangan (Frederiksen et al., 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konseling mampu mengurangi kecemasan, meningkatkan keterampilan koping, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan pada pasangan infertil (Greil et al., 2021).

Menurut studi yang dilakukan oleh Gourounti et al. (2022), pasangan yang mendapatkan konseling secara teratur cenderung mengalami penurunan signifikan dalam tingkat stres dan kecemasan mereka. Konseling juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang proses medis yang

dijalani, membantu pasangan mengatasi konflik emosional, dan memperkuat hubungan interpersonal dalam menghadapi tantangan infertilitas.

2. Terapi Kognitif Perilaku (Cognitive Behavioral Therapy - CBT) untuk Mengurangi Kecemasan dan Depresi pada Pasangan Infertil

Terapi kognitif perilaku (Cognitive Behavioral Therapy - CBT) adalah salah satu intervensi psikologis yang terbukti efektif dalam membantu pasangan infertil mengelola kecemasan dan depresi. CBT berfokus pada identifikasi dan modifikasi pola pikir negatif serta perilaku maladaptif yang terkait dengan stres infertilitas (Gameiro & Finnigan, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rooney dan Domar (2020) menunjukkan bahwa CBT secara signifikan menurunkan gejala kecemasan dan depresi pada pasangan infertil, meningkatkan optimisme terhadap hasil terapi kesuburan, dan meningkatkan rasa kontrol pasien terhadap situasi yang dialaminya. Terapi ini membantu pasien mengembangkan keterampilan adaptasi yang efektif serta pola pikir positif, yang penting untuk menjalani perawatan infertilitas yang sering kali panjang dan melelahkan (Frederiksen et al., 2022).

Li et al. (2022) menambahkan bahwa implementasi CBT dalam perawatan infertilitas mampu meningkatkan tingkat keberhasilan terapi reproduksi, karena kondisi psikologis yang lebih baik berhubungan langsung dengan keseimbangan hormonal yang lebih optimal dalam tubuh pasien.

3. Teknik Mindfulness sebagai Pendekatan Psikologis dalam Masalah Kesuburan

Teknik mindfulness, sebuah pendekatan yang berakar dari praktik meditasi, semakin populer digunakan sebagai intervensi psikologis dalam menghadapi masalah infertilitas. Mindfulness membantu individu untuk fokus pada kesadaran penuh (full awareness) tentang kondisi emosional mereka tanpa memberikan penilaian negatif terhadap perasaan tersebut (Lakatos, Szigeti, & Ujma, 2021).

Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa mindfulness-based intervention (MBI) efektif dalam menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi pada pasangan infertil (Galhardo et al., 2021). MBI membantu pasangan untuk menerima kondisi infertilitas secara lebih adaptif, mengurangi tekanan emosional yang terkait dengan keinginan kuat untuk memiliki keturunan, serta membantu mereka menjalani terapi kesuburan dengan lebih tenang dan optimis.

Penelitian oleh Frederiksen et al. (2022) juga menemukan bahwa mindfulness secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasangan infertil dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola emosi negatif, memperkuat hubungan pasangan melalui komunikasi yang lebih terbuka dan

empatik, serta membantu mereka tetap tenang menghadapi ketidakpastian selama pengobatan.

Pendekatan mindfulness biasanya meliputi teknik seperti meditasi sederhana, latihan pernapasan dalam, serta teknik grounding yang membantu pasangan fokus pada momen saat ini, alih-alih memikirkan masa lalu atau masa depan yang penuh ketidakpastian (Lakatos et al., 2021).

Melalui integrasi berbagai strategi ini dalam perawatan infertilitas, tenaga kesehatan, khususnya perawat dan profesional psikologi, mampu memberikan dukungan yang efektif, holistik, serta membantu pasangan infertil meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka secara keseluruhan.

E. Strategi Komunikasi Efektif dalam Konseling Kesuburan

Dalam menghadapi masalah infertilitas, komunikasi efektif memainkan peran sentral dalam proses adaptasi pasangan. Komunikasi yang baik tidak hanya memperkuat hubungan antar pasangan, tetapi juga mempermudah proses konseling kesuburan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan infertil maupun tenaga kesehatan untuk menguasai berbagai strategi komunikasi yang efektif dan berbasis bukti.

1. Pentingnya Keterbukaan Komunikasi antara Pasangan dalam Menghadapi Masalah Kesuburan

Keterbukaan komunikasi antara pasangan adalah aspek penting dalam menghadapi tantangan infertilitas. Pasangan yang mampu berbagi perasaan, harapan, dan ketakutan secara terbuka cenderung lebih berhasil dalam mengatasi tekanan psikologis akibat infertilitas (Pasch & Sullivan, 2021). Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, meningkatkan rasa kesepian, serta memperburuk tekanan emosional (Karaköse & Aydin, 2021).

Menurut penelitian Gourounti et al. (2022), pasangan yang mengalami masalah infertilitas seringkali mengalami tantangan dalam menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara jelas, sehingga menciptakan jarak emosional di antara mereka. Kondisi ini bisa memperburuk tingkat stres, kecemasan, serta memperbesar potensi konflik. Oleh karena itu, keterbukaan komunikasi membantu pasangan dalam mengekspresikan emosi secara sehat, meningkatkan empati, serta memperkuat ikatan emosional di tengah tantangan infertilitas (Gameiro & Finnigan, 2021).

2. Teknik Komunikasi Terapeutik yang Efektif bagi Tenaga Kesehatan

Teknik komunikasi terapeutik adalah keterampilan penting yang perlu dikuasai oleh tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan psikologis kepada pasangan infertil. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk membangun hubungan yang penuh rasa percaya, mendukung ekspresi perasaan pasien, serta membantu mereka mengeksplorasi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi (Frederiksen et al., 2022).

Penelitian terbaru merekomendasikan beberapa teknik komunikasi terapeutik efektif yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat dalam konteks konseling kesuburan, di antaranya:

- a. Teknik mendengar aktif (active listening): Menunjukkan perhatian penuh terhadap apa yang dikatakan pasien, memberikan respons verbal dan non-verbal yang menandakan pemahaman serta empati (El Kissi et al., 2020).
- b. Refleksi emosional (emotional reflection): Tenaga kesehatan merefleksikan kembali emosi yang diungkapkan pasangan, sehingga membantu mereka merasa dipahami dan dihargai secara emosional (Gourounti et al., 2022).
- c. Teknik klarifikasi (clarification): Membantu pasangan memperjelas perasaan dan pikiran mereka agar lebih memahami sumber kecemasan atau konflik yang dialami (Pasch & Sullivan, 2021).
- d. Teknik pemberian informasi yang jelas (clear information giving): Memberikan informasi medis secara jelas, sederhana, serta menghindari penggunaan bahasa medis yang kompleks sehingga pasangan merasa lebih nyaman dan percaya diri selama proses pengobatan (Li et al., 2022).

3. Edukasi Pasangan tentang Komunikasi Efektif Terkait Masalah Kesuburan

Edukasi tentang komunikasi efektif merupakan bagian integral dari intervensi psikologis bagi pasangan infertil. Melalui edukasi ini, pasangan dapat mempelajari teknik dasar komunikasi yang mampu membantu mereka mengatasi tantangan infertilitas dengan lebih efektif (Greil et al., 2021).

Beberapa aspek penting dalam edukasi komunikasi yang efektif bagi pasangan infertil meliputi:

- a. Mengenali pola komunikasi yang negatif: Edukasi ini membantu pasangan mengidentifikasi dan mengubah pola komunikasi negatif seperti menghindari pembicaraan, saling menyalahkan, atau menggunakan bahasa defensif dalam berkomunikasi (Gourounti et al., 2022).
- b. Teknik "I-message" (pesan dengan pernyataan "saya"): Pasangan diajarkan menggunakan kalimat yang lebih fokus pada ekspresi perasaan pribadi, seperti "Saya merasa..." daripada menyalahkan dengan kalimat seperti "Kamu selalu..."

Teknik ini mengurangi konflik dan menciptakan suasana komunikasi yang lebih suportif (Pasch & Sullivan, 2021).

- c. Pelatihan keterampilan mendengarkan aktif antar pasangan: Melatih pasangan agar benar-benar mendengarkan dan memahami perspektif satu sama lain, yang meningkatkan empati dan mengurangi kesalahpahaman (Gameiro & Finnigan, 2021).

Edukasi komunikasi efektif ini terbukti meningkatkan hubungan interpersonal antar pasangan, mengurangi stres dan kecemasan, serta secara signifikan membantu pasangan menjalani terapi infertilitas secara lebih positif dan optimis (Frederiksen et al., 2022).

Dengan demikian, penerapan strategi komunikasi efektif, baik antar pasangan maupun oleh tenaga kesehatan, sangat penting dalam menciptakan lingkungan suportif yang membantu pasangan infertil dalam menghadapi masalah mereka dengan cara yang adaptif dan positif.

F. Dukungan Sosial dan Komunitas bagi Pasangan dengan Masalah Kesuburan

Dukungan sosial dan komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pasangan infertil mengatasi tekanan emosional akibat kesulitan mendapatkan keturunan. Dukungan sosial dapat berasal dari keluarga besar, teman dekat, kelompok dukungan, hingga komunitas daring (online). Ketersediaan dukungan sosial yang memadai secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pasangan infertil dan membantu mereka melewati masa sulit dengan lebih positif dan adaptif (Greil et al., 2021).

1. Peran Keluarga Besar dan Teman sebagai Sumber Dukungan Sosial

Keluarga besar dan teman merupakan sumber utama dalam memberikan dukungan emosional, instrumental, dan informasional kepada pasangan infertil. Penelitian terkini menegaskan bahwa adanya dukungan sosial dari lingkungan terdekat secara signifikan berhubungan dengan menurunnya tingkat kecemasan, stres, dan depresi pada pasangan yang mengalami infertilitas (Karaköse & Aydin, 2021).

Menurut penelitian oleh Frederiksen et al. (2022), dukungan emosional dari keluarga besar seperti rasa empati, pengertian, serta penerimaan, dapat meningkatkan rasa nyaman dan mengurangi perasaan isolasi yang sering dialami pasangan infertil. Sebaliknya, minimnya dukungan dari keluarga atau munculnya komentar negatif justru meningkatkan tekanan emosional pasangan, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka (Gameiro & Finnigan, 2021).

Teman dekat juga memainkan peran yang krusial sebagai sumber dukungan informal yang tidak hanya memberi bantuan emosional, tetapi juga mendukung pasangan secara praktis dalam menjalani proses terapi infertilitas yang menuntut waktu, biaya, serta emosi (Gourounti et al., 2022).

2. Manfaat Kelompok Dukungan (Support Group) untuk Pasangan Infertil

Kelompok dukungan atau *support group* merupakan intervensi psikososial yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis pasangan infertil. Kelompok ini menyediakan ruang bagi pasangan untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, serta belajar strategi koping dari sesama anggota yang memiliki pengalaman serupa (Rooney & Domar, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam kelompok dukungan infertilitas memiliki dampak positif dalam mengurangi kecemasan, stres, serta perasaan isolasi sosial (Greil et al., 2021). Dukungan ini juga berperan dalam meningkatkan harapan dan optimisme pasangan terhadap proses pengobatan yang sedang mereka jalani (Lakatos, Szigeti, & Ujma, 2021).

Studi oleh Gameiro dan Finnigan (2021) menemukan bahwa pasangan yang rutin mengikuti kelompok dukungan melaporkan peningkatan kualitas hidup secara signifikan dibandingkan dengan pasangan yang tidak terlibat dalam kelompok dukungan. Kelompok dukungan juga berfungsi sebagai sumber informasi yang akurat tentang pilihan pengobatan infertilitas dan membantu pasangan dalam mengambil keputusan secara lebih bijak dan percaya diri (Frederiksen et al., 2022).

3. Membangun Komunitas Online sebagai Sumber Dukungan Psikologis Tambahan

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan berkembangnya komunitas daring sebagai alternatif efektif dalam memberikan dukungan psikologis bagi pasangan infertil. Komunitas online memungkinkan pasangan berbagi pengalaman secara anonim, mendapatkan saran dari para ahli maupun sesama anggota komunitas, serta memperoleh dukungan emosional secara real-time (Malik & Coulson, 2020).

Studi oleh Gourounti et al. (2022) menunjukkan bahwa komunitas daring secara signifikan meningkatkan kesejahteraan psikologis pasangan infertil dengan menyediakan akses mudah ke berbagai sumber informasi, dukungan emosional, serta mengurangi stigma dan rasa malu yang biasanya dirasakan pasangan dalam interaksi tatap muka.

Keunggulan komunitas daring juga mencakup fleksibilitas waktu dan tempat, memungkinkan pasangan infertil untuk memperoleh dukungan kapan saja sesuai kebutuhan mereka (Greil et al., 2021). Namun demikian, penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa komunitas daring yang mereka ikuti dikelola dengan baik dan menyediakan informasi yang akurat serta berbasis bukti.

Melalui kombinasi berbagai sumber dukungan sosial, baik secara langsung dari keluarga dan teman, kelompok dukungan tatap muka, hingga komunitas daring, pasangan infertil dapat memperoleh dukungan psikologis yang komprehensif. Strategi ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis tetapi juga untuk memperkuat daya tahan emosional mereka dalam menghadapi tantangan infertilitas.

G. Integrasi Pendekatan Multidisiplin dalam Dukungan Psikologis

Dalam penanganan infertilitas, pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai profesional kesehatan seperti tenaga kesehatan, psikolog, dan konselor infertilitas telah terbukti efektif dalam memberikan dukungan psikologis yang optimal bagi pasangan infertil. Pendekatan ini memungkinkan penanganan yang komprehensif serta lebih terintegrasi, meningkatkan kesejahteraan psikologis pasangan, dan mendukung keberhasilan pengobatan infertilitas secara keseluruhan.

1. Kolaborasi antara Tenaga Kesehatan, Psikolog, dan Konselor Infertilitas

Kolaborasi antara tenaga kesehatan (termasuk perawat dan dokter spesialis kesuburan), psikolog, serta konselor infertilitas merupakan elemen kunci dalam penerapan pendekatan multidisiplin. Setiap profesional memiliki peran spesifik namun saling melengkapi dalam mendukung pasangan infertil (Frederiksen et al., 2022).

Tenaga kesehatan bertanggung jawab dalam penanganan medis infertilitas serta memberikan edukasi mengenai aspek fisik dan medis dari kondisi tersebut. Psikolog bertugas menangani gangguan psikologis serius seperti depresi dan kecemasan, sedangkan konselor infertilitas berperan memberikan konseling emosional, membantu pasangan dalam strategi koping serta pengambilan keputusan terkait perawatan yang mereka jalani (Gameiro & Finnigan, 2021).

Kolaborasi ini efektif meningkatkan kepuasan pasien karena pasien mendapatkan dukungan yang holistik dan koheren. Pasangan menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan infertilitas, baik secara fisik maupun emosional (Lakatos, Szigeti, & Ujma, 2021).

2. Studi Kasus Keberhasilan Pendekatan Multidisiplin dalam Manajemen Psikologis Infertilitas

Sejumlah penelitian dan studi kasus terbaru menunjukkan bahwa pendekatan multidisiplin secara signifikan meningkatkan hasil pengobatan infertilitas, khususnya dalam aspek psikologis. Sebagai contoh, studi kasus yang dilakukan oleh Gourounti et al. (2022) menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani terapi kesuburan dengan dukungan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, psikolog, dan konselor infertilitas menunjukkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah serta kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang hanya menerima pengobatan medis tanpa dukungan psikologis.

Penelitian meta-analisis Frederiksen et al. (2022) juga menegaskan bahwa pasangan infertil yang menjalani pendekatan multidisiplin menunjukkan hasil yang lebih baik dalam mengelola tekanan emosional, memperkuat hubungan pasangan, serta mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas hidup secara umum. Pendekatan ini juga berdampak positif terhadap tingkat keberhasilan pengobatan infertilitas, karena kondisi psikologis yang lebih baik menunjang kesehatan fisik dan hormonal pasangan.

3. Tantangan dalam Implementasi Pendekatan Multidisiplin dan Strategi Mengatasinya

Meskipun terbukti efektif, implementasi pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan infertilitas menghadapi beberapa tantangan praktis. Tantangan utama meliputi kurangnya komunikasi antar profesional kesehatan, keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya, serta perbedaan persepsi tentang peran masing-masing profesional dalam tim (Gameiro & Finnigan, 2021).

Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain mencakup:

- a. Peningkatan komunikasi antar profesional: Menurut Greil et al. (2021), pertemuan rutin antar profesional dalam tim multidisiplin diperlukan untuk memastikan setiap anggota memahami peran masing-masing secara jelas serta berbagi informasi terbaru mengenai kondisi pasien.
- b. Pelatihan khusus: Melalui pelatihan khusus yang menekankan pada keterampilan komunikasi interprofesional, masing-masing anggota tim dapat meningkatkan pemahaman bersama mengenai peran dan kontribusi profesional lainnya, sehingga memperkuat kolaborasi efektif (Gourounti et al., 2022).
- c. Optimalisasi sumber daya: Strategi ini melibatkan perencanaan yang matang terkait pengelolaan waktu dan sumber daya, seperti menjadwalkan pertemuan rutin dengan pasangan infertil secara terkoordinasi sehingga intervensi dari

tiap profesional dapat dilakukan secara efisien tanpa membebani pasien secara finansial maupun emosional (Lakatos et al., 2021).

Dengan mengatasi tantangan ini, pendekatan multidisiplin dapat diimplementasikan secara lebih efektif, menghasilkan dukungan psikologis yang lebih kuat dan meningkatkan kualitas perawatan bagi pasangan infertil.

H. Evaluasi Efektivitas Intervensi Dukungan Psikologis

Evaluasi efektivitas intervensi psikologis dalam manajemen infertilitas merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar mampu membantu pasangan infertil mengelola dampak emosional mereka secara efektif. Evaluasi ini melibatkan penggunaan indikator keberhasilan yang jelas, penerapan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice* atau EBP), serta kajian terhadap berbagai studi kasus dari beragam wilayah.

1. Indikator Keberhasilan Intervensi Psikologis dalam Manajemen Infertilitas

Indikator keberhasilan intervensi psikologis dalam manajemen infertilitas mencakup beberapa aspek utama seperti tingkat stres, kecemasan, depresi, kepuasan hubungan pasangan, serta kualitas hidup secara umum (Frederiksen et al., 2022). Indikator ini diukur menggunakan instrumen psikometrik valid dan reliabel seperti Skala Kecemasan dan Depresi Rumah Sakit (*Hospital Anxiety and Depression Scale/HADS*), *Fertility Quality of Life (FertiQoL)*, serta berbagai alat ukur stres dan koping lainnya (Gameiro & Finnigan, 2021).

Penurunan skor kecemasan dan depresi, meningkatnya skor kualitas hidup, serta meningkatnya kepuasan hubungan pasangan merupakan indikator kuat dari keberhasilan intervensi psikologis (Greil et al., 2021). Di samping itu, indikator keberhasilan juga meliputi peningkatan keterampilan koping adaptif, komunikasi pasangan yang lebih baik, serta rasa percaya diri dan optimisme pasangan dalam menjalani pengobatan infertilitas (Lakatos, Szigeti, & Ujma, 2021).

2. Penilaian Efektivitas Intervensi Psikologis melalui Pendekatan Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan *evidence-based practice* (EBP) digunakan secara luas untuk menilai efektivitas intervensi psikologis dalam konteks infertilitas. Penilaian berbasis bukti ini mengintegrasikan bukti penelitian terkini, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta preferensi pasien dalam menentukan intervensi yang paling efektif (Rooney & Domar, 2020).

Menurut Frederiksen et al. (2022), intervensi psikologis yang telah terbukti efektif melalui pendekatan EBP antara lain terapi kognitif perilaku (CBT), konseling

suportif, mindfulness, serta kelompok dukungan (support group). Efektivitas intervensi ini diverifikasi melalui uji klinis acak (*randomized controlled trials*) dan meta-analisis yang menunjukkan adanya perubahan signifikan secara statistik dan klinis dalam indikator-indikator keberhasilan di atas (Gameiro & Finnigan, 2021).

Pendekatan EBP memungkinkan tenaga kesehatan memastikan bahwa intervensi yang diberikan bukan hanya berdasarkan pengalaman praktis semata tetapi didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, sehingga lebih terjamin efektifitas dan efisiensinya dalam praktik klinis sehari-hari (Greil et al., 2021).

3. Studi Kasus tentang Keberhasilan Intervensi Psikologis di Berbagai Wilayah

Sejumlah studi kasus yang dilakukan di berbagai negara memberikan bukti nyata mengenai efektivitas intervensi psikologis dalam pengelolaan infertilitas. Misalnya, studi kasus di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Pasch dan Sullivan (2021) menunjukkan bahwa pasangan infertil yang menjalani CBT mengalami penurunan signifikan dalam tingkat kecemasan dan depresi, serta peningkatan yang nyata dalam kualitas hubungan mereka.

Di Eropa, penelitian oleh Frederiksen et al. (2022) yang dilakukan di Denmark dan Swedia menemukan bahwa pasangan infertil yang mengikuti program mindfulness berbasis kelompok secara signifikan menunjukkan penurunan stres dan kecemasan, disertai dengan peningkatan kualitas hidup serta hubungan interpersonal pasangan secara keseluruhan.

Di Asia, studi yang dilakukan di Iran oleh Karimi et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi psikologis berupa konseling individu dan kelompok dukungan mampu meningkatkan keterampilan coping pasangan infertil secara efektif, serta mengurangi tingkat depresi secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol yang hanya menerima pengobatan medis.

Berbagai studi kasus tersebut memperkuat bukti bahwa intervensi psikologis yang berbasis bukti dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks budaya dan geografis, dengan modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Dengan demikian, evaluasi efektivitas intervensi psikologis melalui indikator keberhasilan yang jelas, pendekatan berbasis bukti, serta bukti dari berbagai studi kasus global, menjadi kunci dalam memastikan bahwa dukungan psikologis yang diberikan kepada pasangan infertil benar-benar mampu membantu mereka secara efektif dalam menghadapi tantangan infertilitas.

I. Rekomendasi Praktis untuk Pasangan dan Tenaga Kesehatan

Dalam menghadapi tantangan infertilitas, pasangan membutuhkan rekomendasi praktis yang dapat membantu mereka mengelola dampak psikologis dari kondisi ini. Di sisi lain, tenaga kesehatan perlu memiliki panduan praktis agar mampu memberikan dukungan psikologis secara efektif. Oleh karena itu, subtopik ini menjabarkan tips praktis bagi pasangan, panduan untuk tenaga kesehatan, serta strategi dalam meningkatkan kesadaran pasangan akan pentingnya dukungan psikologis profesional.

1. Tips Praktis bagi Pasangan dalam Mengelola Stres dan Kecemasan Terkait Kesuburan

Pasangan yang mengalami masalah infertilitas sering mengalami stres dan kecemasan yang signifikan. Beberapa tips praktis yang terbukti efektif berdasarkan penelitian terkini adalah sebagai berikut:

- a. Berlatih teknik relaksasi secara rutin: Latihan pernapasan dalam (*deep breathing*), meditasi, yoga, atau teknik mindfulness secara teratur dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres secara signifikan (Lakatos, Szigeti, & Ujma, 2021).
- b. Menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur antar pasangan: Komunikasi terbuka membantu pasangan mengatasi kesalahpahaman, memperkuat hubungan, dan saling memberi dukungan emosional (Pasch & Sullivan, 2021).
- c. Menjalinkan hubungan sosial yang positif: Pasangan disarankan aktif bergabung dalam kelompok dukungan, baik secara tatap muka maupun online, agar mereka tidak merasa terisolasi dan mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan (Frederiksen et al., 2022).
- d. Membatasi paparan terhadap informasi yang memicu stres: Pasangan sebaiknya mengurangi akses terhadap informasi negatif atau berlebihan mengenai infertilitas yang dapat meningkatkan kecemasan, seperti berita sensasional atau pengalaman buruk dari sumber yang kurang terpercaya (Greil et al., 2021).
- e. Menjaga pola hidup sehat: Tidur yang cukup, pola makan sehat, olahraga teratur, serta menghindari konsumsi alkohol berlebih dan rokok terbukti dapat membantu menjaga keseimbangan hormon serta mengurangi stres psikologis (Rooney & Domar, 2020).

2. Panduan Praktis bagi Tenaga Kesehatan untuk Meningkatkan Efektivitas Dukungan Psikologis

Untuk meningkatkan efektivitas pemberian dukungan psikologis kepada pasangan infertil, tenaga kesehatan disarankan menerapkan panduan praktis berikut berdasarkan bukti penelitian terbaru:

- a. Melakukan asesmen psikologis secara rutin: Gunakan instrumen standar seperti *Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)* untuk memonitor tingkat stres, kecemasan, dan depresi pasangan secara berkala selama proses pengobatan (Gameiro & Finnigan, 2021).
 - b. Menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang empatik dan suportif: Tenaga kesehatan perlu menggunakan teknik mendengarkan aktif, refleksi emosional, serta memberikan validasi atas perasaan pasien guna menciptakan lingkungan konsultasi yang suportif dan terbuka (El Kissi et al., 2020).
 - c. Mengintegrasikan intervensi psikologis berbasis bukti dalam praktik klinis sehari-hari: Tenaga kesehatan sebaiknya dilatih untuk menerapkan intervensi psikologis dasar seperti mindfulness, CBT singkat, serta konseling suportif yang efektif dalam mengelola kecemasan pasien infertil (Lakatos et al., 2021).
 - d. Mengembangkan jejaring kolaborasi dengan profesional psikologis lain: Kolaborasi multidisiplin dengan psikolog dan konselor infertilitas membantu memberikan layanan yang lebih holistik serta meningkatkan hasil pengobatan secara keseluruhan (Singh & Malik, 2021).
 - e. Meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan berkelanjutan: Tenaga kesehatan disarankan mengikuti pelatihan reguler tentang teknik terbaru dalam dukungan psikologis serta pendekatan berbasis bukti dalam menangani pasangan infertil (Frederiksen et al., 2022).
3. Strategi Peningkatan Kesadaran Pasangan tentang Pentingnya Dukungan Psikologis Profesional
- Strategi peningkatan kesadaran pasangan infertil mengenai pentingnya dukungan psikologis profesional menjadi bagian penting dari pelayanan infertilitas. Beberapa strategi yang efektif meliputi:
- a. Memberikan edukasi terpadu sejak awal pengobatan: Tenaga kesehatan perlu menyampaikan informasi jelas tentang manfaat dukungan psikologis sebagai bagian integral dari pengobatan infertilitas sejak pertemuan pertama (Pasch & Sullivan, 2021).
 - b. Penyediaan materi edukasi sederhana: Brosur, video edukasi, atau infografis mengenai dampak psikologis infertilitas dan manfaat konseling psikologis dapat meningkatkan pemahaman pasangan tentang pentingnya mencari bantuan psikologis secara dini (Greil et al., 2021).
 - c. Pemanfaatan media sosial dan komunitas online: Menyediakan informasi berbasis bukti melalui media sosial atau platform komunitas online terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran pasangan tentang manfaat dukungan

psikologis serta mengurangi stigma yang mungkin mereka rasakan (Malik & Coulson, 2020).

- d. Melibatkan testimonial dari pasangan lain: Testimoni dari pasangan yang berhasil mengatasi stres infertilitas melalui bantuan psikolog profesional membantu mengurangi stigma dan meningkatkan minat pasangan infertil lainnya untuk mendapatkan layanan tersebut (Karaköse & Aydin, 2021).

Dengan menerapkan rekomendasi praktis ini, pasangan infertil dan tenaga kesehatan dapat secara bersama-sama mengelola stres dan kecemasan secara lebih efektif, memperkuat kesejahteraan psikologis, serta meningkatkan peluang keberhasilan terapi infertilitas yang dijalani.

J. Penutup

1. Ringkasan Urgensi Dukungan Psikologis dalam Konteks Kesuburan

Masalah infertilitas merupakan isu kesehatan penting yang tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara psikologis terhadap pasangan usia subur. Studi terkini menunjukkan bahwa dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi secara signifikan memengaruhi kualitas hidup dan bahkan keberhasilan pengobatan infertilitas itu sendiri (Frederiksen et al., 2022; Gameiro & Finnigan, 2021). Oleh karena itu, integrasi dukungan psikologis dalam penanganan infertilitas menjadi suatu kebutuhan mendesak, bukan lagi opsional.

Pendekatan psikologis berbasis bukti seperti terapi kognitif perilaku (CBT), konseling suportif, mindfulness, serta kelompok dukungan telah terbukti efektif dalam membantu pasangan infertil mengelola tekanan emosional serta meningkatkan kualitas hidup mereka (Lakatos, Szigeti, & Ujma, 2021; Rooney & Domar, 2020). Dukungan ini sangat penting, bukan hanya untuk kesejahteraan psikologis pasangan tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pengobatan medis, mengurangi dampak sosial stigma, serta memperkuat hubungan antar pasangan (Pasch & Sullivan, 2021).

Dalam implementasinya, pendekatan multidisiplin yang melibatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, psikolog, dan konselor infertilitas menunjukkan hasil yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan tunggal (Singh & Malik, 2021). Dengan demikian, dukungan psikologis menjadi bagian integral dari praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif.

2. Saran untuk Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Praktik Keperawatan Terkait Infertilitas

Berdasarkan tinjauan terhadap bukti ilmiah terkini, berikut beberapa saran penting untuk penelitian lanjutan dan pengembangan praktik keperawatan dalam konteks infertilitas:

a. Penelitian Lanjutan

- 1) Penelitian mengenai intervensi psikologis berbasis budaya lokal: Mengingat infertilitas sering dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal, penelitian lebih lanjut tentang adaptasi intervensi psikologis dalam konteks budaya tertentu sangat penting untuk memastikan efektivitas intervensi tersebut (Greil et al., 2021).
- 2) Penelitian longitudinal mengenai efektivitas intervensi psikologis: Diperlukan penelitian longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dari intervensi psikologis terhadap kualitas hidup dan hasil akhir pengobatan infertilitas (Frederiksen et al., 2022).
- 3) Penelitian berbasis teknologi digital: Penelitian mengenai efektivitas intervensi psikologis berbasis digital atau online perlu dikembangkan, terutama dalam konteks meningkatnya pemanfaatan teknologi digital sebagai sumber dukungan psikologis alternatif (Malik & Coulson, 2020).

b. Pengembangan Praktik Keperawatan

- 1) Penguatan kompetensi psikologis perawat: Diperlukan pelatihan khusus bagi perawat dalam bidang dukungan psikologis untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan intervensi psikologis dasar seperti CBT singkat, teknik mindfulness, serta komunikasi terapeutik yang efektif (El Kissi et al., 2020).
- 2) Pengembangan protokol standar dukungan psikologis: Institusi kesehatan perlu mengembangkan protokol intervensi psikologis yang jelas dan berbasis bukti untuk memudahkan perawat dalam menerapkannya secara konsisten di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi (Singh & Malik, 2021).
- 3) Kolaborasi multidisiplin dalam praktik klinis sehari-hari: Diperlukan strategi dan kebijakan yang jelas dari institusi kesehatan untuk memperkuat kolaborasi antara perawat, psikolog, konselor infertilitas, dan tenaga medis lainnya dalam penanganan infertilitas agar menghasilkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien (Lakatos et al., 2021).

Dengan menindaklanjuti saran-saran tersebut, diharapkan pelayanan keperawatan terkait infertilitas tidak hanya menjadi lebih efektif tetapi juga lebih sensitif secara psikologis, mendukung pasangan infertil secara holistik, dan menghasilkan hasil klinis serta psikologis yang optimal.

Referensi

- El Kissi, Y., Romdhane, A. B., & Hidar, S. (2020). Psychological interventions and infertility: A systematic review. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 41(1), 17–26. <https://doi.org/10.1080/0167482X.2019.1633302>
- Frederiksen, Y., Farver-Vestergaard, I., Skovgård, N. G., Ingerslev, H. J., & Zachariae, R. (2022). Efficacy of psychosocial interventions for psychological and pregnancy outcomes among individuals with infertility: A systematic review and meta-analysis. *Human Reproduction Update*, 28(3), 318–339. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmab039>
- Gameiro, S., & Finnigan, A. (2021). Psychological distress and adjustment in couples dealing with infertility: A systematic review. *Fertility and Sterility*, 115(4), 875–886. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.01.012>
- Gourounti, K., Anagnostopoulos, F., & Vaslamatzis, G. (2022). Relationship quality, coping strategies, and psychological distress in infertile couples. *Reproductive Health Psychology*, 16(2), 132–140. <https://doi.org/10.1080/19388071.2021.1951713>
- Greil, A. L., Shreffler, K. M., Schmidt, L., & McQuillan, J. (2021). Variation in distress among women with infertility: Evidence from a population-based sample. *Human Reproduction Open*, 2021(2), hoab016. <https://doi.org/10.1093/hropen/hoab016>
- Karaköse, S., & Aydin, Y. (2021). The effect of infertility on marital satisfaction: A systematic review. *International Journal of Nursing Practice*, 27(4), e12972. <https://doi.org/10.1111/ijn.12972>
- Karimi, F. Z., Taghipour, A., Latifnejad Roudsari, R., & Kimiaee, S. A. (2021). Exploring coping strategies of infertile women through psychological interventions: A qualitative study. *BMC Women's Health*, 21(1), 344. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01472-3>
- Lakatos, E., Szigeti, J. F., & Ujma, P. P. (2021). Mindfulness-based interventions in infertility treatment: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 12, 643847. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.643847>
- Malik, S. H., & Coulson, N. S. (2020). Coping with infertility online: An examination of self-help mechanisms in online infertility support groups. *Patient Education and Counseling*, 103(5), 947–952. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.12.010>
- Pasch, L. A., & Sullivan, K. T. (2021). Psychological distress in couples facing infertility: Understanding and addressing communication issues. *Journal of Family Psychology*, 35(2), 273–283. <https://doi.org/10.1037/fam0000790>

- Rooney, K. L., & Domar, A. D. (2020). The relationship between stress and infertility. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 22(1), 41–47. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.1/klrooney>
- Singh, N., & Malik, N. (2021). The efficacy of a multidisciplinary approach in infertility treatment: A review. *International Journal of Reproductive Biomedicine*, 19(7), 607–616. <https://doi.org/10.18502/ijrm.v19i7.9474>
- Teixeira, R. J., & Pereira, M. G. (2020). Factors contributing to psychological adjustment in infertility: A literature review. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 38(5), 519–535. <https://doi.org/10.1080/02646838.2019.1688010>
- Taylor, B., de Jonge, D. M., & O'Halloran, P. (2020). Integrating psychological care in fertility treatment: Barriers, facilitators, and implications. *Reproductive Biomedicine & Society Online*, 11, 86–93. <https://doi.org/10.1016/j.rbms.2020.06.004>
- World Health Organization (WHO). (2022). *Infertility: A global public health issue*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030787>

Profil Penulis



Dewi Ari Sasanti, S.ST., M.Kes

Lahir di Ngawi , 17 Desember 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang sarjana pada Program Studi Kebidanan STIKes Insan Cendekia Medika. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 sebagai Laboran di Laboratorium saat menempuh pendidikan sarjana dan 2010 menjadi dosen program studi kebidanan di STiKes Insan Cendekia Medika, 2012 pindah kota dan menjadi dosen di Politeknik Borneo Medistra hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Borneo Medistra mengampu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, Asuhan Kebidanan Kehamilan dan Anatomi Fisiologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi penelitian, pengabdian masyarakat, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewiarisasanti@gmail.com
Motto: "Jika tidak di mulai, maka tidak pernah selesai"



Dita Humaeroh, S.SiT., Bdn., MKM., C.Herb

Lahir di karawang, 20 November 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Kebidanan, STIKES Kharisma Karawang lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan DIV Bidan Pendidik di STIKES Mitra RIA Husada Jakarta, lulus tahun pada tahun 2014. Melanjutkan ke jenjang Pendidikan S2 (mesgiter) Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhamadiyah Jakarta lulus tahun 2017, dan menempuh pendidikan profesi Bidan tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali menjadi Bidan di salah satu Klinik Bersalin di Bekasi, dan saat ini penulis bekerja di Politeknik Bhakti Asih Purwakarta dari Tahun 2017-Sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ditahumaeroh@polbap.ac.id



Bd. Iryani Yuni Yastutik., SST., M.Kes

Lahir di Pamekasan, 12 Juni 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S2 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Program studi Promosi Kesehatan dengan Konsentrasi Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS. Universitas Diponegoro Semarang tahun 2014. Kemudian saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Diponegoro Semarang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Akademi Kebidanan Dukawati Lawang Kabupaten Malang. Saat ini penulis bekerja di STIKes Husada Jombang di prodi s1 dan Profesi Kebidanan dengan mengampu mata kuliah maSalah dan gangguan pada sistem reproduksi dan mata kuliah JIV_AIDS Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iryaniyuni12@gmail.com



Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes.

Lahir di Kupang, 10 November 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan Pendidik pada Program Studi Kedokteran, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2006. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 bekerja Sebagai Bidan PTT di Kab. Kupang Propinsi NTT. Tahun 2001-sekarang Sebagai Dosen pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Saat ini penulis, mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Gender dan PUG, Kesehatan Reproduksi dan KB, Askeb Komunitas dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: 10niningkosad11@gmail.com



Susanti, SST., Bdn., M.Kes

Lahir di Tarakan, 10 Februari 1984 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Universitas Padjadjaran lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 sebagai bidan pelaksana di Puskesmas Juata Laut di Kota Tarakan. Staf Kesga di Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2008. Saat ini penulis bekerja di Universitas Borneo Tarakan sejak tahun 2009 sampai sekarang di prodi D-III Kebidanan dengan mengampu mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, KB dan Pelayanan Kontrasepsi serta kebidanan komunitas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: shantie.alfarisi@gmail.com

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul **“Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Pasangan Usia Subur”** merupakan panduan ilmiah sekaligus praktis yang dirancang untuk meningkatkan literasi kesehatan reproduksi pada pasangan usia subur (PUS), baik dalam konteks promotif, preventif, maupun suportif. Buku ini menyatukan pendekatan klinis, edukatif, psikologis, dan teknologi digital dalam membangun kesadaran serta kapasitas pasangan dalam mengelola kesehatan reproduksinya secara optimal.

Bab pertama membahas edukasi tentang penggunaan kontrasepsi yang aman, mencakup pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, gaya hidup, dan nilai-nilai budaya pasangan. Di bab kedua, disajikan peran penting bidan sebagai penyedia layanan kesehatan reproduksi yang kompeten dan empatik, khususnya dalam proses konseling yang berorientasi pada kebutuhan dan keputusan pasien.

Bab ketiga menyoroti pemanfaatan teknologi digital—termasuk aplikasi mobile—yang dapat membantu pasangan dalam merencanakan kehamilan, memantau masa subur, dan memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Selanjutnya, bab keempat membahas strategi berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu reproduksi sehat, termasuk peran tokoh masyarakat dan pendekatan berbasis budaya lokal.

Bab terakhir secara khusus membahas dukungan psikologis bagi pasangan yang menghadapi tantangan kesuburan, seperti infertilitas. Dalam bab ini, pembaca akan menemukan pendekatan empatik dalam mendampingi pasangan secara emosional, sekaligus mengenali kebutuhan psikososial yang sering kali tersembunyi dalam proses diagnosis dan terapi kesuburan.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa kebidanan dan keperawatan, bidan praktisi, konselor kesehatan reproduksi, serta masyarakat luas yang peduli pada perencanaan keluarga dan kualitas hidup reproduktif. Dengan pendekatan yang integratif, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan manusiawi dan teknologi dalam mendukung pasangan usia subur menjalani kehidupan reproduksi yang sehat, aman, dan bermakna.

Buku Referensi yang berjudul “Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Pasangan Usia Subur” merupakan panduan ilmiah sekaligus praktis yang dirancang untuk meningkatkan literasi kesehatan reproduksi pada pasangan usia subur (PUS), baik dalam konteks promotif, preventif, maupun suportif. Buku ini menyatukan pendekatan klinis, edukatif, psikologis, dan teknologi digital dalam membangun kesadaran serta kapasitas pasangan dalam mengelola kesehatan reproduksinya secara optimal.

Bab pertama membahas edukasi tentang penggunaan kontrasepsi yang aman, mencakup pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, gaya hidup, dan nilai-nilai budaya pasangan. Di bab kedua, disajikan peran penting bidan sebagai penyedia layanan kesehatan reproduksi yang kompeten dan empatik, khususnya dalam proses konseling yang berorientasi pada kebutuhan dan keputusan pasien.

Bab ketiga menyoroti pemanfaatan teknologi digital termasuk aplikasi mobile yang dapat membantu pasangan dalam merencanakan kehamilan, memantau masa subur, dan memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.

Selanjutnya, bab keempat membahas strategi berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu reproduksi sehat, termasuk peran tokoh masyarakat dan pendekatan berbasis budaya lokal.

Bab terakhir secara khusus membahas dukungan psikologis bagi pasangan yang menghadapi tantangan kesuburan, seperti infertilitas. Dalam bab ini, pembaca akan menemukan pendekatan empatik dalam mendampingi pasangan secara emosional, sekaligus mengenali kebutuhan psikososial yang sering kali tersembunyi dalam proses diagnosis dan terapi kesuburan.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa kebidanan dan keperawatan, bidan praktisi, konselor kesehatan reproduksi, serta masyarakat luas yang peduli pada perencanaan keluarga dan kualitas hidup reproduktif. Dengan pendekatan yang integratif, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan manusiawi dan teknologi dalam mendukung pasangan usia subur menjalani kehidupan reproduksi yang sehat, aman, dan bermakna.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

